

**INTEGRAÇÃO DO DESIGN E DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL EM PROCESSOS PARAMÉTRICOS
PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRÓTESES DE
MEMBROS SUPERIORES EM IMPRESSÃO 3D.**

Pedro Miguel Candeias da Silva

Orientador

Demétrio Ferreira Matos

Projeto apresentado
ao Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
para obtenção do Grau de Mestre em Design e Desenvolvimento de
Produto

Este trabalho não inclui as críticas e sugestões feitas pelo júri.

julho, 2026

(FOLHA EM BRANCO)

**INTEGRAÇÃO DO DESIGN E DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL EM PROCESSOS PARAMÉTRICOS
PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRÓTESES DE
MEMBROS SUPERIORES EM IMPRESSÃO 3D.**

Pedro Miguel Candeias da Silva

Orientador

Demétrio Ferreira Matos

Projeto apresentado
ao Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
para obtenção do Grau de Mestre em Design e Desenvolvimento de
Produto

Este trabalho não inclui as críticas e sugestões feitas pelo Júri.

julho, 2026

DECLARAÇÃO

Nome: Pedro Miguel Candeias da Silva

Endereço eletrónico:

Título do Projeto: INTEGRAÇÃO DO DESIGN E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM PROCESSOS PARAMÉTRICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRÓTESES DE MEMBROS SUPERIORES EM IMPRESSÃO 3D.

Subtítulo do Projeto:

Orientador: Demétrio Ferreira Matos

Coorientador:

Ano de conclusão: julho, 2026

Designação do Curso de Mestrado: Mestrado em Design e Desenvolvimento de Produto

Nos exemplares das Dissertações /Projetos/ Relatórios de Estágio de mestrado ou de outros trabalhos entregues para prestação de Provas Públicas, e dos quais é obrigatoriamente enviado exemplares para depósito legal, deve constar uma das seguintes declarações:

☒ É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO INTEGRAL DESTA DISSERTAÇÃO/TRABALHO APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE;

☐ É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DISSERTAÇÃO/TRABALHO (indicar, caso tal seja necessário, nº máximo de páginas, ilustrações, gráficos, etc.), APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE;

☐ DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO É PERMITIDA A REPRODUÇÃO DE QUALQUER PARTE DESTA DISSERTAÇÃO/TRABALHO

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, 13/07/2026

Assinatura: _____

INTEGRAÇÃO DO DESIGN E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM PROCESSOS PARAMÉTRICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRÓTESES DE MEMBROS SUPERIORES EM IMPRESSÃO 3D.

RESUMO

A personalização de próteses de membros superiores continua condicionada por custos elevados, competências técnicas especializadas e dificuldades na tradução de dados antropométricos para geometrias configuráveis e fabricáveis. Esta dissertação investiga de que modo o design industrial, articulado com modelação paramétrica e inteligência artificial, pode apoiar a configuração preliminar de modelos de mão protésica destinados à impressão 3D. A investigação adopta uma abordagem de Research Through Design, combinando revisão crítica da literatura, análise de soluções open source, estruturação de uma base local de dados antropométricos, desenvolvimento de modelos em OpenSCAD, integração numa plataforma web e avaliação técnica por cenários simulados, exportação de geometrias e prototipagem física. O protótipo de investigação converte descrições e medidas em sugestões paramétricas, apresenta a geometria no navegador e exporta ficheiros STL e 3MF. A avaliação incidiu sobre a conformidade das sugestões com o esquema de parâmetros, a propagação dos valores para a geometria, o funcionamento dos principais módulos da plataforma, a preparação dos ficheiros e a produção de peças físicas. Os ensaios permitiram detectar e corrigir problemas de correspondência de perfis, lateralidade e escala em modelos específicos. Os resultados sustentam a coerência técnica do fluxo nas condições documentadas e mostram limites próprios de cada modelo. Conforto, usabilidade com participantes, eficácia funcional, segurança, durabilidade e adequação clínica ficaram fora da avaliação. O contributo principal reside num processo de investigação projectual que articula dados antropométricos, regras geométricas, apoio de IA, execução no navegador e verificação material, mantendo a decisão final sob supervisão humana.

Palavras-chave: design industrial; próteses de membro superior; design paramétrico; inteligência artificial; impressão 3D; dados antropométricos; fabrico digital.

INTEGRATION OF DESIGN AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PARAMETRIC PROCESSES FOR THE DEVELOPMENT OF 3D- PRINTED UPPER-LIMB PROSTHESES

ABSTRACT

The personalisation of upper-limb prostheses remains constrained by high costs, specialised technical skills, and difficulties in translating anthropometric data into configurable and manufacturable geometries. This dissertation investigates how industrial design, combined with parametric modelling and artificial intelligence, can support the preliminary configuration of prosthetic hand models for 3D printing. The research follows a Research Through Design approach, combining a critical literature review, analysis of open-source solutions, the structuring of a local anthropometric database, development of OpenSCAD models, integration into a web platform, and technical evaluation through simulated scenarios, geometry export, and physical prototyping. The research prototype converts descriptions and measurements into parametric suggestions, displays geometry in the browser, and exports STL and 3MF files. Evaluation covered suggestion compliance with the parameter schema, value propagation into geometry, operation of the main platform modules, file preparation, and production of physical parts. The tests identified and supported corrections to profile matching, laterality, and model-specific scaling. The results support the technical coherence of the workflow under the documented conditions and reveal constraints specific to each model. Comfort, usability with participants, functional effectiveness, safety, durability, and clinical suitability were outside the evaluation scope. The main contribution is a design-research process that connects anthropometric data, geometric rules, AI support, browser execution, and material verification while keeping final decisions under human supervision.

Keywords: industrial design; upper-limb prostheses; parametric design; artificial intelligence; 3D printing; anthropometric data; digital fabrication.

LISTA DE ABREVIATURAS E/OU SIGLAS

2D – Bidimensional.

3D – Tridimensional.

3DP – 3D Printing; impressão 3D.

3MF – 3D Manufacturing Format; formato de ficheiro para fabrico aditivo.

AMS – Automatic Material System; sistema automático de alimentação de filamento usado em impressoras Bambu Lab.

ANSUR – Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel; inquérito antropométrico do Exército dos Estados Unidos.

API – Application Programming Interface; interface de programação de aplicações.

ASTM – American Society for Testing and Materials; organismo internacional de normalização.

CAD – Computer-Aided Design; desenho ou projecto assistido por computador.

CAM – Computer-Aided Manufacturing; fabrico assistido por computador.

CE – Conformité Européenne; marcação europeia de conformidade.

CSG – Constructive Solid Geometry; geometria sólida construtiva.

CSV – Comma-Separated Values; formato de valores separados por vírgulas.

CT – Computed Tomography; tomografia computadorizada.

DfAM – Design for Additive Manufacturing; design para fabrico aditivo.

DINED – Delft Institute of Ergonomics and Design; base de dados antropométrica da TU Delft.

DOI – Digital Object Identifier; identificador digital de objecto.

EMG – Eletromiografia; registo da atividade elétrica muscular.

EU – European Union; União Europeia.

EUA – Estados Unidos da América.

FA/FdA – Fabrico aditivo.

FDA – Food and Drug Administration; agência reguladora dos Estados Unidos para alimentos, medicamentos e dispositivos médicos.

FDM – Fused Deposition Modelling; modelação por deposição fundida.

FEA – Finite Element Analysis; análise por elementos finitos.

FEM – Finite Element Method; método dos elementos finitos.

FFF – Fused Filament Fabrication; fabrico por filamento fundido.

FFD – Free-Form Deformation; deformação de forma livre.

GB/T – Norma nacional recomendada chinesa.

HB – Hand Breadth; largura da mão.

HCD – Human-Centred Design; design centrado no humano.

HGD – Hand Grip Diameter; diâmetro de apreensão da mão.

HL – Hand Length; comprimento da mão.

HTML – HyperText Markup Language; linguagem de marcação de hipertexto.

IA – Inteligência Artificial.

ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health; Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde.

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers; associação técnico-científica e entidade editorial/de normalização.

ISO – International Organization for Standardization; Organização Internacional de Normalização.

JSON – JavaScript Object Notation; formato leve de intercâmbio de dados.

JWT – JSON Web Token; token web em formato JSON para autenticação e autorização.

LL – Lower Limb; membro inferior.

MCP – Metacarpophalangeal; articulação metacarpofalângica.

MDR – Medical Device Regulation; Regulamento Europeu dos Dispositivos Médicos.

MPT – Matching Person and Technology; modelo de adequação entre pessoa e tecnologia.

MRI – Magnetic Resonance Imaging; ressonância magnética.

PCA – Principal Component Analysis; análise de componentes principais.

PDF – Portable Document Format; formato portátil de documento.

PIP – Proximal Interphalangeal; articulação interfalângica proximal.

PL – Palm Length; comprimento da palma.

PRISMA – Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses; diretrizes para reporte de revisões sistemáticas e meta-análises.

RTD – Research Through Design; investigação através do design.

SD – Standard Deviation; desvio-padrão.

SLA – Stereolithography; estereolitografia.

SLS – Selective Laser Sintering; sinterização seletiva a laser.

SSM – Statistical Shape Modelling; modelação estatística da forma.

SQLite – Motor leve de base de dados relacional baseado em SQL, autónomo e incorporável na aplicação.

STL – Stereolithography; formato de ficheiro de malha tridimensional usado em impressão 3D.

TC – Technical Committee; comité técnico.

TRL – Technology Readiness Level; nível de prontidão tecnológica.

UCD – User-Centred Design; design centrado no utilizador.

UI – User Interface; interface do utilizador.

UL – Upper Limb; membro superior.

UX – User Experience; experiência do utilizador.

WASM – WebAssembly; tecnologia para execução de código compilado no navegador.

XAI – Explainable Artificial Intelligence; inteligência artificial explicável.

LISTA DE TABELAS

TABELA 2.1 — PAPÉIS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.....	9
TABELA 2.2 — ELEMENTOS CENTRAIS NA CONFIGURAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM SISTEMAS CONFIGURÁVEIS.....	27
TABELA 3.1 — CICLOS DE RESEARCH THROUGH DESIGN DOCUMENTADOS NO DESENVOLVIMENTO.....	34
TABELA 3.2 — CORRESPONDÊNCIA ENTRE PERGUNTAS, ACTIVIDADES, EVIDÊNCIA E LIMITES.....	36
TABELA 4.1 — PRINCIPAIS PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS DA MÃO E DO MEMBRO SUPERIOR RELEVANTES PARA MODELAÇÃO PARAMÉTRICA.....	42
TABELA 4.2 — CONJUNTOS MÍNIMOS DE PARÂMETROS POR NÍVEL DE AMPUTAÇÃO.....	43
TABELA 4.3 — MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS E SUAS CARACTERÍSTICAS.....	45
TABELA 4.4 — FONTES INTEGRADAS NA BASE LOCAL DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS.....	46
TABELA 4.5 — ESTRUTURA HIERÁRQUICA DOS PARÂMETROS NO MODELO PARAMÉTRICO.....	50
TABELA 4.6 — MAPEAMENTO ENTRE PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS E ELEMENTOS DO MODELO.....	52
TABELA 4.7 — ESTRUTURA TÉCNICA EM CAMADAS DE UM MODELO PARAMÉTRICO EM OPENSAD PARA PRÓTESES PERSONALIZADAS.....	54
TABELA 4.8 — RELAÇÕES PARAMÉTRICAS DOS MODELOS AVALIADOS.....	56
TABELA 5.1 — FLUXO DE DADOS E RESPONSABILIDADES DA PLATAFORMA.....	63
TABELA 5.2 — ESTADO DOS MODELOS NO FECHO DO ESTUDO.....	71
TABELA 6.1 — ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MODELOS DE IA E DO CONTRATO DE SUGESTÃO PARAMÉTRICA.....	77
TABELA 6.2 — DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS ENTRE REGRAS, IA E SUPERVISÃO HUMANA.....	79
TABELA 8.1 — EVIDÊNCIA TÉCNICA DO FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA.....	88
TABELA 8.2 — PROJECTOS DE PREPARAÇÃO PARA IMPRESSÃO ARQUIVADOS.....	89
TABELA 8.3 — INSPECÇÃO COMPUTACIONAL DE MALHAS NA CONFIGURAÇÃO INFANTIL.....	90
TABELA 8.4 — ENTRADAS UTILIZADAS NOS CENÁRIOS DE AVALIAÇÃO DA IA.....	94
TABELA 8.5 — SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DAS SUGESTÕES DE IA.....	96
TABELA 8.6 — MODELOS E MECANISMOS DE ESCALA AVALIADOS.....	97
TABELA 8.7 — RÁCIO ADIMENSIONAL DA MAIOR DIMENSÃO DA PALMA EXPORTADA FACE AO VALOR DE REFERÊNCIA.....	98

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1.1 — EXEMPLOS DE PRÓTESES E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS AO FABRICO ADITIVO EM CONTEXTO PROTÉSICO.....	1
FIGURA 2.1 — EXEMPLOS DE PRÓTESES DE MEMBRO SUPERIOR IMPRESSAS EM 3D, ILUSTRANDO DIVERSIDADE TIPOLOGICA E CONSTRUTIVA.....	6
FIGURA 2.2 — UTILIZAÇÃO, REJEIÇÃO PRIMÁRIA E REJEIÇÃO SECUNDÁRIA DE PRÓTESES DO MEMBRO SUPERIOR ADQUIRIDAS.....	8
FIGURA 2.3 — FLUXO DIGITAL ENTRE AQUISIÇÃO, CAD/CAM E FABRICO ADITIVO EM PRÓTESES E ORTÓTESES.....	13
FIGURA 2.4 — EXEMPLO DE CONFIGURADOR DIGITAL PARA PERSONALIZAÇÃO DE UMA PRÓTESE IMPRESSA EM 3D.....	15
FIGURA 2.5 — MARCOS ANATÔMICOS E MEDIDAS DE REFERÊNCIA DA MÃO PARA FINS DE PERSONALIZAÇÃO.....	19
FIGURA 2.6 — ENQUADRAMENTO DE UM FLUXO DE CAD APOIADO POR IA PARA DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO.....	22
FIGURA 2.7 — MODELO DE PROCESSO PARA CONFIGURAR PARTICIPAÇÃO EM ECOSISTEMAS DE INOVAÇÃO E COCRIAÇÃO.....	26
FIGURA 2.8 — DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS POR NÍVEL DE PRONTIDÃO TECNOLÓGICA (TRL) E CATEGORIA DE APLICAÇÃO. O GRÁFICO DISTINGUE ESTUDOS SOBRE PRÓTESES EM GERAL, PRÓTESES DE MEMBRO INFERIOR PRODUZIDAS POR IMPRESSÃO 3D (LL 3DP), PRÓTESES DE MEMBRO INFERIOR DESENVOLVIDAS COM RECURSO A CAD/CAM (LL CAD/CAM), OUTRAS ABORDAGENS APLICADAS AO MEMBRO INFERIOR (LL OTHER), PRÓTESES DE MEMBRO SUPERIOR PRODUZIDAS POR IMPRESSÃO 3D (UL 3DP) E OUTROS CASOS NÃO ENQUADRADOS NAS CATEGORIAS ANTERIORES.....	30
FIGURA 3.1 — PROCESSO INTERDISCIPLINAR DE DESENVOLVIMENTO DE UMA PRÓTESE DE MEMBRO SUPERIOR IMPRESSA EM 3D.....	35
FIGURA 3.2 — EXEMPLO DE RECOLHA DIMENSIONAL PARA AJUSTE DE PRÓTESE IMPRESSA EM 3D.....	38
FIGURA 4.1 — PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS UTILIZADOS NA MODELAÇÃO PARAMÉTRICA DE DEDOS PROTÉSICOS.....	42
FIGURA 4.2 — COMPARAÇÃO ENTRE O ESCALONAMENTO UNIFORME E A MODELAÇÃO PARAMÉTRICA DE DEDO PROTÉSICO.....	44
FIGURA 4.3 — RELAÇÃO ENTRE MODELO PARAMÉTRICO DIGITAL, PROTOTIPAGEM E VERIFICAÇÃO DE UM DEDO PROTÉSICO.....	54
FIGURA 5.1 — FLUXO GERAL DE PRODUÇÃO PERSONALIZADA DE PRÓTESES A PARTIR DE PLATAFORMA WEB – HAND FAB.....	61
FIGURA 5.2 — ARQUITECTURA E SEQUÊNCIA PRINCIPAL ENTRE INTERFACE, CONFIGURAÇÃO, WEB WORKER, OPENS CAD EM WEBASSEMBLY, VISUALIZAÇÃO, SERVIÇOS DO SERVIDOR, IA EXTERNA E FABRICO.....	64
FIGURA 5.3 — FLUXO GERAL DE PRODUÇÃO PERSONALIZADA DE PRÓTESES A PARTIR DE DIGITALIZAÇÃO, CAD ADAPTATIVO E FABRICO ADITIVO.....	65
FIGURA 5.4 — FERRAMENTA PARAMÉTRICA PARA CONFIGURAÇÃO DE AJUDAS TÉCNICAS COM VARIAÇÃO DE DIMENSÕES, MATERIAIS E PESO.....	69
FIGURA 6.1 — RELAÇÃO ENTRE DESAFIOS DE EXPLICABILIDADE E PRINCÍPIOS DE IA RESPONSÁVEL.....	81

FIGURA 7.1 — EXEMPLO PUBLICADO DE TESTE DE UMA PRÓTESE IMPRESSA EM 3D COM UM UTILIZADOR; ESTA ACTIVIDADE NÃO INTEGROU A AVALIAÇÃO DA PRESENTE DISSERTAÇÃO.....	85
FIGURA 8.1 — SEGMENTOS DO FLEXY BEAST PRODUZIDOS E ASSENTES NA PLATAFORMA DA BAMBU LAB A1.....	93
FIGURA 8.2 — SÉRIE FÍSICA DE SEGMENTOS FLEXY BEAST IDENTIFICADOS PELAS IDADES SIMULADAS DE 8, 15, 28 E 70 ANOS. A IMAGEM PERMITE COMPARAR ESCALA E CONCLUSÃO DAS PEÇAS, SEM CONSTITUIR MEDIÇÃO DIMENSIONAL OU ENSAIO MECÂNICO.....	93
FIGURA 8.3 — SÉRIE FÍSICA DE SEGMENTOS PARAGLIDER HAND IDENTIFICADOS PELAS IDADES SIMULADAS DE 8, 15, 28 E 70 ANOS. A IMAGEM DOCUMENTA A TRANSIÇÃO PARA PEÇAS FÍSICAS E NÃO DEMONSTRA AJUSTE ANATÓMICO.....	93
FIGURA 8.4 — TAREFAS FUNCIONAIS USADAS EM AVALIAÇÃO DE PRÓTESE PERSONALIZADA DE MEMBRO SUPERIOR.....	94

ÍNDICE

CAPÍTULO 1 — INTRODUÇÃO.....	1
1.1 ENQUADRAMENTO GERAL, CONTEXTO E MOTIVAÇÃO.....	1
1.2 PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO.....	2
1.3 OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO.....	2
1.3.1 OBJECTIVO GERAL.....	2
1.3.2 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS.....	2
1.4 ABORDAGEM METODOLÓGICA GERAL.....	3
1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO.....	3
CAPÍTULO 2 — ENQUADRAMENTO TEÓRICO E ESTADO DA ARTE.....	4
2.1 PRÓTESE DE MEMBRO SUPERIOR E DISPOSITIVOS MÉDICOS.....	4
TIPOLOGIAS DE PRÓTESES DE MEMBRO SUPERIOR.....	4
PRÓTESES MECÂNICAS ACCIONADAS PELO CORPO (BODY-POWERED).....	4
PRÓTESES MIOELÉCTRICAS.....	5
SISTEMAS HÍBRIDOS.....	5
CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS E FUNCIONAIS.....	6
MEDIÇÃO DE RESULTADOS E ABANDONO PROTÉSICO.....	7
ENQUADRAMENTO REGULATÓRIO ENQUANTO DISPOSITIVO MÉDICO.....	8
2.2 DESIGN INDUSTRIAL, DESIGN INCLUSIVO E DESIGN CENTRADO NO UTILIZADOR.....	9
DESIGN INDUSTRIAL EM DISPOSITIVOS MÉDICOS.....	9
DESIGN INCLUSIVO E DESIGN UNIVERSAL.....	10
DESIGN CENTRADO NO UTILIZADOR E DESIGN CENTRADO NO HUMANO.....	10
DESIGN PARTICIPATIVO E CO-DESIGN.....	11
METODOLOGIAS, INSTRUMENTOS E AVALIAÇÃO.....	11
DESAFIOS E LACUNAS.....	12
2.3 FABRICO ADITIVO E PARAMETRIZAÇÃO NO DESIGN DE PRODUTO.....	12
MODELAÇÃO PARAMÉTRICA E ESPAÇOS DE VARIAÇÃO.....	13
INTEGRAÇÃO COM FABRICO ADITIVO E DESIGN FOR ADDITIVE MANUFACTURING.....	14
CONFIGURADORES E COCRIAÇÃO DIGITAL.....	14
OTIMIZAÇÃO, GERAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.....	15
IMPLICAÇÕES PARA O DESIGN INDUSTRIAL.....	16
2.4 PRÓTESES OPEN SOURCE DE MEMBRO SUPERIOR PASSÍVEIS DE IMPRESSÃO 3D.....	16
2.5 ANTROPOMETRIA APLICADA AO DESIGN PROTÉSICO.....	18
DA DIMENSÃO LINEAR À “FORMA” COMO DADO DE PROJECTO.....	18
MÉTODOS DE RECOLHA ANTROPOMÉTRICA EM PRÓTESES E TECNOLOGIAS DE APOIO.....	19
INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS NO PROJECTO.....	20
EVIDÊNCIA POR TIPO DE DISPOSITIVO.....	20
LIMITAÇÕES, LACUNAS E RECOMENDAÇÕES.....	21
ESTRUTURAÇÃO DE DADOS.....	21
2.6 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PROCESSO DE DESIGN.....	22
O QUE É A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	22
COMO FUNCIONA: DADOS, TREINO, INFERÊNCIA E GERAÇÃO.....	23
FORMAS DE IA MAIS RELEVANTES PARA O DESIGN.....	23
IA AO LONGO DO PROCESSO DE DESIGN.....	24
PAPEL DO DESIGNER, RISCOS E NECESSIDADE DE SUPERVISÃO HUMANA.....	24

2.7 PLATAFORMAS DIGITAIS E SISTEMAS CONFIGURÁVEIS.....	25
FUNDAMENTOS CONCEPTUAIS: TOOLKITS, META-DESIGN E END-USER DEVELOPMENT.....	26
MECANISMOS DE PERSONALIZAÇÃO: MODULARIDADE, PARAMETRIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO INDIVIDUALIZADA.....	27
FLUXOS PARTICIPATIVOS E INFRA-ESTRUTURAS REMOTAS.....	28
APLICAÇÕES EM SAÚDE, REABILITAÇÃO E PRÓTESES.....	28
LIMITAÇÕES E LACUNAS: SUSTENTABILIDADE, ADOÇÃO E EQUILÍBRIO ENTRE NORMALIZAÇÃO E IMPROVISO.....	29
2.8 ANÁLISE CRÍTICA DO ESTADO DA ARTE E LACUNAS IDENTIFICADAS.....	29
LACUNA 1 — VALIDAÇÃO EMPÍRICA LIMITADA E FRACA TRANSPOSIÇÃO PARA CONTEXTOS REAIS DE UTILIZAÇÃO.....	31
LACUNA 2 — DESALINHAMENTO ENTRE NECESSIDADES IDENTIFICADAS, MÉTRICAS OBJETIVAS, E QUALIDADE DE VIDA.....	31
LACUNA 3 — PERSISTÊNCIA DE PROBLEMAS NA INTERFACE CORPO-PRÓTESE E NO AJUSTE INDIVIDUALIZADO.....	31
LACUNA 4 — EVOLUÇÃO LIMITADA DAS ESTRATÉGIAS DE CONTROLO E DA INTERACÇÃO UTILIZADOR-PRÓTESE.....	32
LACUNA 5 — ACESSO, CUSTO, MANUTENÇÃO E INEQUIDADES SISTÉMICAS.....	32
LACUNA 6 — ENVOLVIMENTO DO UTILIZADOR E REGISTO METODOLÓGICO INSUFICIENTE	32
IMPLICAÇÕES PARA ESTA INVESTIGAÇÃO.....	33
CAPÍTULO 3 — METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO.....	34
3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO E ABORDAGEM RESEARCH THROUGH DESIGN.....	34
3.2 O DESIGN INDUSTRIAL COMO PRÁTICA INVESTIGATIVA.....	35
3.3 ESTRUTURA METODOLÓGICA DO PROJECTO.....	36
3.4 MÉTODOS DE RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS.....	37
3.5 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS.....	38
CAPÍTULO 4 — DESENVOLVIMENTO DO MODELO PARAMÉTRICO.....	40
4.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE DESIGN E REQUISITOS.....	40
4.2 PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS E ESTRUTURA DO MODELO.....	41
CONJUNTOS MÍNIMOS DE PARÂMETROS POR NÍVEL DE AMPUTAÇÃO.....	43
LIMITAÇÕES DO REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL.....	44
MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS.....	44
BASES DE DADOS ANTROPOMÉTRICAS, EXTRACÇÃO E NORMALIZAÇÃO.....	45
CORRESPONDÊNCIA ENTRE PERFIL POPULACIONAL E PARÂMETROS DO MODELO.....	49
ESTRUTURA PARAMÉTRICA E MAPEAMENTO DE PARÂMETROS.....	50
OPENSCAD: ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DA ESCOLHA.....	51
4.3 MODELAÇÃO PARAMÉTRICA EM OPENSCAD.....	53
4.3.1 ESTRUTURA TÉCNICA, PARÂMETROS E RESTRIÇÕES.....	54
4.3.2 ANÁLISE CRÍTICA DA ABORDAGEM.....	55
4.3.3 RELAÇÕES IMPLEMENTADAS NOS MODELOS AVALIADOS.....	56
4.4 ITERAÇÕES, REFINAMENTO E DISCUSSÃO INTERMÉDIA.....	58
CAPÍTULO 5 — PLATAFORMA WEB E INTEGRAÇÃO DIGITAL.....	61
5.1 ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL E PERFIS DE UTILIZADOR.....	61
5.2 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA.....	62

5.3 INTEGRAÇÃO OPENS CAD VIA WEBASSEMBLY (WASM).....	66
5.4 ESTRUTURA FUNCIONAL DA PLATAFORMA.....	68
5.5 GESTÃO DE PARÂMETROS, VERSÕES E EXPANSÃO.....	72
CAPÍTULO 6 — INTEGRAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	75
6.1 PAPEL DA IA NO SISTEMA PROPOSTO.....	75
6.2 IA NA PARAMETRIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E APOIO À DECISÃO.....	76
6.3 AVALIAÇÃO DAS SUGESTÕES PARAMÉTRICAS APOIADAS POR IA.....	78
6.4 AJUSTE, VERIFICAÇÃO E LIMITAÇÕES ÉTICAS E TÉCNICAS.....	80
CAPÍTULO 7 — PRINCÍPIOS DE INTERFACE E DECISÕES DE INTERACÇÃO.....	82
7.1 ESTRATÉGIA DE INTERACÇÃO E DECISÕES DE UI/UX.....	82
7.2 PAPÉIS PREVISTOS E DISTRIBUIÇÃO DE DECISÕES.....	83
7.3 MEDIAÇÃO DO PROCESSO DE DESIGN E REFLEXÃO CRÍTICA.....	85
CAPÍTULO 8 — AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO.....	88
8.1 ESTRATÉGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO.....	88
8.1.1 VERIFICAÇÃO TÉCNICA DA PLATAFORMA.....	88
8.1.2 PREPARAÇÃO PARA IMPRESSÃO E PROTÓTIPOS FÍSICOS.....	89
8.2 AVALIAÇÃO DA COERÊNCIA DAS SUGESTÕES DE IA.....	94
8.3 VERIFICAÇÃO GEOMÉTRICA ENTRE MODELOS.....	97
8.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS FACE AOS OBJECTIVOS.....	99
CAPÍTULO 9 — CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS.....	100
9.1 RESPOSTA AO PROBLEMA E ÀS PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO.....	100
9.2 CONTRIBUTOS DA INVESTIGAÇÃO.....	100
9.3 LIMITAÇÕES.....	101
9.4 TRABALHO FUTURO.....	101
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	103
ANEXO A — METODOLOGIA DE EXTRACÇÃO E CODIFICAÇÃO DE DADOS	
ANTROPOMÉTRICOS DA MÃO.....	115
A.1 CONTEXTO E OBJECTIVO.....	115
A.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA.....	115
A.2.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA ORIENTADA.....	115
A.2.2 BASE ANSUR 1988.....	115
A.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE ESTUDOS.....	115
A.3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO.....	115
A.3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO.....	116
A.4 PROCESSO DE EXTRACÇÃO DE DADOS.....	116
A.4.1 LEITURA DOS PDFS E LOCALIZAÇÃO DAS TABELAS.....	116
A.4.2 IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES E CONVERSÃO.....	116
A.4.3 DECOMPOSIÇÃO EM LINHAS ATÓMICAS.....	117
A.4.4 REGISTO FIEL DO CONTEXTO DA MEDIÇÃO.....	117
A.5 DECISÕES POR ESTUDO.....	117
A.5.1 ANSUR 1988 — EUA, MILITARES (GORDON ET AL., 1989).....	117
A.5.2 TURQUIA — JOVENS ADULTOS (CHATZIOGLOU ET AL., 2024).....	118
A.5.3 MÉXICO — POPULAÇÃO GERAL (RODRÍGUEZ-VEGA & RODRÍGUEZ-VEGA, 2024).....	118

A.5.4 ÍNDIA — MULHERES TRABALHADORAS (NAG ET AL., 2003).....	118
A.5.5 PORTUGAL — TRABALHADORES INDUSTRIAIS (ANACLETO FILHO ET AL., 2023).....	118
A.5.6 NIGÉRIA — ATLETAS UNIVERSITÁRIOS (IBIWARI ET AL., 2025).....	118
A.5.7 JORDÂNIA — TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA (MISTARIHI, 2020).....	119
A.5.8 EUA — DEDO INDICADOR (LIM ET AL., 2018).....	119
A.5.9 ESTUDO EXCLUÍDO: MOREO (2016).....	119
A.5.10 EUA — MILITARES ANSUR II (GORDON ET AL., 2015).....	119
A.5.11 PAÍSES BAIXOS — DINED (TU DELFT, 1993–2004).....	120
A.5.12 CHINA — IDOSOS DE PEQUIM (HU ET AL., 2007).....	120
A.5.13 ESTUDO EXCLUÍDO: RECONSTRUÇÃO CORPORAL 3D A PARTIR DE FOTOGRAFIAS ORTOGONAIS.....	121
A.6 ESTRUTURA DO CSV E ESQUEMA DE DADOS.....	121
A.6.1 CAMPOS.....	121
A.6.2 FORMATO LONGO (LONG FORMAT).....	122
A.7 CONTROLO DE QUALIDADE DOS DADOS.....	122
A.7.1 MARCAÇÃO INLINE DE LIMITAÇÕES.....	122
A.7.2 VERIFICAÇÃO DE UNIDADES.....	122
A.7.3 LIGAÇÃO À FONTE.....	123
A.8 ESCRITA DO CÓDIGO DE GERAÇÃO.....	123
A.9 RESULTADO FINAL.....	123
A.10 COBERTURA GLOBAL DA BASE DE DADOS E LACUNAS.....	123
A.10.1 O QUE ESTÁ COBERTO.....	124
A.10.1.1 Cobertura geográfica.....	124
A.10.1.2 Cobertura etária.....	124
A.10.1.3 Cobertura estatística.....	125
A.10.2 ONDE A COBERTURA FALHA.....	125
A.10.2.1 Lacunas geográficas.....	125
A.10.2.2 Lacunas demográficas.....	126
A.10.2.3 Limitações qualitativas dos dados existentes.....	126
A.10.3 FRENTES IDENTIFICADAS PARA EXPANSÃO FUTURA.....	126
A.10.3.1 Prioridade alta.....	126
A.10.3.2 Prioridade média.....	127
A.10.3.3 Pertinência directa para o tema da tese.....	127

CAPÍTULO 1 — INTRODUÇÃO

1.1 ENQUADRAMENTO GERAL, CONTEXTO E MOTIVAÇÃO

A perda de membros superiores provoca impactos funcionais, sociais e simbólicos, com efeitos nas tarefas quotidianas, na participação e na identidade. Este contexto exige soluções que considerem desempenho mecânico, conforto, aceitação estética e viabilidade económica. Apesar dos avanços em dispositivos médicos e no fabrico aditivo, persistem obstáculos relacionados com o custo, a adaptação anatómica e a dependência de técnicos especializados para o ajuste e a manutenção das próteses.

Nos últimos anos, a impressão 3D e as plataformas open source ampliaram o acesso a dispositivos protésicos, especialmente em contextos economicamente desfavorecidos. Muitos desses modelos dependem de geometrias fixas, isto é, formas predefinidas sem adaptação automática, ou de ajustes manuais pouco padronizados. Esta condição dificulta a expansão dos modelos, a repetição documentada do procedimento e a integração consistente de dados antropométricos.

A Figura 1.1 introduz visualmente este contexto, mostrando como o fabrico aditivo tem sido associado a soluções protésicas abertas e adaptáveis. Esta leitura enquadra a motivação inicial do projecto: a impressão 3D amplia o campo de possibilidades, enquanto a configuração dimensional continua a exigir modelos ajustáveis, critérios explícitos e mediação projectual.

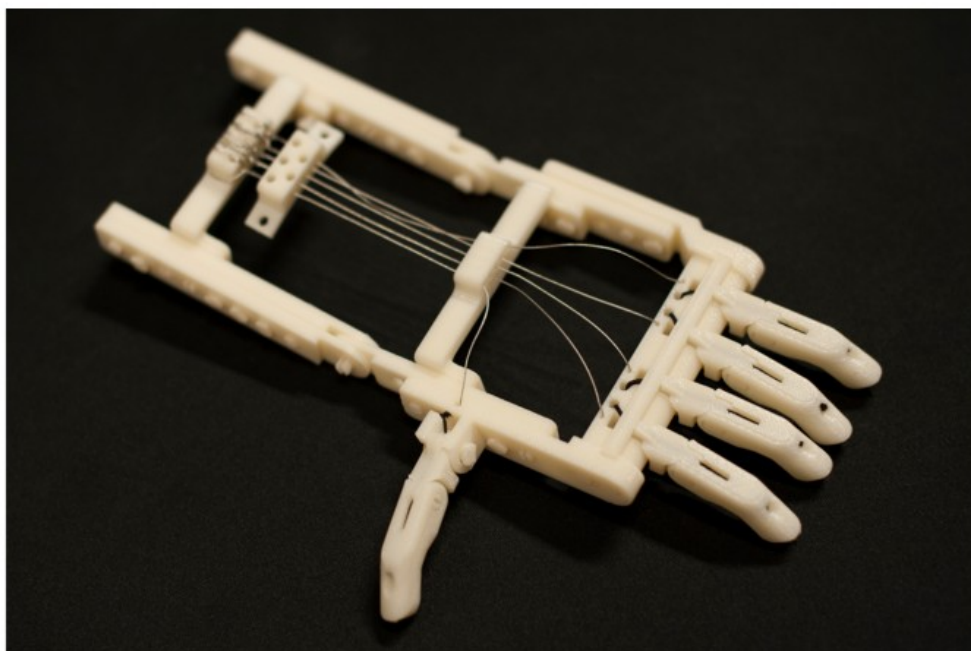


Figura 1.1 — Exemplos de próteses e dispositivos associados ao fabrico aditivo em contexto protésico.

Fonte original: Manero, A., Smith, P., Sparkman, J., Dombrowski, M., Courbin, D., Kester, A., Womack, I., & Chi, A. (2019). Implementation of 3D printing technology in the field of prosthetics: Past, present, and future. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16, 1641. <https://doi.org/10.3390/ijerph16091641>

Nesta dissertação, «prótese de membro superior» designa a categoria geral em que o estudo se inscreve; os artefactos implementados e avaliados são sobretudo modelos de mão protésica. «Modelo paramétrico» refere-se ao conjunto de variáveis, relações e restrições que gera a forma; «geometria exportada» designa a malha STL ou 3MF; «plataforma web» identifica a aplicação que coordena parâmetros, visualização, dados e sugestões; e «protótipo físico» corresponde à peça impressa. A parametrização é a definição dessas relações, a configuração é a escolha de valores e a personalização individual exige dados da própria pessoa. Os perfis populacionais usados neste estudo fornecem referências iniciais e não equivalem a uma adaptação anatómica individual.

O design industrial assume uma função de mediação entre tecnologia, decisões de projecto e experiência humana. A presente investigação examina essa mediação através de um protótipo técnico desenvolvido e discutido segundo uma abordagem de Research Through Design.

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO

Apesar da expansão do fabrico aditivo e da partilha de modelos abertos, persiste uma lacuna na articulação entre dados antropométricos, regras geométricas, configuração digital e preparação para fabrico. Muitos modelos de mão protésica continuam dependentes de escalonamento uniforme, ajustes manuais e conhecimento tácito, o que dificulta a identificação da origem dos valores e a avaliação do efeito de cada alteração na geometria.

O problema central consiste em compreender de que modo o design de produto pode articular modelação paramétrica, referências antropométricas, apoio de inteligência artificial e fabrico aditivo num fluxo técnico de configuração preliminar de modelos de mão protésica. Este fluxo deve manter explícitas as decisões, os limites dos modelos e a supervisão humana, sem pressupor adequação clínica ou funcional.

1.3 OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO

1.3.1 OBJECTIVO GERAL

O objectivo geral é produzir conhecimento através da prática de design mediante o desenvolvimento e a avaliação técnica de um sistema paramétrico, apoiado por inteligência artificial, para a configuração preliminar de modelos de mão protésica destinados ao fabrico aditivo.

1.3.2 OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Para concretizar este objectivo, a investigação procura:

- analisar o papel do Design Industrial na articulação entre requisitos humanos, decisões técnicas e condições de fabrico;
- organizar dados antropométricos provenientes de diferentes fontes, preservando população, protocolo, unidade, estatística e limitações;
- adaptar modelos abertos de mão protésica a uma estrutura paramétrica explícita em OpenSCAD;
- desenvolver uma plataforma web que integre configuração, visualização, gestão de versões, exportação e preparação para impressão;

- delimitar o papel da inteligência artificial na sugestão inicial de parâmetros, distinguindo-o das regras geométricas e das decisões humanas;
- avaliar a coerência técnica do percurso entre dados, parâmetros, geometria digital e protótipos físicos;
- identificar os limites da solução e as condições necessárias para avaliações clínicas, funcionais e de utilização posteriores.

A investigação procura responder às seguintes perguntas:

1. De que modo o design paramétrico e a inteligência artificial podem apoiar a configuração preliminar de modelos de mão protésica, mantendo explícitos os limites do sistema e o controlo humano?
2. Que métodos permitem avaliar a coerência entre referências antropométricas, parâmetros, geometria gerada, exportação e prototipagem física?
3. Que decisões de Design Industrial permitem articular, numa plataforma experimental, interface, regras determinísticas, sugestões de inteligência artificial e fabrico aditivo?

1.4 ABORDAGEM METODOLÓGICA GERAL

O projecto adopta uma metodologia aplicada, baseada em Research Through Design, que reconhece o acto de projectar como uma forma de gerar conhecimento. Estrutura-se em fases conceptual, metodológica e empírica, articuladas pelo modelo Double Diamond, que promove ciclos iterativos de exploração, definição, desenvolvimento e avaliação.

A fase conceptual realiza uma revisão crítica da literatura e das plataformas, consolidando o quadro teórico e os requisitos técnicos. A fase metodológica estabelece a arquitectura do sistema paramétrico apoiado por inteligência artificial, integrando dados antropométricos e princípios de design para fabrico aditivo. A fase empírica operacionaliza a modelação paramétrica, a produção de protótipos por impressão 3D e a avaliação técnica preliminar, sem utilizar dados pessoais nem envolver participantes.

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A dissertação organiza-se em nove capítulos principais. O Capítulo 1 apresenta o enquadramento, o problema, os objectivos, as questões de investigação e a abordagem metodológica geral. O Capítulo 2 desenvolve o enquadramento teórico e o estado da arte. O Capítulo 3 explicita a metodologia de investigação. O Capítulo 4 descreve o desenvolvimento do modelo paramétrico. O Capítulo 5 aborda a plataforma web e a integração digital. O Capítulo 6 trata da integração da inteligência artificial. O Capítulo 7 discute a interface, a interacção e a experiência de utilização. O Capítulo 8 reúne a avaliação e a discussão dos resultados. Por fim, o Capítulo 9 sintetiza as conclusões e os trabalhos futuros.

CAPÍTULO 2 — ENQUADRAMENTO TEÓRICO E ESTADO DA ARTE

2.1 PRÓTESE DE MEMBRO SUPERIOR E DISPOSITIVOS MÉDICOS

Prótese de membro superior é um dispositivo médico externo que substitui um segmento ausente devido à amputação ou a uma deficiência congénita. Vai além da restituição formal: recupera funções, facilita atividades diárias, melhora a autonomia e reduz o impacto psicossocial da perda (Fink & Diamond, 2023; Segura et al., 2024).

A perda total ou parcial de um membro superior provoca consequências físicas, funcionais, sociais e emocionais profundas. "Perda total" refere-se à ausência completa do membro, enquanto "perda parcial" indica ausência apenas de parte dele. A mão humana incorpora capacidades motoras e sensoriais complexas, abrangendo o alcance (movimento do membro para tocar ou agarrar objectos), a apreensão (ato de segurar objectos), a manipulação fina (habilidade para movimentos precisos), a estabilização (manter objectos ou posições), a coordenação bimanual (uso de ambas as mãos em colaboração) e a exploração tátil (detecção de propriedades dos objectos pelo contacto). Replicar artificialmente estas funções continua a ser um desafio significativo nos dispositivos médicos e na reabilitação. O desenvolvimento e a prescrição de próteses envolvem compromissos permanentes entre funcionalidade, peso, robustez, conforto, controlo intuitivo, manutenção e custo.

Nas últimas décadas, o sector evoluiu de soluções maioritariamente cosméticas e mecânicas para sistemas com maior sofisticação electromecânica, integração electrónica e capacidade de configuração. Ainda assim, persistem desafios estruturais, como desconforto, dificuldade de controlo, ausência de resposta sensorial e taxas elevadas de abandono. Esta tensão entre potencial técnico e resultados práticos é fundamental para compreender o estado actual das próteses de membro superior como dispositivos médicos.

TIPOLOGIAS DE PRÓTESES DE MEMBRO SUPERIOR

As próteses de membro superior podem ser classificadas de acordo com a fonte de energia e o mecanismo de controlo. Distinguem-se quatro categorias principais: passivas (cosméticas), mecânicas accionadas pelo corpo, mioeléctricas (externamente alimentadas) e híbridas. Cada tipo possui vantagens e limitações, o que reflete diferentes equilíbrios entre desempenho funcional, conforto, durabilidade e custo (Brack & Amalu, 2021).

Próteses passivas destinam-se à aparência e ao apoio estático em tarefas simples, sem apreensão ativa. Variam entre dispositivos rígidos e versões ajustáveis, nas quais os dedos ou os terminais podem ser movidos manualmente. São leves, simples, silenciosas e requerem pouca manutenção. Oferecem utilidade funcional limitada e são preferidas quando a estética é prioritária ou quando o utilizador procura um dispositivo discreto (Fink & Diamond, 2023; Segura et al., 2024).

PRÓTESES MECÂNICAS ACCIONADAS PELO CORPO (BODY-POWERED)

As próteses mecânicas utilizam um sistema de arnês e cabos que converte movimentos do ombro, do tronco ou da cintura escapular em ação no dispositivo terminal, tipicamente um gancho ou uma mão mecânica. São

soluções tradicionalmente valorizadas pela robustez, pela previsibilidade mecânica, pelo menor custo e pela relativa facilidade de manutenção.

Um atributo particularmente relevante é o feedback proprioceptivo indireto proporcionado pela tensão transmitida pelo sistema de cabos, que pode contribuir para um controlo funcional mais previsível em determinadas tarefas. Contudo, estas próteses apresentam limitações expressivas: o arnês pode ser desconfortável e restritivo, os padrões de preensão tendem a ser mais limitados e a sua utilização exige esforço físico contínuo e aprendizagem motora específica (Engdahl et al., 2024; Fink & Diamond, 2023).

PRÓTESES MIOELÉCTRICAS

As próteses mioelétricas são dispositivos alimentados electricamente que utilizam sinais electromiográficos (EMG) captados através de eléctrodos de superfície aplicados no membro residual. Estes sinais são processados electronicamente e activam os motores responsáveis pelo movimento da mão, do punho ou do cotovelo. Em comparação com as soluções mecânicas, apresentam habitualmente maior integração estética, ausência de arnês e potencial para padrões de movimento mais sofisticados. Em alguns casos, a sua utilização tem sido associada à redução da dor fantasma e a uma experiência de uso mais aceitável em contextos sociais. As suas limitações incluem maior peso, custo mais elevado, dependência de baterias, maior sensibilidade à humidade e a interferências, necessidade de calibração e ausência de resposta sensorial directa (Bates et al., 2020; Engdahl et al., 2024).

SISTEMAS HÍBRIDOS

Combinam mecanismos mecânicos e eléctricos no mesmo dispositivo. São particularmente frequentes em amputações proximais, como amputações transumerais ou desarticulações do ombro, podendo associar, por exemplo, controlo mecânico do cotovelo e controlo mioelétrico do terminal. Esta configuração procura tirar partido das vantagens específicas de cada sistema, distribuindo o peso, as exigências funcionais e a complexidade de controlo. Em contrapartida, a aprendizagem, a adaptação e a manutenção podem tornar-se mais exigentes (Segura et al., 2024; Walters et al., 2025).

Uma representação visual útil desta diversidade tipológica é apresentada na Figura 2.1, que reúne exemplos de próteses impressas em 3D com soluções morfológicas e mecânicas distintas, ajudando a perceber como diferentes opções de configuração materializam compromissos distintos entre simplicidade, função e custo.



Figura 2.1 — Exemplos de próteses de membro superior impressas em 3D, ilustrando diversidade tipológica e construtiva.

Fonte original: ten Kate, J., Smit, G., & Breedveld, P. (2017). 3D-printed upper limb prostheses: A review. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 12(3), 300-314. <https://doi.org/10.1080/17483107.2016.1253117>

CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS E FUNCIONAIS

A prescrição de uma prótese de membro superior constitui um processo clínico complexo, centrado no utilizador e conduzido por uma equipa multidisciplinar composta por médicos, protesistas, terapeutas e pela própria pessoa. A escolha do dispositivo terminal envolve uma avaliação integrada de factores físicos, funcionais, ocupacionais e psicossociais (Fink & Diamond, 2023; Soyer et al., 2016).

Entre os factores físicos incluem-se o nível de amputação, o comprimento e a condição do membro residual, a integridade cutânea, a amplitude articular e a força muscular. Amputações de nível mais proximal implicam desafios acrescidos em termos de controlo e do peso do sistema protésico.

Os factores individuais, como idade, comorbilidades, dominância manual, literacia técnica, contexto profissional e atividades recreativas, influenciam significativamente a escolha da tipologia protésica. A título

de exemplo, utilizadores envolvidos em trabalho manual intensivo ou em ambientes mais exigentes podem beneficiar de soluções mecânicas mais robustas, enquanto contextos profissionais e sociais em que a integração estética e a diversidade funcional são mais valorizadas podem favorecer dispositivos mioelétricos.

Os factores psicossociais, incluindo motivação, expectativas, imagem corporal, suporte social e capacidade cognitiva, são igualmente determinantes. Expectativas irrealistas relativamente às capacidades do dispositivo podem levar à insatisfação, ao uso intermitente e ao eventual abandono.

A reabilitação protésica desenvolve-se em fases — cuidados perioperatórios, preparação pré-protésica, treino com prótese definitiva e acompanhamento a longo prazo. O treino funcional é particularmente relevante em sistemas mioelétricos, exigindo fortalecimento muscular específico, aprendizagem da geração de sinais consistentes e integração progressiva do dispositivo em tarefas reais. De modo recorrente, a literatura sublinha a importância do seguimento continuado, da educação do utilizador e do ajustamento iterativo do dispositivo ao longo do tempo (Bates et al., 2020; Soyer et al., 2016).

MEDIÇÃO DE RESULTADOS E ABANDONO PROTÉSICO

A avaliação objetiva do sucesso protésico continua a ser um desafio. Persistem a escassez de instrumentos padronizados e a heterogeneidade de métricas, o que dificulta a comparação entre estudos, dispositivos e estratégias de reabilitação. São utilizadas ferramentas de avaliação registadas pelo utilizador, centradas na funcionalidade percebida, na satisfação e na qualidade de vida, bem como testes baseados em desempenho, orientados para a destreza, a velocidade de execução e o controlo funcional em tarefas estruturadas (Segura et al., 2024; Soyer et al., 2016).

Apesar da evolução tecnológica, as taxas de abandono permanecem elevadas. A literatura associa, de forma recorrente, a rejeição protésica a problemas de conforto, peso, funcionalidade insuficiente, manutenção exigente e controlo pouco intuitivo. Esta persistência indica que a melhoria tecnológica isolada não garante adoção sustentada. Ainda assim, quando o dispositivo está adequadamente prescrito, ajustado e acompanhado, a utilização continuada de prótese tende a associar-se a maior independência funcional e a melhores indicadores de participação e de qualidade de vida do que a não utilização (Fink & Diamond, 2023; Smail et al., 2020).

Esta persistência do abandono é sintetizada de forma clara na Figura 2.2, que relaciona uso, rejeição primária e rejeição secundária, reforçando que o problema não é marginal, mas estrutural no campo das próteses de membro superior.

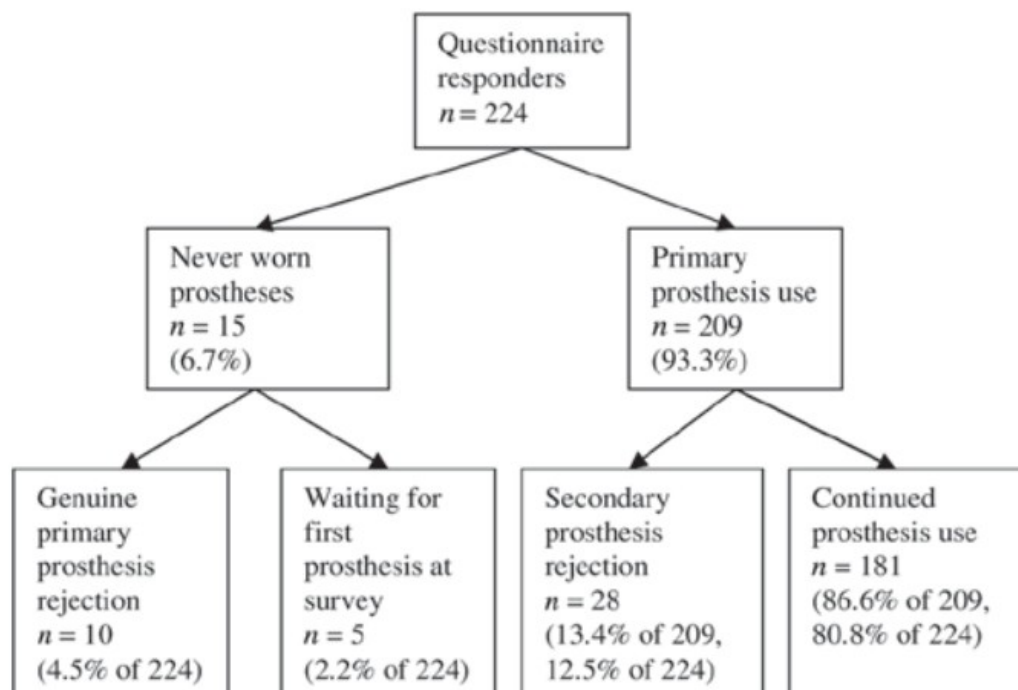


Figura 2.2 — Utilização, rejeição primária e rejeição secundária de próteses do membro superior adquiridas.

Fonte original: Biddiss, E., Beaton, D., & Chau, T. (2007). Consumer design priorities for upper limb prosthetics. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 2(6), 346-357. <https://doi.org/10.1080/17483100701714733> (<https://doi.org/10.1080/17483100701714733>)

ENQUADRAMENTO REGULATÓRIO ENQUANTO DISPOSITIVO MÉDICO

As próteses de membro superior são classificadas como dispositivos médicos e estão sujeitas à regulamentação específica destinada a garantir a segurança, o desempenho e a vigilância ao longo de todo o ciclo de vida. Na União Europeia, o enquadramento é definido pela Regulamento ([²]EU) 2017/745 (MDR) - <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj/eng>, que classifica os dispositivos nas Classes I, IIa, IIb e III. Dispositivos terapêuticos ativos, incluindo próteses mioelétricas, enquadram-se geralmente nas classes intermédias ou superiores, o que exige avaliação por um organismo notificado para efeitos de marcação CE[³] (Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2017).

Nos Estados Unidos, a regulação é assegurada pela Food and Drug Administration (FDA) por meio de um sistema de classificação de risco. A maioria dos componentes protésicos convencionais enquadra-se nas classes de risco mais baixas, enquanto sistemas mais complexos, como próteses mioelétricas avançadas, podem exigir controlos, documentação técnica mais extensa e, em certos casos, evidência clínica adicional (Resnik et al., 2010).

A demonstração de segurança e desempenho implica avaliação clínica sistemática, testes de biocompatibilidade, avaliação da segurança mecânica e elétrica, validação de software e consideração explícita de factores humanos e de usabilidade. Normas desenvolvidas no âmbito do comité técnico ISO/TC 168[⁴]

contribuem para a padronização de requisitos aplicáveis a próteses e ortóteses. Adicionalmente, os fabricantes devem implementar sistemas de vigilância pós-comercialização, recolhendo dados de uso real ao longo do ciclo de vida do dispositivo, o que reforça a natureza regulada, iterativa e evidencial deste domínio (Parlamento Europeu & Conselho da União Europeia, 2017; Resnik et al., 2010).

2.2 DESIGN INDUSTRIAL, DESIGN INCLUSIVO E DESIGN CENTRADO NO UTILIZADOR

O design industrial, no contexto da saúde e das tecnologias de apoio, é reconhecido progressivamente como uma disciplina mediadora entre as necessidades humanas, os contextos de utilização e os sistemas técnicos regulados.

A literatura revista evidencia que o design desempenha um papel estruturante na promoção da inclusão, da autonomia e da participação social, ao articular a configuração formal dos produtos com a modelação da relação entre indivíduos, ambientes, artefactos e sistemas.

Em particular, nas tecnologias de apoio, o design é descrito como um elemento que medeia a interacção entre os utilizadores e o seu meio envolvente, contribuindo para reduzir barreiras funcionais e sociais e, consequentemente, para melhorar os resultados de participação e a qualidade de vida (Clarkson & Coleman, 2010; Shah & Robinson, 2006).

Paralelamente, o design inclusivo é apresentado como um imperativo contemporâneo que visa minimizar a exclusão evitável decorrente de decisões projectuais que ignoram a diversidade populacional e as alterações de capacidades ao longo do tempo. Esta perspectiva alinha-se com a responsabilidade dos sistemas de saúde de responder a utilizadores heterogéneos, com diferentes condições físicas, cognitivas e contextuais (Clarkson & Coleman, 2010).

DESIGN INDUSTRIAL EM DISPOSITIVOS MÉDICOS

No domínio dos dispositivos médicos, o design industrial constitui uma prática metodológica centrada no utilizador e assume um papel colaborativo em equipas multidisciplinares de desenvolvimento. A literatura identifica, contudo, uma lacuna estrutural: muitos dispositivos médicos continuam a ser desenvolvidos predominantemente com base em abordagens de engenharia e em requisitos regulatórios, com participação limitada de profissionais com formação específica em metodologias de design centrado no uso. Esta assimetria contribui para soluções tecnicamente robustas, mas nem sempre optimizadas em termos de ergonomia, usabilidade ou integração na vida quotidiana (Fisher & Johansen, 2020; Wilke et al., 2020).

Neste contexto, o design industrial assume relevância na conceptualização, na definição de requisitos de utilização, na tradução de necessidades clínicas em soluções tangíveis e na articulação entre requisitos regulamentares e experiência do utilizador (Fisher & Johansen, 2020; Shah & Robinson, 2006).

Esta posição intermédia do design torna-se mais clara quando se observa a multiplicidade de papéis que os profissionais de saúde podem assumir nos processos de desenvolvimento. Em vez de contribuírem apenas como validadores de soluções, estes agentes podem ser intervenientes do seu sector, utilizadores peritos, mediadores entre domínios e profissionais clínicos ou investigadores, como sintetiza a Tabela 2.1.

Tabela 2.1 — Papéis dos profissionais de saúde no desenvolvimento de dispositivos médicos

Papel	Contributo no desenvolvimento	Domínio principal de decisão
Utilizadores peritos	Fornecem experiência clínica situada e problemas de uso	Experiência do utilizador e adequação funcional
Mediadores	Traduzem linguagem, necessidades e constrangimentos entre equipas	Problemas técnicos, terminologia e entendimento partilhado
Profissionais clínicos e investigadores	Enquadram cuidados, testes e validação empírica	Resultados clínicos, ensaios e usabilidade

Fonte adaptada. Referência original: Kaygan, H., & Kaygan, P. (2025). Clients and carers: Healthcare professionals' roles in medical device development processes in SMEs. *The Design Journal*, 28(2), 213-231.
<https://doi.org/10.1080/14606925.2024.2420152> (<https://doi.org/10.1080/14606925.2024.2420152>)

DESIGN INCLUSIVO E DESIGN UNIVERSAL

O design inclusivo representa uma mudança conceptual significativa ao deslocar o foco da deficiência enquanto atributo individual para a compreensão da deficiência como resultado de desajustes entre capacidades humanas e ambientes projetados (Clarkson & Coleman, 2010).

Esta perspectiva aproxima-se dos modelos sociais e relacionais da deficiência, enfatizando que a exclusão pode ser produzida por decisões de projecto que não contemplam a diversidade de utilizadores (Clarkson & Coleman, 2010).

Enquanto campo de prática e investigação, o design inclusivo desenvolveu ferramentas e orientações destinadas a apoiar equipas de projecto na consideração sistemática da diversidade populacional. Estas incluem estratégias de segmentação, análise de capacidades e critérios de acessibilidade aplicáveis a produtos e sistemas, incluindo tecnologias digitais em saúde (Clarkson & Coleman, 2010).

O design universal, por sua vez, é frequentemente enquadrado como uma abordagem amplamente aplicada no design industrial, tendo como princípio orientador a concepção de produtos e ambientes utilizáveis pelo maior número possível de pessoas, sem necessidade de adaptações ou de design especializado. Os Sete Princípios do Design Universal, propostos por Ron Mace^[5], são amplamente citados como um quadro normativo para avaliar equidade, flexibilidade, simplicidade, tolerância ao erro e redução do esforço físico (Story, 2006).

Na área da saúde, o design universal é associado a abordagens centradas na pessoa e avaliado através de critérios orientados a resultados, como a participação, a inclusão e a igualdade de acesso. A convergência entre design inclusivo e design universal revela-se particularmente evidente na ênfase comum na redução de barreiras ambientais e na ampliação do conceito de usabilidade para uma população mais ampla (Story, 2006; White & Mosca, 2022).

DESIGN CENTRADO NO UTILIZADOR E DESIGN CENTRADO NO HUMANO

O design centrado no utilizador (User-Centred Design – UCD) é descrito como uma abordagem que envolve os utilizadores finais ao longo de todo o processo de desenvolvimento, com o objectivo de assegurar que o produto seja funcionalmente adequado, compreensível e valorizado. Esta abordagem mobiliza métodos

como entrevistas, personas, protocolos de think-aloud, prototipagem iterativa e grupos focais, promovendo ciclos sucessivos de recolha de requisitos e de validação (Fisher & Johansen, 2020; Shah & Robinson, 2006).

O design centrado no humano (Human-Centred Design – HCD) amplia esta perspectiva ao integrar dimensões culturais, contextuais e sistémicas. No desenvolvimento de dispositivos médicos, o HCD é associado a práticas como etnografia, design participativo, mapeamento de jornadas (journey maps), mapeamento de stakeholders e avaliação de factores humanos. A norma ISO 62366 define requisitos específicos para a aplicação da engenharia de usabilidade a dispositivos médicos, reforçando a integração formal de avaliações formativas e sumativas no processo regulado de desenvolvimento. (Fisher & Johansen, 2020; Millet et al., 2018).

A incorporação de factores humanos é igualmente reforçada por diretivas e normas que exigem a redução dos riscos de uso inadequado, articulando segurança, ergonomia e usabilidade como dimensões indissociáveis do desenvolvimento de dispositivos médicos (Millet et al., 2018).

DESIGN PARTICIPATIVO E CO-DESIGN

O design participativo e o co-design representam um aprofundamento das abordagens centradas no utilizador, enfatizando a participação activa e o envolvimento dos utilizadores no processo de projecto. Nestes modelos, os utilizadores contribuem para a definição de problemas, a geração de soluções e a avaliação de protótipos (Chapman et al., 2025).

Revisões sistemáticas apontam para a necessidade de maior transparência e rigor na descrição dos processos de co-design, de modo a fortalecer a sua validade metodológica e eficácia prática. Nas tecnologias de apoio, observa-se uma evolução discursiva dos modelos centrados no utilizador para paradigmas de cocriação, nos quais as experiências dos utilizadores assumem um estatuto central na tomada de decisão (Chapman et al., 2025). Persistem tensões entre ideais participativos e contextos regulatórios altamente estruturados, nos quais a autoridade decisional permanece frequentemente concentrada em profissionais clínicos e em equipas técnicas (Chapman et al., 2025; Wilke et al., 2020).

METODOLOGIAS, INSTRUMENTOS E AVALIAÇÃO

A literatura evidencia que as abordagens inclusivas e centradas no utilizador recorrem a repertórios metodológicos diversificados, incluindo personas, simulação de limitações, prototipagem iterativa, oficinas participativas e análise de ecossistemas de stakeholders (Fisher & Johansen, 2020; Shah & Robinson, 2006).

No domínio hospitalar e dos serviços de saúde, ferramentas de avaliação baseadas em critérios de design universal e de design para todos (Design for All) introduzem sistemas de análise multicritério e listas de verificação estruturadas para aferir os níveis de inclusão (White & Mosca, 2022).

Em contextos de tecnologias de apoio, modelos como o Matching Person and Technology (MPT) e quadros conceptuais baseados na Classificação Internacional de Funcionalidade (ICF) são utilizados para apoiar decisões de selecção e de adequação tecnológica, promovendo o alinhamento entre as características do utilizador, do ambiente e do dispositivo (White & Mosca, 2022).

A avaliação da evidência tem sido igualmente reforçada através do uso de protocolos sistemáticos, como o PRISMA, que orienta a identificação, selecção e apresentação transparente dos estudos analisados, bem como

de instrumentos de avaliação crítica. Esta evolução reflete uma preocupação crescente em fundamentar decisões de design numa base empírica robusta. (Chapman et al., 2025).

DESAFIOS E LACUNAS

Entre os principais desafios identificados destacam-se a articulação entre normalização e personalização em dispositivos médicos regulamentados, a distância entre modelos teóricos de UCD e as restrições institucionais da prática em saúde, a passagem de processos participativos para contextos de implementação e a integração de factores sociais e culturais na investigação e no desenvolvimento (Fisher & Johansen, 2020; Oldfrey et al., 2024; Shah & Robinson, 2006).

Estas lacunas evidenciam que o design industrial em dispositivos médicos não pode ser compreendido apenas como uma prática formal ou estética, mas como uma disciplina estratégica que articula inclusão, regulação, implementação e experiência do utilizador.

2.3 FABRICO ADITIVO E PARAMETRIZAÇÃO NO DESIGN DE PRODUTO

A convergência entre modelação paramétrica e fabrico aditivo (FdA) tem sido amplamente reconhecida como um dos principais vetores de transformação no design contemporâneo, particularmente em contextos que exigem personalização, adaptação morfológica e produção de variantes em pequena escala. A literatura posiciona estas duas abordagens como complementares: a modelação paramétrica permite gerar múltiplas variações controladas a partir de um modelo-base, enquanto a fabrico aditivo viabiliza a materialização de geometrias complexas sem necessidade de moldes ou ferramentas dedicadas (Lei et al., 2016; Ozdemir et al., 2022; Stralen, 2018).

Esta articulação é representada com clareza na Figura 2.3, que resume o encadeamento entre aquisição digital, modelação/rectificação e fabrico, evidenciando que a personalização depende da integração das várias etapas do fluxo de trabalho.

Fluxo tradicional



Trabalho físico

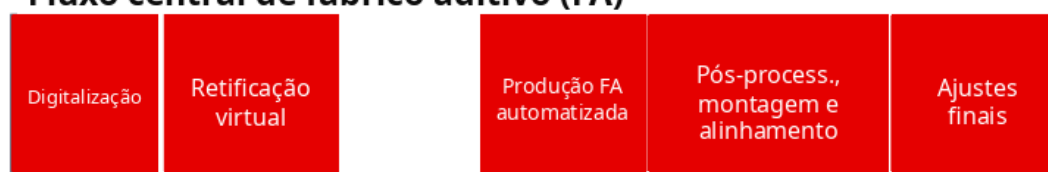
Fluxo CAD/CAM central



Ambiente digital

Trabalho físico

Fluxo central de fabrico aditivo (FA)



Ambiente digital

Trabalho físico

Figura 2.3 — Fluxo digital entre aquisição, CAD/CAM e fabrico aditivo em próteses e órteses.

Fonte original: Chainando, N., Faephu, C., Suwaphong, N., Bureerat, S., Limphirat, W., Thammajarak, P., & Syafrudin, M. (2025). Applying 3D scanning and printing techniques to produce upper limb prostheses: Bibliometric analysis and scoping review. *Prosthesis*, 7(2), 26. <https://www.mdpi.com/2673-1592/7/2/26/pdf?version=1740996517> (<https://www.mdpi.com/2673-1592/7/2/26/pdf?version=1740996517>)

Neste enquadramento, a personalização deixa de ser entendida como exceção e passa a constituir uma estratégia estruturada, operacionalizada por meio de “seed designs” ou modelos-base parametrizados. Estes modelos preservam uma arquitetura estável, expondo simultaneamente um conjunto limitado de variáveis ajustáveis, frequentemente acessíveis por meio de interfaces digitais ou de configuradores destinados a utilizadores não especialistas (Ozdemir et al., 2022; Stralen, 2018).

MODELAÇÃO PARAMÉTRICA E ESPAÇOS DE VARIAÇÃO

Os modelos paramétricos desempenham duas funções centrais. Em primeiro lugar, codificam a lógica geométrica do produto — relações, restrições e regras —, assegurando que alterações nos valores dos parâmetros gerem novas variantes sem comprometer a integridade estrutural nem a coerência funcional. Em segundo lugar, permitem explorar espaços de variação extensos, frequentemente descritos como quase contínuos, o que possibilita a criação de famílias de produtos ajustáveis por meio da modificação de variáveis dimensionais ou funcionais (Lei et al., 2016; Ozdemir et al., 2022).

No contexto da adaptação ao utilizador, a literatura destaca que a parametrização torna-se particularmente eficaz quando associada a dados mensuráveis, como a antropometria ou as digitalizações tridimensionais.

Em vez de recorrer a um escalonamento uniforme, que pode introduzir desvios significativos, a definição de parâmetros independentes, como comprimento e largura, permite ajustes mais precisos e maior controlo

dimensional dentro de margens reduzidas. Em aplicações protésicas, esta abordagem revelou maior proximidade às cinemáticas naturais e melhor adequação morfológica face a modelos ajustados apenas por escala global. (Lim et al., 2018).

INTEGRAÇÃO COM FABRICO ADITIVO E DESIGN FOR ADDITIVE MANUFACTURING

A eficácia da personalização depende da integração precoce dos constrangimentos do processo de fabrico aditivo no processo de projecto. A literatura sobre Design for Additive Manufacturing (DfAM) sublinha que a incorporação antecipada de limitações de processo — tolerâncias, resistência mecânica, espessuras mínimas, orientação de impressão — reduz falhas de fabrico e encurta os ciclos iterativos (Chtioui et al., 2023; Wiberg et al., 2019).

Estudos aplicados demonstram que, ao determinar experimentalmente constrangimentos do processo e incorporá-los ao modelo paramétrico, é possível gerar milhares de variantes únicas com elevada taxa de sucesso funcional, minimizando as reimpressões (Wiberg et al., 2019). [^9]

Esta evidência reforça a necessidade de uma ligação sistemática entre as fases de design e fabrico, contrariando abordagens que tratam a fabrico como etapa posterior e correctiva (Chtioui et al., 2023; Wiberg et al., 2019).

As tecnologias de fabrico aditivo (FA) utilizadas incluem FDM/FFF (extrusão de termoplásticos), SLS (fusão seletiva a laser), SLA (estereolitografia) e processos industriais metálicos, o que reflete a diversidade de rotas produtivas para componentes personalizados. Cada tecnologia implica requisitos específicos de projecto, reforçando a importância de integrar critérios técnicos no modelo paramétrico desde o início (Chtioui et al., 2023; Wiberg et al., 2019).[^10]

CONFIGURADORES E COCRIAÇÃO DIGITAL

A articulação entre modelação paramétrica e interfaces digitais possibilita novos modelos de cocriação e de produção distribuída. Configuradores web ou interfaces baseadas em CAD expõem um conjunto delimitado de parâmetros, permitindo ao utilizador ajustar dimensões ou características dentro de intervalos válidos, frequentemente com feedback em tempo real sobre viabilidade (Ozdemir et al., 2022; Stralen, 2018).

A Figura 2.4 mostra um exemplo especialmente relevante desta lógica: a personalização mediada por interface, em que o utilizador atua sobre atributos visuais e formais dentro de um espaço de variação previamente estruturado. Este tipo de configurador ajuda a compreender como a cocriação digital pode ser operacionalizada sem exigir domínio directo de ferramentas CAD complexas.

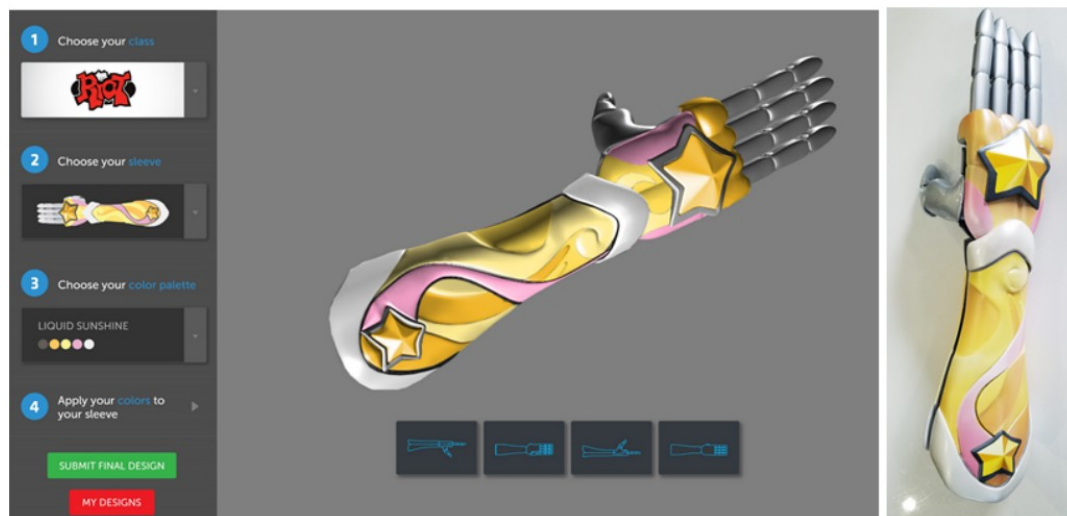


Figura 2.4 — Exemplo de configurador digital para personalização de uma prótese impressa em 3D.

Fonte original: Manero, A., Smith, P., Sparkman, J., Dombrowski, M., Courbin, D., Kester, A., Womack, I., & Chi, A. (2019). Implementation of 3D printing technology in the field of prosthetics: Past, present, and future. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16, 1641. <https://doi.org/10.3390/ijerph16091641>

Este modelo “file-to-factory” viabiliza fluxos digitais em que o ficheiro parametrizado é convertido diretamente em instruções de fabrico, seja localmente (impressão 3D descentralizada) ou através de uma encomenda online^[11]. A literatura associa esta lógica à democratização do design e à expansão de estratégias de customização em massa (mass customization) e personalização em massa (mass personalization), reduzindo custos marginais ao dispensar moldes e dispositivos específicos de fabrico.^[12] (Lei et al., 2016; Stralen, 2018).

Contudo, enfatiza-se que configuradores eficazes devem limitar o número de parâmetros expostos e fornecer orientação clara sobre os limites válidos, evitando complexidade excessiva ou escolhas superficiais (Ozdemir et al., 2022).

OTIMIZAÇÃO, GERAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A parametrização é frequentemente combinada com métodos de optimização topológica, de geração de estruturas reticuladas e de abordagens multiobjectivo. Estas estratégias permitem gerir compromissos entre peso, resistência, custo e tempo de fabrico, explorando fronteiras de Pareto para seleccionar soluções alinhadas com objectivos específicos (Lei et al., 2016; Yao et al., 2016).

Em contextos médicos e de tecnologias de apoio, estudos demonstram a integração de modelos paramétricos com análises de elementos finitos (FEM) para validar o desempenho estrutural, bem como a utilização de algoritmos generativos capazes de adaptar padrões e estruturas superficiais a geometrias individualizadas. (Lei et al., 2016; Lim et al., 2018).

Este cruzamento entre parametrização, simulação e FA evidencia um ecossistema digital integrado que sustenta personalização técnica com base quantitativa (Lei et al., 2016; Yao et al., 2016).

IMPLICAÇÕES PARA O DESIGN INDUSTRIAL

A literatura converge para a ideia de que a robustez do modelo paramétrico é uma condição crítica para a personalização em escala. Modelos mal estruturados ou com dependências inconsistentes podem comprometer a simulação, a optimização e a configuração de famílias de produto (Lei et al., 2016; Wiberg et al., 2019).

Assim, a qualidade da definição paramétrica desempenha um papel estratégico para a viabilidade de sistemas adaptáveis (Ozdemir et al., 2022).

Em termos económicos, a Fabrico Aditivo permite reduzir [13] penalizações tradicionais associadas à variação de produto, sustentando modelos de personalização acessíveis. Estudos orientados para famílias de produto indicam que a integração de modelos paramétricos com análises de custo e desempenho pode manter os custos relativamente estáveis mesmo com elevada diversidade geométrica (Lei et al., 2016; Yao et al., 2016).

No plano educativo e profissional, recomenda-se a integração de DfAM nos currículos de design industrial, promovendo competências que articulem a concepção, a simulação e a fabrico digital em fluxo contínuo (Kandikjan et al., 2022).

2.4 PRÓTESES OPEN SOURCE DE MEMBRO SUPERIOR PASSÍVEIS DE IMPRESSÃO 3D

As próteses open source de membro superior passíveis de impressão 3D constituem um caso particularmente relevante para esta investigação, porque tornam visível a articulação entre fabrico aditivo, partilha digital de ficheiros, produção distribuída e adaptação local. Ao contrário dos dispositivos comerciais desenvolvidos em cadeias industriais fechadas, estes modelos circulam frequentemente como ficheiros editáveis ou imprimíveis, acompanhados por instruções de montagem, listas de componentes e documentação comunitária. A partilha destes recursos reduz barreiras de acesso aos ficheiros e demonstra a capacidade de comunidades distribuídas para produzir e adaptar soluções fora dos canais tradicionais da indústria médica; a qualidade funcional de cada dispositivo continua dependente de avaliação própria (Manero et al., 2019; Wendo et al., 2022).

O projecto e-NABLE é o exemplo mais influente deste movimento. A comunidade consolidou-se em torno da criação e partilha de dispositivos de assistência para diferenças de membro superior, em especial mãos mecânicas accionadas pelo corpo e braços impressos em 3D para crianças. O seu catálogo reúne modelos de mão, braço, dedos, polegares e dispositivos terminais, organizados de acordo com a anatomia disponível e o tipo de acionamento. Nos modelos de mão accionados pelo punho, a flexão dos dedos depende normalmente da flexão ativa do punho e de uma palma parcialmente preservada; quando essa condição anatómica não existe, a solução tende a deslocar-se para braços ou mecanismos accionados pelo cotovelo (Wendo et al., 2022).

Este enquadramento é importante porque vários modelos usados ou analisados nesta investigação pertencem diretamente a esta linhagem. O Cyborg Beast, o Raptor Reloaded, a Flexy Hand, o Flexy Beast, o Paraglider Hand/Flexible Flyer, a Phoenix Hand e a Unlimbited Phoenix Hand não devem ser entendidos como objectos isolados, mas como variações de um ecossistema e-NABLE em que cada modelo traduz compromissos diferentes entre simplicidade de impressão, facilidade de montagem, robustez, custo, aparência e adequação anatómica. O Cyborg Beast, por exemplo, foi descrito como uma mão protésica infantil de baixo custo, accionada pelo punho e ajustável por procedimentos remotos de medição e escala (Zuniga et al., 2015).

Já modelos posteriores, como a Phoenix/Unlimbited Phoenix e derivados como o Paraglider, procuram simplificar a montagem, melhorar a manutenção e estabilizar geometrias recorrentes. Para o presente projecto, isto tem uma consequência directa: a integração de modelos e-NABLE numa plataforma paramétrica não é apenas uma operação técnica de importação de ficheiros, mas uma tentativa de explicitar e controlar regras geométricas que, nos modelos originais, aparecem muitas vezes como escalas globais, limites empíricos ou decisões embebidas no próprio ficheiro.

O Victoria Hand Project representa uma alternativa complementar ao modelo comunitário e maker do e-NABLE. Em vez de depender sobretudo de voluntários dispersos, organiza-se como uma estrutura de prestação de cuidados baseada em parcerias locais, formação técnica, fabrico descentralizado e acompanhamento por profissionais ou clínicas parceiras. A sua relevância está em mostrar que a impressão 3D pode ser integrada num modelo de serviço mais estruturado, no qual a criação digital de componentes, a selecção modular, a adaptação de encaixes e a circulação de feedback entre parceiros locais e equipa central funcionam como infraestrutura de aprendizagem contínua (Dechev et al., 2023). Assim, enquanto o e-NABLE evidencia o potencial da comunidade aberta e da documentação partilhada, o Victoria Hand Project evidencia a importância da mediação clínica, da formação e da qualidade controlada em contextos de baixo acesso a cuidados protésicos.

A evidência disponível, contudo, obriga a uma leitura cautelosa. As revisões sistemáticas sobre próteses de membro superior impressas em 3D indicam que os resultados são promissores, mas continuam limitados por amostras pequenas, ausência de ensaios controlados, períodos curtos de acompanhamento e heterogeneidade nos instrumentos de avaliação. A literatura existente não demonstra superioridade robusta face a próteses convencionais nem permite concluir sobre efeitos de longo prazo em conforto, durabilidade ou qualidade de vida (Diment et al., 2018). Uma revisão mais recente sobre resultados clínicos de próteses impressas em 3D reforça a mesma cautela: há sinais de melhoria em destreza, satisfação e adequação, mas a qualidade da evidência permanece limitada e pouco comparável entre estudos (Atallah et al., 2025).

As limitações técnicas também são relevantes para o design. Estudos mecânicos sobre mãos open source mostram que a acessibilidade e o baixo custo coexistem com restrições claras de desempenho, repertório de preensões, resistência, durabilidade e segurança funcional. No caso do Raptor Reloaded, por exemplo, uma mão corporalmente accionada pode ser útil para tarefas simples, mas permanece distante da diversidade de movimentos e preensões de uma mão humana (Cabibihan et al., 2021). Esta constatação não diminui o valor social destes modelos, mas impede que sejam apresentados como substitutos clínicos universais. Pelo contrário, reforça a necessidade de os tratar como plataformas de desenvolvimento, aprendizagem e personalização progressiva.

Para esta investigação, o interesse das próteses open source impressas em 3D está precisamente nessa tensão. Modelos como o Flexy Beast, o Paraglider Hand e a Unlimbited Phoenix Hand oferecem bases abertas, documentadas e compatíveis com fabrico distribuído. A sua configuração continua frequentemente dependente de escalonamento, adaptação manual e conhecimento tácito da comunidade. A proposta de um sistema paramétrico apoiado por inteligência artificial situa-se nesse intervalo: procura transformar modelos abertos

em objectos configuráveis com regras explícitas, limites dimensionais visíveis, apoio à escolha do modelo e ligação mais clara entre dados antropométricos, geometria gerada e critérios de fabrico. Deste modo, o ecossistema e-NABLE e o Victoria Hand Project constituem antecedentes históricos e referências críticas para compreender o que a plataforma deve preservar, corrigir e tornar mais verificável.

2.5 ANTROPOMETRIA APLICADA AO DESIGN PROTÉSICO

A antropometria constitui um fundamento técnico e metodológico central no design protésico, na medida em que a adequação geométrica do dispositivo ao corpo do utilizador condiciona diretamente o conforto, a segurança, o desempenho funcional e a aceitação. Em próteses e tecnologias de apoio, a literatura recente evidencia uma transição progressiva de medições manuais baseadas em marcos anatómicos para processos digitais de captura de superfície (digitalização 3D e fotogrametria), integrados com fluxos CAD/CAM e com fabrico aditivo. Esta evolução é frequentemente descrita como uma cadeia “aquisição anatómica → modelação/retificação em CAD → fabrico aditivo → pós-processamento”, embora também se reconheça que muitos estudos permanecem em fases de prova de conceito e carecem de validação longitudinal e em larga escala (Chainando et al., 2025).

DA DIMENSÃO LINEAR À “FORMA” COMO DADO DE PROJECTO

Historicamente, a antropometria aplicada ao design baseou-se em medidas escalares (comprimentos, larguras, perímetros), obtidas com instrumentos como paquímetros, compassos antropométricos e fitas métricas, muitas vezes segundo procedimentos normalizados (por exemplo, a norma ISO 7250). Contudo, no design protésico — particularmente em interfaces corpo–dispositivo, como o encaixe (socket) — a literatura sublinha que a “forma” (shape) desempenha um papel determinante, pois pequenas variações volumétricas e distribuições de pressão podem gerar desconforto, lesões cutâneas e abandono do dispositivo. Estudos e revisões referem que o ajuste protésico pode exigir tolerâncias muito reduzidas e que a complexidade anatómica, bem como trajetórias de carga e zonas de alívio, não é devidamente capturada por um conjunto limitado de medidas lineares (Albin & Molenbroek, 2023; Young et al., 2023).

Assim, observa-se uma valorização crescente de métodos capazes de capturar geometria tridimensional de alta resolução e de traduzir essa informação em modelos CAD passíveis de retificação, parametrização e fabrico (Squibb et al., 2024).

Mesmo assim, a medição linear continua a ser indispensável para estruturar o modelo paramétrico, sobretudo quando se pretende definir um conjunto mínimo de entradas robustas e replicáveis. A Figura 2.5 ilustra precisamente este nível basal: os marcos anatómicos e os comprimentos de referência que sustentam medições comparáveis da mão.

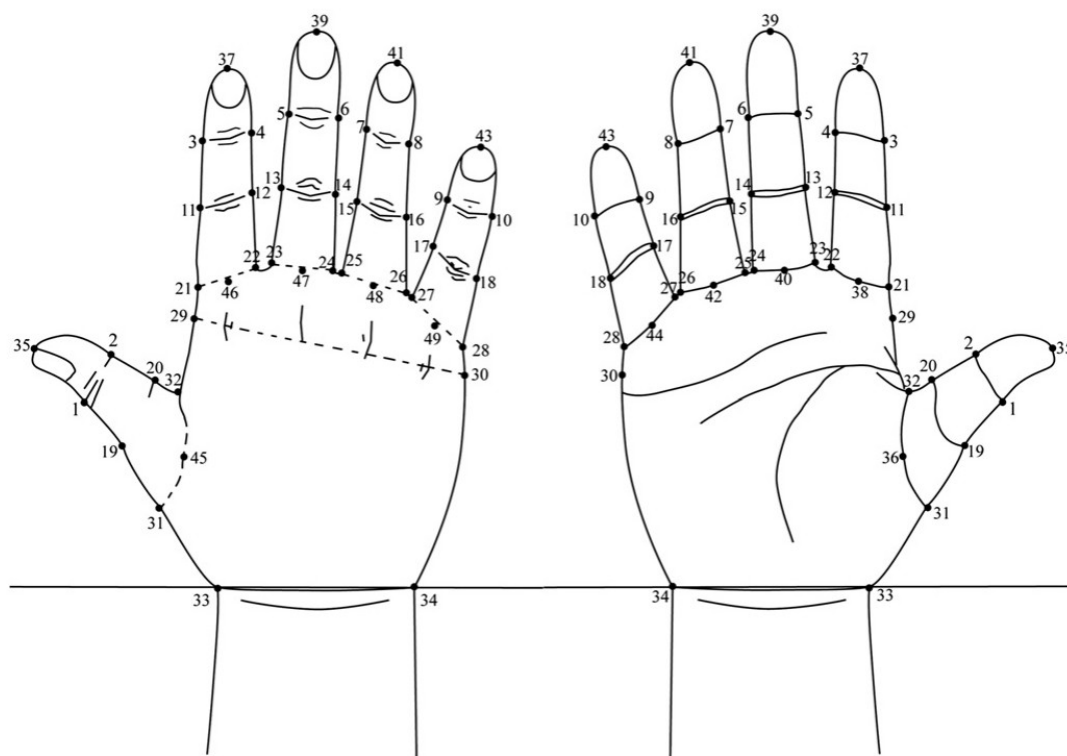


Figura 2.5 — Marcos anatômicos e medidas de referência da mão para fins de personalização.

Fonte original: Yu, A., Yick, K. L., Ng, S. P., & Yip, J. (2013). 2D and 3D anatomical analyses of hand dimensions for custom-made gloves. *Applied Ergonomics*, 44, 381-392.

MÉTODOS DE RECOLHA ANTROPOMÉTRICA EM PRÓTESES E TECNOLOGIAS DE APOIO

A literatura organiza os métodos de recolha em famílias, cada uma com potencialidades e limitações específicas para o design protésico:

A antropometria manual inclui medições em posturas normalizadas, com instrumentos clínicos e de ergonomia. Mantém relevância em contextos de acessibilidade clínica e de monitorização simples, por exemplo através da medição de circunferências para acompanhar variações do membro residual. Contudo, estas medidas podem representar de forma limitada as alterações reais de volume, uma vez que dependem da geometria do segmento e da distribuição dos tecidos, o que reduz a precisão necessária para decisões de ajuste fino. (Ibrahim et al., 2024).

2. A digitalização 3D, através de scanning óptico, permite captar a superfície corporal sob a forma de nuvens de pontos ou malhas, posteriormente limpas e convertidas em modelos utilizáveis em CAD e fabrico, frequentemente no formato STL. Esta tecnologia facilita fluxos de personalização e pode ser combinada com processos de automatização, como a correspondência de características anatômicas, para reduzir o trabalho manual. A consistência dos resultados pode, contudo, variar conforme a complexidade da forma, sobretudo em geometrias irregulares, como segmentos residuais complexos. (Squibb et al., 2024).

3. Fotogrametria: reconstrói modelos 3D a partir de fotografias 2D, incluindo soluções baseadas em smartphones. É apresentada como um método promissor pela rapidez de captura e pelo potencial de acesso alargado, embora possa exigir mais tempo de processamento e cuidados com a iluminação e a cobertura da imagem (Silva et al., 2024).

4. As imagens médicas, como tomografia computadorizada (CT) ou ressonância magnética (MRI: Magnetic Resonance Imaging), permitem obter geometria externa e, em alguns casos, informação interna, por exemplo sobre estruturas ósseas. Esta informação pode sustentar modelos mais ricos e abordagens como a modelação estatística de forma. Contudo, estas técnicas implicam maior custo e menor acessibilidade e, no caso do CT, exigem ainda considerar a exposição à radiação e a dependência de contexto hospitalar.

5. Medições complementares da interface (pressão, termografia, bioimpedância) A literatura enfatiza que, em próteses, a adequação não é apenas geométrica: depende do comportamento da interface durante o uso. Por isso, surgem métodos adjuntos que quantificam sinais de ajuste, como a distribuição de pressão e de cisalhamento, zonas de aquecimento localizado (Thermal hot spots) e flutuações de volume do membro residual. Estes métodos ajudam a ligar decisões de forma/retificação a desfechos de conforto e segurança, embora, em muitos casos, sejam descritos como ainda experimentais e com barreiras à adoção clínica (Ibrahim et al., 2024; Young et al., 2023).

INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS NO PROJECTO

A passagem de dados antropométricos para critérios de projecto ocorre por diferentes vias analíticas:

- Dimensionamento estatístico por percentis e avaliação de incompatibilidades dimensionais: método típico no design ergonómico para definir dimensões que acomodam uma percentagem da população; aplicado sobretudo a produtos de uso “externo” (por exemplo, cadeiras de rodas e interfaces).

- Métodos multivariados e aprendizagem estatística: usados quando se trabalha com dados de alta dimensionalidade (malhas, secções, nuvens de pontos), permitindo extrair padrões de retificação ou modos de variação.

- Modelos preditivos e modelação estatística de forma (SSM): aplicados para reconstruir a geometria a partir de medições reduzidas e inferir relações entre a superfície e a anatomia interna, com análise de componentes principais (PCA) e regressões como ferramentas frequentes, embora limitados por tamanhos amostrais reduzidos em vários estudos (Sunderland et al., 2024).

Em design protésico, a aplicação mais crítica recai sobre o encaixe e as zonas de contacto, onde a geometria capturada é submetida a processos de retificação (diferenças propositadas entre o corpo e o dispositivo) e, depois, validada por critérios de conforto e de interface. A literatura é explícita ao considerar a captura dimensional/geométrica do membro como etapa decisiva para a qualidade do encaixe (Kannenberg et al., 2024; Young et al., 2023).

EVIDÊNCIA POR TIPO DE DISPOSITIVO

Embora os princípios sejam transversais, a literatura evidencia diferenças por tipo de dispositivo:

- Encaixes protésicos e ortóteses: forte ênfase na digitalização 3D, na análise quantitativa de malhas e na validação através de métricas de interface e/ou de simulação por elementos finitos (FEA). Em fluxos digitais

de fabrico, verificam-se diferenças geométricas relevantes entre soluções manuais e digitais, reforçando que a digitalização implica uma transformação do próprio processo de ajuste e pode alterar o resultado final (Kannenberget al., 2024; Silva et al., 2024).

– Próteses de membro superior: coexistência de tomografia computadorizada (CT), scanners comerciais e fotogrametria como métodos de captura; estudos comparativos indicam que medições obtidas por digitalização 3D podem ser fiáveis e consistentes face a métodos tradicionais quando bem implementadas. Destacam-se também fluxos automatizados que adaptam modelos CAD inteligentes a dados de digitalização, reduzindo o intervalo entre a captura anatómica e a obtenção de um modelo pronto para fabrico (Chainando et al., 2025; Çıklaçandır et al., 2022).

– Produtos de assistência definidos por zonas de alcance funcional (ex.: cadeiras de rodas e acessórios): a antropometria é frequentemente operacionalizada como critério de posicionamento e de acessibilidade, com mapeamentos de alcance e critérios percentílicos.

LIMITAÇÕES, LACUNAS E RECOMENDAÇÕES

Apesar do avanço metodológico, a literatura identifica limitações consistentes: amostras pequenas em estudos aplicados, inconsistência no registo das etapas de retificação e de pós-processamento e falta de validação em contexto real e de longo prazo.

Um problema estrutural particularmente relevante para o design inclusivo é a escassez de bases de dados antropométricas normalizadas para pessoas com deficiência, o que dificulta estimativas de acomodação e pode perpetuar desajustes de design em populações sub-representadas (Bradtmiller, 2022).

Como orientação prática, emergem recomendações claras: seleccionar o método de medição em função da questão de design — captura de forma, monitorização de volume ou validação de interface —, garantir a consistência da medição através de posturas padronizadas e da marcação coerente dos pontos de referência anatómicos, e utilizar bases de dados antropométricas alinhadas com a população-alvo quando se pretende definir critérios de acomodação e ajuste (ASTM International, 2024; Ibrahim et al., 2024).

Acresce a recomendação de distinguir o ajuste estático (em posturas padronizadas) do ajuste dinâmico (durante a amplitude de movimento funcional), reconhecendo que ajuste e conforto são conceitos relacionados, mas não equivalentes (ASTM International, 2024).

ESTRUTURAÇÃO DE DADOS

A antropometria aplicada ao design protésico evoluiu para um paradigma digital centrado na captura e na interpretação tridimensionais, complementado por métricas de interface que aproximam a medição do desempenho real de uso. Esta abordagem favorece a integração entre dados dimensionais, CAD, parametrização e fabrico aditivo, abrindo caminho para fluxos de adaptação parcialmente automatizados. Contudo, a consolidação destas práticas exige procedimentos mais padronizados, amostras mais amplas, bases de dados antropométricas representativas e identificação clara da origem dos valores utilizados (Bradtmiller, 2022; Sunderland et al., 2024).

No contexto desta investigação, esta necessidade foi operacionalizada através da construção de uma base local consolidada de medidas da mão e do membro superior distal. A descrição detalhada da selecção das

fontes, da extracção dos valores, da normalização dos dados e da sua tradução para parâmetros de projecto é retomada no Capítulo 4, onde esses dados deixam de funcionar apenas como enquadramento teórico e passam a integrar a metodologia de desenvolvimento do modelo paramétrico.

2.6 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PROCESSO DE DESIGN

A integração de Inteligência Artificial (IA) no design tornou-se um tema central devido ao surgimento de novas ferramentas e à alteração da relação entre criatividade, análise, decisão e automatização. Contudo, a rápida disseminação do termo «IA» também gerou alguma imprecisão conceptual. Em muitos contextos, a mesma designação é usada para sistemas de previsão, algoritmos de optimização, modelos generativos e interfaces conversacionais, embora estes mecanismos tenham funções e modos de operação distintos. Numa dissertação de Design Industrial, importa começar por uma clarificação introdutória: esta secção explica, de forma acessível, o que é a IA, como funciona em termos gerais, que formas assume no design e por que razão deve ser entendida como instrumento de apoio sujeito à decisão do designer (Choudhury et al., 2025; Saeidnia & Ausloos, 2024; Yüksel et al., 2023).

Para efeitos de enquadramento, a Figura 2.6 é útil porque mostra a IA não como um bloco monolítico, mas como uma camada integrada num fluxo CAD mais amplo, em que a recolha de dados, a modelação, a optimização e a avaliação permanecem articuladas com a decisão projectual.

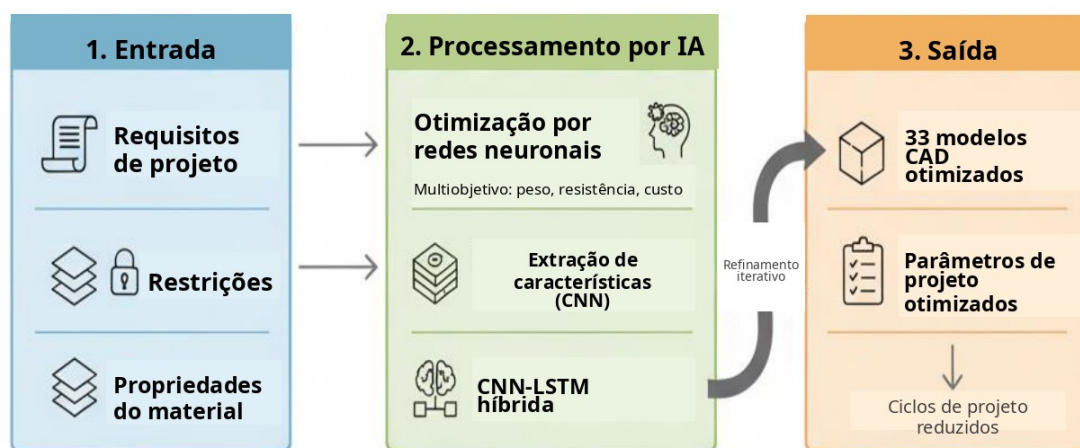


Figura 2.6 — Enquadramento de um fluxo de CAD apoiado por IA para desenvolvimento de produto.

Adaptado de Menaka, S., Raja, A. W., Ramakrishnan, S., Karthikeswaran, D., Sridar, K., & Sivaranjani, T. (2025). AI-driven computer-aided design (CAD) systems: Leveraging neural networks for optimized engineering product development. *International Journal of Applied Mathematics*, 38(5s).

O QUE É A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

De forma ampla, a IA pode ser entendida como um conjunto de métodos computacionais orientados para executar tarefas que requerem aprendizagem, reconhecimento de padrões, inferência ou geração de respostas com base em dados. Neste contexto, inferência designa o processo pelo qual um sistema aplica padrões aprendidos durante o treino a novos dados de entrada, produzindo uma classificação, previsão, recomendação ou resposta compatível com esses padrões. Esta definição evita tratar a IA como uma entidade única ou como sinónimo de inteligência humana generalizada. A maioria dos sistemas actuais opera sobre tipos específicos de

problemas a partir de exemplos, regularidades e relações estatísticas aprendidas durante o treino, sem possuir uma capacidade geral de pensamento (Choudhury et al., 2025; Yüksel et al., 2023).

Dentro deste campo, a aprendizagem automática designa as abordagens em que o sistema aprende a partir de dados, em vez de depender exclusivamente de regras explicitamente escritas. A aprendizagem profunda corresponde a um subconjunto desta família e baseia-se em redes neuronais artificiais com múltiplas camadas, particularmente adequadas para tratar dados complexos, como imagens, texto ou som. Já a IA generativa refere-se a modelos capazes de produzir novos conteúdos — por exemplo, texto, imagens, composições formais ou variantes de projecto — com base nos padrões que aprenderam. Esta distinção é particularmente importante para o design, pois diferentes tipos de IA apoiam diferentes tipos de tarefas: algumas ajudam a analisar, outras a prever, outras a otimizar e outras ainda a gerar alternativas (Khanolkar et al., 2023; Krahe et al., 2020; Li et al., 2021).

COMO FUNCIONA: DADOS, TREINO, INFERÊNCIA E GERAÇÃO

O funcionamento básico da maioria dos sistemas actuais de IA pode ser explicado em quatro etapas: dados, treino, inferência e, em certos casos, geração. Em primeiro lugar, o sistema necessita de dados de entrada, isto é, exemplos a partir dos quais possa aprender padrões. Em segundo lugar, durante o treino, o modelo ajusta os seus parâmetros internos para captar padrões recorrentes nos dados. Em terceiro lugar, após o treinamento, o modelo passa a realizar inferência, produzindo previsões, classificações, recomendações ou respostas a novos casos. Em modelos generativos, há ainda um quarto momento: a produção de novos conteúdos compatíveis com os padrões aprendidos, em vez de simples classificação ou previsão (Ao et al., 2025; Menaka et al., 2025; Panchal et al., 2019).

Esta lógica distingue a IA contemporânea dos sistemas puramente baseados em regras. Num sistema baseado em regras, o comportamento é prescrito antecipadamente: se ocorrer determinada condição, executa-se determinada acção. Num sistema treinado com dados, pelo contrário, o comportamento emerge da exposição a exemplos. Esta diferença ajuda a explicar a sua força e fragilidade. A força reside na capacidade de lidar com grande complexidade, diversidade e volume de informação. A fragilidade resulta da dependência dos dados de treino, que podem conter enviesamentos, simplificações e erros reproduzidos pelo sistema (Panchal et al., 2019; Yüksel et al., 2023).

Nos modelos generativos, este processo torna-se particularmente visível. O sistema aprende distribuições de forma, linguagem, composição ou estilo e, a partir daí, produz novas saídas em resposta a condições ou prompts. Isto permite criar imagens, textos ou alternativas formais que não existiam previamente naquela forma exacta. O resultado pode parecer coerente e ainda assim ser inadequado, derivativo ou tecnicamente frágil. Para o design, esta distinção é decisiva: gerar muitas alternativas não equivale a resolver bem o problema de projecto (Burnap et al., 2019; Choudhury et al., 2025; Li et al., 2021).

FORMAS DE IA MAIS RELEVANTES PARA O DESIGN

A literatura identifica várias famílias de aplicações da IA com relevância directa para o design. Uma primeira família é a do apoio à decisão, na qual sistemas analíticos ajudam a interpretar grandes volumes de informação, a comparar alternativas e a reduzir a carga cognitiva em problemas multivariados. Uma segunda

é a optimização, particularmente importante na engenharia de produto, na parametrização e no fabrico, na qual algoritmos exploram combinações possíveis e sugerem soluções com melhor desempenho estrutural, funcional ou produtivo. Uma terceira é a visão por computador, usada quando o sistema precisa interpretar imagens, formas ou padrões visuais. Uma quarta é o processamento de linguagem natural, que permite interagir com sistemas complexos por meio de descrições semânticas, em vez de comandos técnicos rígidos. Finalmente, a quinta família, hoje mais visível, corresponde aos sistemas generativos capazes de produzir texto, imagem, forma ou variantes de projecto em resposta a condições de entrada (Ao et al., 2025; Khanolkar et al., 2023; Wang & Hu, 2024).

Para o Design Industrial, estas famílias não têm exatamente o mesmo peso. A IA generativa tornou-se especialmente relevante na ideação, na comunicação visual e na rápida exploração de alternativas. A optimização e os modelos preditivos assumem maior importância quando o problema envolve desempenho, simulação, restrições de fabrico ou espaços paramétricos amplos. Já o processamento de linguagem natural ganha interesse crescente enquanto camada de acesso a sistemas mais complexos, sobretudo quando se pretende que utilizadores menos especializados consigam formular intenções ou restrições sem depender de software CAD avançado ou de uma sintaxe demasiado técnica (Ao et al., 2025; Menaka et al., 2025; Wang & Hu, 2024).

IA AO LONGO DO PROCESSO DE DESIGN

Uma das conclusões mais consistentes da literatura é que a IA não atua apenas numa fase isolada do processo projectual. Nas fases iniciais, pode apoiar a pesquisa, a síntese de informação e o enquadramento do problema, ajudando a identificar padrões nas necessidades dos utilizadores, tendências, dados de mercado ou requisitos de contexto. Na ideação, pode ampliar o espaço de procura, reduzir fixação prematura e produzir rapidamente múltiplas alternativas de partida. No desenvolvimento, pode acelerar a iteração, gerar variantes paramétricas e articular a exploração formal às restrições técnicas. Em fases posteriores, pode apoiar a prototipagem, a simulação, a previsão de desempenho e a comparação entre opções concorrentes. Também pode reforçar a comunicação e a documentação, produzindo representações mais rápidas de cenários, conceitos e soluções (Khanolkar et al., 2023; Saeidnia & Ausloos, 2024; Verganti et al., 2020).

A eficácia da IA varia consoante a etapa do processo de design. A literatura sugere que o seu valor tende a ser maior em tarefas de exploração divergente, análise extensiva e automatização parcial, enquanto as etapas de convergência, enquadramento contextual, decisão ética e validação final exigem avaliação humana qualificada. A IA pode ampliar o campo de exploração e acelerar a comparação entre alternativas, mas a decisão sobre o que faz sentido desenvolver, para quem, em que contexto e com que consequências permanece uma responsabilidade humana. (Ao et al., 2025; Choudhury et al., 2025; Virós-i-Martin & Selva, 2021).

PAPEL DO DESIGNER, RISCOS E NECESSIDADE DE SUPERVISÃO HUMANA

A integração da IA no processo de design exige uma redefinição do papel do designer, sobretudo quando a geração de alternativas, a análise de dados ou a sugestão de soluções passam a ser parcialmente mediadas por sistemas computacionais. Neste contexto, a questão central desloca-se da autoria formal para a capacidade de orientar, interpretar e avaliar criticamente os resultados produzidos. A literatura consultada descreve, assim,

uma evolução do designer enquanto gerador exclusivo de forma para um papel mais híbrido, no qual assume funções de orientação, curadoria, interpretação e decisão estratégica. O papel humano torna-se particularmente exigente em tarefas como a formulação do problema, a definição de critérios, a leitura contextual, a selecção entre alternativas e a justificação das decisões. Esta transformação é especialmente relevante em domínios sensíveis, nos quais a adequação ao utilizador, a responsabilidade técnica e a aceitabilidade ética exigem supervisão humana qualificada (Figoli et al., 2022; Kadenhe et al., 2025; Virós-i-Martin & Selva, 2021).

É também neste ponto que emergem os principais riscos. Um primeiro risco é o enviesamento, já que modelos treinados com dados históricos ou desequilibrados podem reproduzir exclusões, preferências dominantes e padrões culturais pouco representativos. Um segundo risco é a opacidade: muitos sistemas produzem resultados eficazes, mas são difíceis de explicar em termos do seu raciocínio interno, o que dificulta a confiança e a responsabilização. Um terceiro risco é o erro, incluindo respostas aparentemente coerentes, mas incorrectas, simplificações abusivas e sugestões sem fundamento técnico suficiente. A estes somam-se riscos de dependência excessiva, homogeneização formal, enfraquecimento de competências críticas e incerteza quanto à autoria e originalidade dos resultados produzidos com apoio algorítmico (Burnap et al., 2019; Panchal et al., 2019; Yüksel et al., 2023).

Por estas razões, a literatura converge para a defesa de modelos com supervisão humana explícita. A integração mais robusta da IA não assenta em autonomia plena, mas em ciclos apoiados, em que o sistema acelera a análise, a geração ou a previsão e o humano mantém autoridade sobre critérios, validação e consequências da decisão. Em termos práticos, isto implica preservar mecanismos de controlo, a comparação entre alternativas, a explicitação de limites, a verificação técnica e a capacidade de recusar ou reformular sugestões produzidas pela máquina. Em design, a supervisão humana não é um complemento opcional; é a condição que transforma a IA em instrumento projectual e não em fonte acrítica de soluções aparentes (Ao et al., 2025; Kadenhe et al., 2025; Verganti et al., 2020).

2.7 PLATAFORMAS DIGITAIS E SISTEMAS CONFIGURÁVEIS

A evolução recente do desenvolvimento de produto, particularmente em contextos de saúde e de tecnologias de apoio, tem sido acompanhada pelo crescimento de plataformas digitais configuráveis e de sistemas participativos orientados para a personalização. A literatura caracteriza estes sistemas como infraestruturas sociotécnicas que articulam três dimensões principais: enquadramentos conceptuais que legitimam e estruturam a participação dos utilizadores; recursos técnicos de personalização, como parametrização, modularidade e interfaces de configuração; e fluxos participativos que traduzem a experiência vivida em requisitos, protótipos e iterações de projecto. (Fischer et al., 2004; Hippel & Katz, 2002; Howard et al., 2022).

Em domínios como a reabilitação e as tecnologias de apoio, a personalização é frequentemente descrita como uma necessidade funcional, distinta da diferenciação de mercado. A adequação do produto ao utilizador pode ser determinante para a segurança, a usabilidade e a adopção sustentada, deslocando o foco do design de uma solução «média» para sistemas capazes de acomodar diferenças individuais de forma controlada (Fischer et al., 2017; Kerr et al., 2024; Zhu & Zhong, 2022).

FUNDAMENTOS CONCEITUAIS: TOOLKITS, META-DESIGN E END-USER DEVELOPMENT.

Uma linha teórica relevante é a dos “toolkits for user innovation”, que entende os sistemas configuráveis como ferramentas coordenadas e acessíveis que transferem parte do trabalho de design relacionado com as necessidades dos utilizadores, enquanto fabricantes e especialistas retêm tarefas de resolução e de produção. A distinção entre configuradores, centrados em seleccionar opções, e toolkits, centrados em desenhar dentro de um espaço de projecto delimitado, é central: a participação pode variar entre escolher alternativas predefinidas e criar configurações num ambiente com regras e resposta visual (Franke & Hippel, 2002; Hippel & Katz, 2002).

O meta-design aprofunda esta lógica ao defender a participação “em uso”, estabelecendo condições técnicas e sociais para que os utilizadores se tornem co-designers e o sistema evolua ao longo do tempo. O modelo Seeding, Evolutionary Growth, and Reseeding formaliza este processo como alternância entre “sementes” iniciais, criadas por especialistas, evolução por meio do desenvolvimento do utilizador e reestruturações periódicas que consolidam as aprendizagens e reorganizam o sistema (Costabile et al., 2007; Fischer et al., 2004).

Para enquadrar estes fundamentos de forma mais operacional, a Figura 2.7 mostra um modelo de configuração da participação em living labs, útil porque desloca a discussão da participação como princípio abstrato para a participação como estrutura desenhável.

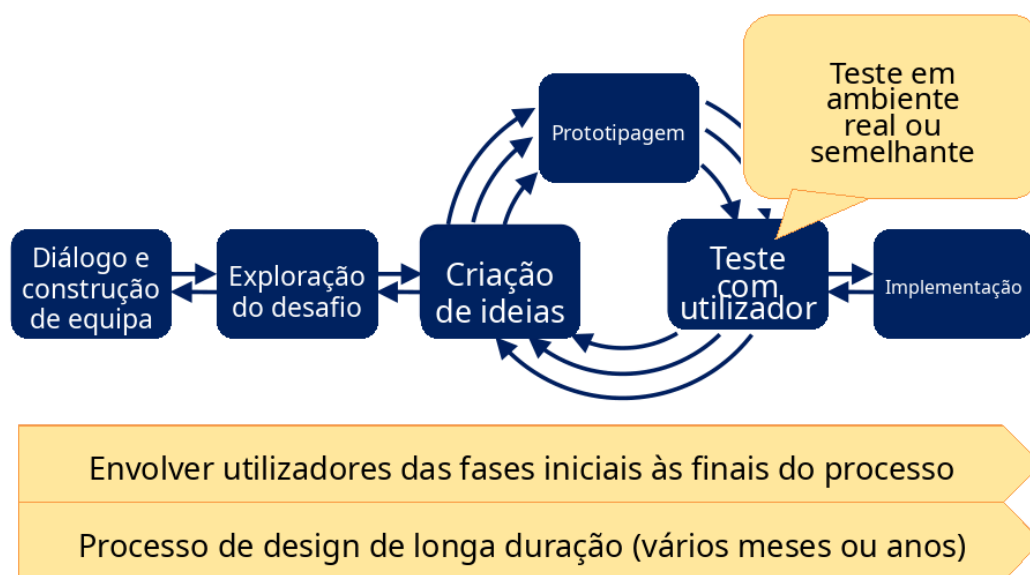


Figura 2.7 — Modelo de processo para configurar participação em ecossistemas de inovação e cocriação.

Fonte original: Akasaka, M., Veeckman, C., Georges, A., Schuurman, D., & Coorevits, L. (2022). A framework for configuring participation in living labs.

<https://www.semanticscholar.org/paper/305d55af5fda06b4d1b33e7d29c1f16d1b7ea488>
(<https://www.semanticscholar.org/paper/305d55af5fda06b4d1b33e7d29c1f16d1b7ea488>)

A literatura identifica, contudo, o risco de sobrecarga participativa, entendido como a transferência excessiva de trabalho, responsabilidade e decisão para os utilizadores. Este risco exige mecanismos de apoio, curadoria e reutilização que tornem a participação sustentável (Fischer et al., 2017).

Em paralelo, o conceito de Software Shaping Workshop operacionaliza o meta-design, entendido como uma abordagem que cria condições técnicas e sociais para que utilizadores finais participem ativamente na adaptação e evolução dos sistemas que utilizam. Neste enquadramento, o Software Shaping Workshop funciona como uma “oficina virtual”: um ambiente digital composto por ferramentas familiares, ajustadas à cultura, às práticas e às competências de uma comunidade específica. Em contextos de reabilitação e assistência, este paradigma manifesta-se em sistemas que fornecem a cuidadores e terapeutas interfaces do tipo editor, permitindo adaptar scripts, exercícios e conteúdos sem necessidade de programação especializada, respondendo de forma pragmática às necessidades de personalização (Costabile et al., 2007; Fischer et al., 2017).

Esta transição entre princípio e operação pode ser resumida pelos elementos nucleares apresentados na Tabela 2.2, que sistematiza dimensões recorrentes no desenho de participação mediada: quando participar, quem participa, por quais canais, através de quais pontos de contacto e com que mecanismos de motivação.

Tabela 2.2 — Elementos centrais na configuração da participação em sistemas configuráveis

Elemento	Questão orientadora
Participantes	Que perfis participam, em que número e com que papel
Formato	Que canais, espaços e métodos suportam a colaboração
Contacto	Como se recrutam participantes e como se mantém a relação
Gestão da motivação	Que factores promovem adesão e que barreiras dificultam continuidade

Fonte adaptada. Referência original: Akasaka, M., Veeckman, C., Georges, A., Schuurman, D., & Coorevits, L. (2022). A framework for configuring participation in living labs.

<https://www.semanticscholar.org/paper/305d55af5fda06b4d1b33e7d29c1f16d1b7ea488>
<https://www.semanticscholar.org/paper/305d55af5fda06b4d1b33e7d29c1f16d1b7ea488>

MECANISMOS DE PERSONALIZAÇÃO: MODULARIDADE, PARAMETRIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO INDIVIDUALIZADA

A literatura sintetiza a personalização por meio de mecanismos recorrentes que diferem quanto a “quem configura”, “o que é configurável” e “quando se configura”. Três mecanismos destacam-se pela relevância para sistemas protésicos e dispositivos médicos personalizados:

1. Seleção modular de componentes: a personalização é obtida através da combinação de módulos interoperáveis, permitindo adaptar a funcionalidade através de combinações e substituições. A modularidade surge como estratégia para conciliar personalização, reutilização e expansão em ecossistemas de produto (Dechev et al., 2023; Peters & Richter, 2023).

2. Configuração paramétrica: o utilizador, ou um intermediário clínico, fornece entradas num espaço de parâmetros e o sistema gera automaticamente artefactos de design, como ficheiros CAD, com base nesses valores. Este mecanismo é mais adequado quando a personalização depende de atributos mensuráveis, ligando

diretamente dados antropométricos e cinemáticos a variáveis de projecto (Kuhl et al., 2020; Zhu & Zhong, 2022).

3. Tailoring por toolkit/editor: a personalização ocorre em tempo de uso, permitindo editar conteúdos, instruções, rotinas de treino ou componentes informacionais associados ao produto ou serviço. Em saúde, este mecanismo é particularmente relevante em plataformas de reabilitação e de telereabilitação, nas quais a adaptação de exercícios e de objectivos faz parte do cuidado contínuo (Cole, 2011; Fischer et al., 2017).

A selecção do mecanismo mais adequado depende da forma como o conhecimento relevante se distribui entre utilizadores, designers, profissionais técnicos ou clínicos e sistemas digitais. A modularidade é adequada quando as necessidades podem ser expressas através da combinação de módulos previamente definidos; a parametrização torna-se mais eficaz quando existem dados mensuráveis que podem ser traduzidos em variáveis de projecto; e os kits de ferramentas são particularmente relevantes quando a adaptação contínua em contexto é crítica e quando o utilizador ou um intermediário dispõe de conhecimento situado para ajustar o sistema. (Hippel & Katz, 2002; Peters & Richter, 2023; Zhu & Zhong, 2022).

FLUXOS PARTICIPATIVOS E INFRA-ESTRUTURAS REMOTAS

Uma característica transversal é o recurso crescente à participação remota e aos processos mediados por meios digitais. A literatura documenta sessões de co-design por videoconferência, oficinas online e processos de co-fabrico à distância, em que o ciclo «definir → prototipar → fabricar → testar» ocorre com envio de protótipos para experimentação no contexto real do utilizador. Estes modelos são particularmente relevantes em tecnologias de apoio, nas quais a avaliação em contexto e a adaptação iterativa são determinantes para a adequação funcional e a aceitação (Dexter et al., 2013; Thorsen et al., 2023).

No entanto, a literatura sublinha que a tecnologia, por si só, não é suficiente. A eficácia destes sistemas depende de estruturas de governação, isto é, da definição clara de quem decide, o que decide e em que momento do processo. Depende igualmente da mediação exercida por clínicos, designers ou técnicos, bem como de mecanismos que permitam gerir a carga de trabalho, a comunicação e a coordenação entre intervenientes. Em modelos abertos e distribuídos, podem surgir riscos de incumprimento de compromissos e atrasos decorrentes da ausência de responsabilização clara, o que exige a definição explícita de regras, expectativas e responsabilidades. (Frangos et al., 2016; Hussaini et al., 2023; Kerr et al., 2024).

APLICAÇÕES EM SAÚDE, REABILITAÇÃO E PRÓTESES

Em saúde, plataformas baseadas em digital twins são descritas como sistemas de serviço personalizados que ligam participantes através da nuvem, integrando sensores, parâmetros de movimento e métricas de desempenho. Embora apresentem correlações elevadas em cenários controlados, a literatura assinala degradação de desempenho em contextos mais complexos, revelando diferenças entre os modelos e o movimento humano real. Estes sistemas mostram o potencial de integrar personalização, fabrico digital e monitorização remota, mas deixam claro que a robustez do modelo depende da qualidade dos dados e da diversidade dos cenários de uso (Mikołajewski et al., 2023; Zhu & Zhong, 2022).

Na reabilitação, plataformas de virtual coaching, serious games configuráveis e modelos de cocriação tecnológica são apresentados como formas de personalizar os tratamentos com base no estado clínico, nos

objectivos terapêuticos e no feedback do utilizador. As avaliações indicam boa usabilidade e experiência do utilizador quando a participação é integrada no ciclo de desenvolvimento e abrangem a interface, a selecção de exercícios, o ritmo do programa e a mediação por profissionais de saúde (Cole, 2011; Kerr et al., 2024; Seregni et al., 2021).

No contexto protésico e das tecnologias de apoio, evidencia-se a relevância dos ecossistemas modulares e das cadeias de aprendizagem distribuída. Estudos sobre próteses pediátricas, serviços de reabilitação e modelos como o Victoria Hand Project mostram que a personalização pode combinar prototipagem iterativa, módulos intercambiáveis, criação digital de encaixes e circulação de comentários entre locais clínicos e equipas centrais de desenvolvimento. Neste enquadramento, a plataforma funciona como interface de configuração e infraestrutura organizacional de aprendizagem e actualização contínua (Dechev et al., 2023; Howard et al., 2022; Sims et al., 2017).

Em contextos de baixos recursos, a literatura reforça que a impressão 3D pode ser um facilitador importante, mas só produz benefícios quando integrada a infraestruturas de apoio, confiança, manutenção e capacitação técnica. A simples disponibilização de tecnologia de fabrico não garante soluções adequadas nem adoção sustentada, pelo que os modelos participativos e a mediação local assumem um papel determinante na tradução do potencial técnico em valor real para os utilizadores (Hussaini et al., 2023; Thorsen et al., 2023).

LIMITAÇÕES E LACUNAS: SUSTENTABILIDADE, ADOÇÃO E EQUILÍBRIO ENTRE NORMALIZAÇÃO E IMPROVISO

Apesar do potencial das plataformas configuráveis e dos fluxos participativos para apoiar a personalização de dispositivos médicos e tecnologias de apoio, a evidência empírica disponível baseia-se frequentemente em amostras reduzidas e em estudos de caso, o que limita a generalização dos resultados (Frangos et al., 2016; Howard et al., 2022; Thorsen et al., 2023). A literatura identifica ainda três tensões estruturais relevantes.

A primeira diz respeito à sustentabilidade da participação: processos participativos prolongados ou mal distribuídos podem gerar sobrecarga, fadiga e eventual desistência por parte dos utilizadores, exigindo mecanismos de apoio, curadoria e redistribuição da carga entre utilizadores, especialistas e intermediários técnicos ou clínicos (Fischer et al., 2017).

A segunda tensão situa-se entre normalização e personalização. Em domínios regulamentados, a adaptação individualizada deve preservar o registo da origem das decisões, a segurança e a qualidade, o que pode entrar em conflito com ajustamentos locais necessários para responder a necessidades específicas ou contextuais (Costabile et al., 2007; Fischer et al., 2004).

A terceira tensão relaciona-se com a adoção e o valor efetivamente realizado. A literatura sobre personalização em massa regista dificuldades recorrentes na conversão e adoção de configuradores; por analogia, em contextos de saúde e de tecnologias de apoio, a configurabilidade não garante aceitação sem alinhamento com expectativas, confiança dos intervenientes e integração nos serviços existentes (Akasaka et al., 2022; Frangos et al., 2016).

2.8 ANÁLISE CRÍTICA DO ESTADO DA ARTE E LACUNAS IDENTIFICADAS

A distância entre o potencial técnico destas abordagens e a sua consolidação prática torna-se particularmente visível quando se analisam os níveis de prontidão tecnológica descritos na literatura. A Figura 2.8 apresenta a distribuição dos estudos por nível de prontidão tecnológica, ou Technology Readiness Level (TRL), evidenciando que muitos contributos permanecem concentrados em fases ainda afastadas de uma adoção ampla e sustentada.

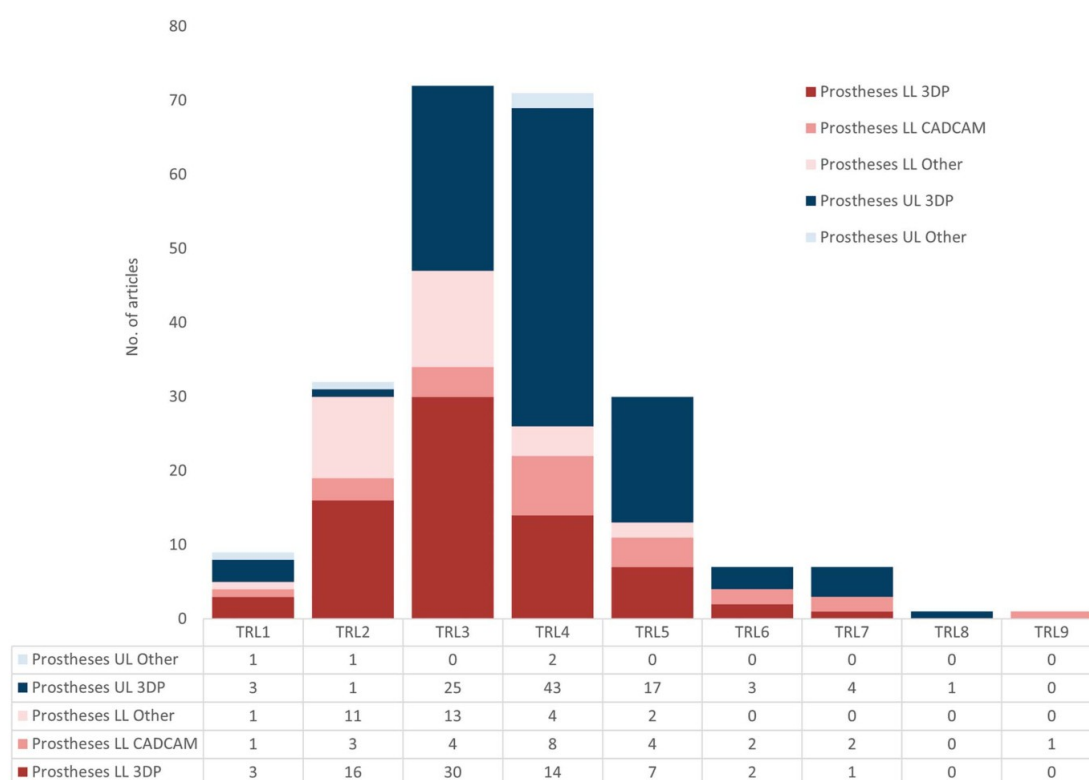


Figura 2.8 — Distribuição dos estudos por nível de prontidão tecnológica (TRL) e categoria de aplicação. O gráfico distingue estudos sobre próteses em geral, próteses de membro inferior produzidas por impressão 3D (LL 3DP), próteses de membro inferior desenvolvidas com recurso a CAD/CAM (LL CAD/CAM), outras abordagens aplicadas ao membro inferior (LL other), próteses de membro superior produzidas por impressão 3D (UL 3DP) e outros casos não enquadrados nas categorias anteriores.

Fonte original: Chainando, N., Faephu, C., Suwaphong, N., Bureerat, S., Limphirat, W., Thammajarak, P., & Syafrudin, M. (2025). Applying 3D scanning and printing techniques to produce upper limb prostheses: Bibliometric analysis and scoping review. *Prosthesis*, 7(2), 26. <https://www.mdpi.com/2673-1592/7/2/26/pdf?version=1740996517>

A síntese das secções anteriores evidencia avanços técnicos significativos e limitações estruturais persistentes na investigação e no desenvolvimento de próteses e de tecnologias de apoio. Um tema transversal é o desfasamento entre o desenvolvimento tecnológico e a sua validação empírica. Muitos contributos permanecem em fase de protótipo, com testes realizados em amostras reduzidas e por períodos curtos, o que limita a demonstração da sua eficácia, segurança e adequação em contextos reais de utilização (Chadwell et al., 2020; Samuelsson et al., 2012; Windrich et al., 2016).

A predominância de estudos com amostras reduzidas, curta duração e validação limitada dificulta a comparação entre soluções, a generalização de conclusões e a tradução de melhorias laboratoriais em benefícios consistentes na vida quotidiana. (Hafner & Sawers, 2016; Samuelsson et al., 2012).

LACUNA 1 — VALIDAÇÃO EMPÍRICA LIMITADA E FRACA TRANSPOSIÇÃO PARA CONTEXTOS REAIS DE UTILIZAÇÃO

A revisão da literatura aponta repetidamente para a ausência de estudos comparativos consistentes e de ensaios clínicos que confrontem dispositivos avançados com soluções convencionalmente prescritas, particularmente no caso de próteses activas e externamente alimentadas. Em vários subdomínios, observa-se uma dependência significativa de protótipos e de amostras reduzidas, o que limita as inferências sobre eficácia, segurança e valor clínico. Em paralelo, predominam avaliações laboratoriais e tarefas pouco representativas, que não captam adequadamente o desempenho em contextos reais de utilização, marcados pela diversidade de ambientes, objectos manipulados e exigências funcionais (Ghillebert et al., 2019; Samuelsson et al., 2012; Windrich et al., 2016).

Esta lacuna é particularmente relevante porque a adaptação, a aprendizagem e o eventual abandono de uma prótese ocorrem ao longo do tempo e em contextos quotidianos, como o trabalho, a habitação e o espaço público. Quando a evidência disponível se baseia em períodos de observação curtos, torna-se difícil compreender trajetórias de adoção, padrões de uso e o surgimento progressivo de problemas relacionados com conforto, manutenção ou integração funcional (Chadwell et al., 2020; Samuelsson et al., 2012).

LACUNA 2 — DESALINHAMENTO ENTRE NECESSIDADES IDENTIFICADAS, MÉTRICAS OBJETIVAS, E QUALIDADE DE VIDA

A literatura evidencia uma articulação insuficiente entre as necessidades expressas pelos utilizadores, como conforto, controlo intuitivo, aparência e participação social; os indicadores objectivos habitualmente medidos, como desempenho em testes funcionais, parâmetros biomecânicos e métricas instrumentadas de uso da prótese; e os resultados finais desejáveis, como autonomia e qualidade de vida. As revisões salientam que estas necessidades são contextuais e interdependentes, e que as medições laboratoriais nem sempre refletem tarefas relevantes do quotidiano, contribuindo para contradições entre resultados subjetivos e objectivos (Cordella et al., 2016; Manz et al., 2022).

Esta desarticulação tem implicações directas para o design. A existência de métricas ecologicamente válidas e sensíveis às prioridades do utilizador é essencial para orientar decisões de projecto para benefícios significativos e sustentados. Como consequência, melhorias técnicas isoladas podem produzir ganhos limitados em termos de aceitação, integração funcional ou uso continuado da prótese (Manz et al., 2022; Samuelsson et al., 2012).

LACUNA 3 — PERSISTÊNCIA DE PROBLEMAS NA INTERFACE CORPO-PRÓTESE E NO AJUSTE INDIVIDUALIZADO

Apesar dos avanços em componentes técnicos e sistemas de controlo, a literatura continua a identificar a interface corpo-prótese como um ponto crítico ainda insuficientemente resolvido. Problemas de ajuste, desconforto, irritação cutânea e dificuldade de adaptação persistem como factores determinantes de insatisfação e abandono. Nas revisões analisadas, a personalização é frequentemente descrita como insuficiente ou metodologicamente frágil, sendo a evidência difícil de sintetizar devido à heterogeneidade das intervenções e ao registo incompleto dos processos e resultados (Alluhydan et al., 2023; Baldock et al., 2023; Richardson & Dillon, 2017).

Um aspecto estruturante desta lacuna é a ausência de fluxos metodológicos consistentes e acessíveis que articulem medição, decisão de projecto e validação. Esta ausência dificulta a utilização de dados objectivos para orientar ajustes individualizados. Mesmo quando são propostas soluções baseadas em sensores e na monitorização do uso, persistem barreiras práticas, como o custo, a autonomia da bateria, a disponibilidade de equipamentos e a necessidade de formação técnica, o que limita a sua adoção como prática clínica regular (Chadwell et al., 2020; Richardson & Dillon, 2017).

LACUNA 4 — EVOLUÇÃO LIMITADA DAS ESTRATÉGIAS DE CONTROLO E DA INTERACÇÃO UTILIZADOR-PRÓTESE

No caso das próteses de membro superior, algumas revisões apontam para uma evolução limitada das estratégias de controlo em aplicações comerciais, marcada por uma progressão lenta desde as primeiras abordagens desenvolvidas no século XX. Persistem dificuldades relacionadas com a robustez dos sistemas e com a sua transferência entre cenários laboratoriais e contextos reais de utilização, bem como desafios associados ao esforço cognitivo, ao tempo de aprendizagem e à inconsistência do desempenho em situações quotidianas (Cordella et al., 2016; Marinelli et al., 2022).

Esta lacuna não é apenas técnica. Reflete também uma conceptualização ainda insuficiente da interacção utilizador-prótese enquanto sistema integrado, no qual controlo, informação sensorial, treino e contexto de uso devem ser considerados de forma articulada (Domínguez-Ruiz et al., 2023; Marinelli et al., 2022).

LACUNA 5 — ACESSO, CUSTO, MANUTENÇÃO E INEQUIDADES SISTÉMICAS

A acessibilidade surge como um constrangimento central e persistente, tanto em contextos de baixos recursos quanto em sistemas de saúde mais robustos. Revisões identificam barreiras associadas a custos elevados, à necessidade de formação especializada, a atrasos na prestação de cuidados e a pressões sistémicas que levam os utilizadores a negociar intensivamente para obter soluções adequadas. Em contextos de baixos e médios rendimentos, enfatizam-se ainda problemas de durabilidade e de manutenção, com compromissos claros: soluções biomecanicamente mais sofisticadas podem ser mais frágeis e difíceis de manter, comprometendo a sustentabilidade do uso (Alluhydan et al., 2023; Andrysek, 2010; Baumann & Maria, 2023).

Assim, a inovação pode agravar as inequidades ao introduzir dependências de infraestrutura, de apoio técnico e de cadeias de fornecimento indisponíveis para uma parcela significativa da população (Andrysek, 2010; Segura et al., 2024).

LACUNA 6 — ENVOLVIMENTO DO UTILIZADOR E REGISTO METODOLÓGICO INSUFICIENTE

O envolvimento do utilizador permanece uma fragilidade metodológica e ética no desenvolvimento de próteses. As revisões relacionam processos pouco ajustados às necessidades individuais dos utilizadores com o abandono dos dispositivos e a dificuldade em responder a prioridades relevantes de uso. Em várias áreas, identifica-se ainda a ausência de métodos qualitativos sistemáticos para captar a experiência, a aceitação e os factores de rejeição, mesmo em componentes directamente associados ao conforto, como os revestimentos de interface. Esta limitação reduz a compreensão dos factores que condicionam a adopção, a continuidade de uso e a adequação da prótese à vida quotidiana (Marinelli et al., 2022; Richardson & Dillon, 2017; Walker et al., 2019).

Adicionalmente, a heterogeneidade metodológica e a ausência de critérios comuns de avaliação, como escalas partilhadas de utilidade e satisfação, dificultam a síntese dos resultados e a realização de meta-análises, mantendo o campo fragmentado e com baixa comparabilidade entre estudos (Cordella et al., 2016; Hafner & Sawers, 2016; Richardson & Dillon, 2017).

IMPLICAÇÕES PARA ESTA INVESTIGAÇÃO

Em conjunto, estas lacunas apontam para a necessidade de abordagens que:

- reforcem a ligação entre personalização e validação empírica, através de fluxos integrados de aquisição de dados, geração de variantes e avaliação;
- privilegiem avaliações ecologicamente válidas e longitudinais, aproximando as métricas de desempenho dos resultados relacionados com participação, autonomia e qualidade de vida;
- tratem a interface corpo-prótese e o conforto como requisitos estruturantes do processo de projecto, e não como ajustes posteriores;
- incorporem o envolvimento do utilizador como elemento contínuo, documentável e passível de análise, articulando métodos qualitativos e quantitativos;
- considerem a acessibilidade, a manutenção e o contexto de serviço como dimensões constitutivas do problema de design (Anderson et al., 2024; Baumann & Maria, 2023; Chadwell et al., 2020).

CAPÍTULO 3 — METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO E ABORDAGEM RESEARCH THROUGH DESIGN

A presente investigação é aplicada e segue o enquadramento de Research Through Design (RTD). Nesta abordagem, a concepção, a experimentação, a prototipagem e a reflexão crítica constituem actividades de investigação através das quais o artefacto permite formular e examinar conhecimento de projecto (Frayling, 1994; Zimmerman et al., 2007). O artefacto central é um protótipo de investigação: uma plataforma web que coordena modelos paramétricos de mão protésica, dados antropométricos, sugestões geradas por IA, visualização tridimensional e exportação para fabrico.

O conhecimento produzido decorre das relações e dos limites revelados durante a construção. A integração de modelos open source mostrou que cada família possui pressupostos dimensionais próprios; os ensaios de ponta a ponta revelaram falhas que a inspecção isolada dos valores não mostrava; e a impressão tornou visíveis condicionantes de orientação, escala, separação de peças e preparação. Estes resultados foram usados para reformular o sistema e, em seguida, voltar a examiná-lo. O RTD concretiza-se, assim, numa sequência explícita de situação problemática, decisão de design, artefacto, ensaio, resultado e alteração.

O modelo Double Diamond organiza os momentos de descoberta, definição, desenvolvimento e entrega, sem impor uma sequência linear. A sua função é estruturar a abertura e a convergência dos ciclos, enquanto o RTD enquadra a produção de conhecimento através desses ciclos (Design Council, 2020). A Tabela 3.1 apresenta as iterações técnicas com maior relevância para o argumento da dissertação.

Tabela 3.1 — Ciclos de Research Through Design documentados no desenvolvimento

Situação examinada	Artefacto ou ensaio	Resultado observado	Decisão incorporada
Preparação de modelos compostos para impressão	Exportação em placa nas versões 14.15.0 e seguintes	A posição montada originava peças suspensas ou exigia suportes desnecessários	Criação de modos de impressão planos e assentamento de cada peça em Z=0
Seleção de referência antropométrica	Ensaio com descrições, unidades e grupos etários, versão 14.16.0	Unidades como «mm» e «cm» podiam ser interpretadas como indicação de sexo masculino	Análise por palavras completas, reconhecimento multilingue e classificação etária
Propagação da largura da palma no Paraglider	Sugestão de IA, exportação e medição da malha, versão 14.17.0	Os dedos respondiam ao perfil, mas a palma permanecia na escala interna da biblioteca	Aplicação da escala no ponto de chamada da palma Reborn
Limite dimensional do UnLimbited Phoenix	Perfil infantil e exportação, versão	Um percurso alternativo aceitava uma	Aplicação do intervalo de 100% a

Situação examinada	Artefacto ou ensaio	Resultado observado	Decisão incorporada
	14.18.0	escala inferior ao mínimo definido pelo modelo	160% nos dois percursos de escala
Definição do lado da mão	Cenários repetidos de mão esquerda e direita, versões 14.19.0–14.20.0	A IA devolvevia mão direita em pedidos explícitos de mão esquerda	Lateralidade retirada do conjunto sugerível e controlada pela interface
Informação de cor no fabrico	Exportação 3MF, versão 14.22.0	O STL não preservava unidades e materiais por peça	Exportação 3MF com unidade em milímetros e materiais derivados das cores

A Figura 3.1 apresenta um precedente interdisciplinar que inclui avaliação clínica e participação de utilizadores. No presente estudo, a figura funciona como referência para um processo futuro mais amplo; essas actividades clínicas e participativas não foram executadas nesta investigação (Silva et al., 2018).

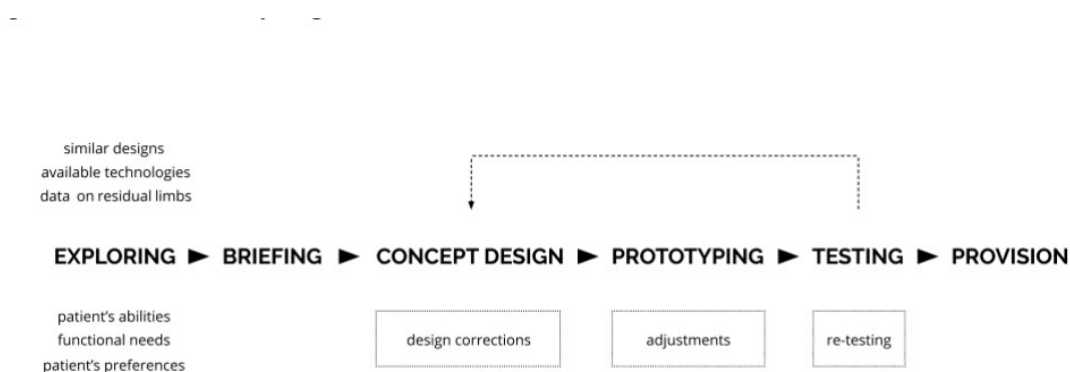


Figura 3.1 — Processo interdisciplinar de desenvolvimento de uma prótese de membro superior impressa em 3D.

Fonte original: Silva, L. A. da, Medola, F. O., Rodrigues, O. V., Rodrigues, A. C. T., & Sandnes, F. E. (2018). Interdisciplinary-based development of user-friendly customized 3D printed upper limb prosthesis. Comunicação em conferência.

3.2 O DESIGN INDUSTRIAL COMO PRÁTICA INVESTIGATIVA

O projecto parte do design industrial como campo de prática e investigação capaz de mediar inovação tecnológica, requisitos de fabrico e experiência humana. Esta perspectiva relaciona-se com os designerly ways of knowing, que reconhecem modos próprios de formular problemas e produzir conhecimento através da experimentação material, da geração de alternativas e da articulação de exigências técnicas e humanas (Cross, 1982). Nesta dissertação, essa mediação é examinada na tradução entre fontes antropométricas, parâmetros editáveis, regras geométricas, mensagens da interface e peças fabricadas.

O contributo de investigação decorre da explicitação dessas traduções e das falhas encontradas durante o desenvolvimento. O trabalho não demonstra desempenho clínico do dispositivo nem efeitos na experiência de pessoas amputadas. A dimensão humana é tratada como requisito e limite ético, com base na literatura, e permanece como matéria de estudo posterior com participantes.

A hipótese principal sustenta que a articulação entre dados antropométricos, design paramétrico, plataforma web e apoio de inteligência artificial permite estabelecer um fluxo técnico coerente para configurar, gerar, exportar e materializar variantes dos modelos seleccionados.

Três hipóteses secundárias orientam a avaliação: relações geométricas e limites explícitos oferecem maior controlo do que o escalonamento uniforme; sugestões de inteligência artificial limitadas pelo esquema do modelo podem fornecer pontos de partida úteis, desde que decisões críticas permaneçam sob regras e supervisão humana; e a passagem por malha, preparação para impressão e protótipo físico revela falhas que a análise isolada dos valores numéricos pode ocultar. Estas hipóteses dizem respeito ao protótipo e aos casos estudados. Adequação anatómica individual, usabilidade, conforto, aceitação, redução da dependência de especialistas e impacto em contextos com poucos recursos ficaram fora da avaliação.

3.3 ESTRUTURA METODOLÓGICA DO PROJECTO

A metodologia organiza-se em três fases interligadas. A fase conceptual reúne a revisão crítica da literatura, a análise de soluções open source e a definição dos requisitos. A fase de desenvolvimento estrutura a base antropométrica, integra os modelos OpenSCAD e implementa a plataforma e o módulo de IA. A fase de avaliação usa cenários simulados, registos de execução, malhas exportadas, perfis de preparação para impressão e protótipos físicos. Os resultados de cada fase regressam ao desenvolvimento através dos ciclos apresentados na Tabela 3.1.

Tabela 3.2 — Correspondência entre perguntas, actividades, evidência e limites

Pergunta de investigação	Actividades realizadas	Evidência produzida	Dimensões fora da avaliação
Apoio do design paramétrico e da IA à configuração preliminar	Definição de parâmetros, implementação da plataforma, cenários de IA, exportação e impressão	Regras documentadas, respostas JSON, malhas, correcções de escala e peças físicas	Ajuste individual, conforto e desempenho funcional em uso
Métodos para avaliar a coerência entre dados, parâmetros, geometria e protótipos	RTD, ensaios unitários do mecanismo de correspondência, cenários de ponta a ponta, inspecção geométrica e preparação para impressão	Registo de versões, 10 testes unitários aprovados na versão 14.67.0, relatórios de ensaio e três projectos de preparação	Ensaio mecânicos normalizados, séries controladas e avaliação clínica

Pergunta de investigação	Actividades realizadas	Evidência produzida	Dimensões fora da avaliação
Decisões de Design Industrial para articular os componentes do sistema	Revisão da literatura, selecção de parâmetros, separação de permissões, visualização e opções de cor	Decisões de arquitectura, grupos de parâmetros e exportação 3MF com materiais	Avaliação situada da interface e dos significados estéticos com os grupos previstos

A plataforma encontrava-se na versão 14.67.0 da branch staging no fecho desta revisão. Os ensaios antropométricos e geométricos principais foram realizados e documentados nas versões 14.16.0 a 14.20.0; as alterações posteriores são identificadas quando afectam a interpretação dos resultados. Esta distinção evita apresentar o estado actual do código como se correspondesse exactamente ao estado de todas as execuções arquivadas.

3.4 MÉTODOS DE RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS

A recolha combinou análise documental, comparação de precedentes, inspecção do código, construção paramétrica, cenários automatizados, medição de malhas, preparação para impressão, observação de peças físicas e reflexão sobre cada ciclo. Os dados usados na análise foram: parâmetros e limites declarados em `models/models-config.json`; respostas JSON e metadados de execução; dimensões das malhas exportadas; relatórios técnicos por modelo; ficheiros 3MF; três projectos com parâmetros de preparação; fotografias dos protótipos; e registos de alterações do código.

Os modelos foram preparados no PrusaSlicer e no Bambu Studio. O fatiamento converte a geometria numa sequência de camadas e trajetórias de deposição, definindo altura de camada, paredes, enchimento, suportes, temperaturas e orientação. Existem dois projectos Bambu Lab A1, para Flexy Beast e UnLimbited Phoenix, gerados no Bambu Studio 1.10.02.76, e um projecto Prusa MINI para Paraglider Hand, gerado no PrusaSlicer 2.8.1. Os dois projectos Bambu registam camada de 0,24 mm, duas paredes, 15% de enchimento em grelha, suporte em árvore automático e aba de 5 mm. O projecto Prusa regista camada de 0,20 mm, duas paredes, 15% de enchimento em grelha, PLA, bico de 0,4 mm, mesa a 60 °C e suporte desactivado. Os parâmetros comparáveis foram mantidos nas restantes impressões, segundo o registo do projecto, embora não exista um ficheiro de configuração individual para cada peça produzida.

A materialização recorreu a uma Bambu Lab A1 com sistema AMS e a uma Prusa MINI, ambas baseadas em fabrico por filamento fundido. Os ficheiros disponíveis permitem verificar a preparação, a disposição das peças, o material atribuído no projecto e a ausência de erros de malha registados pelo programa. As fotografias permitem confirmar a existência das peças e comparar visualmente as séries etárias. Sem medições físicas sistemáticas, ensaios de carga ou registos completos por peça, esta evidência sustenta imprimibilidade e inspecção preliminar; não sustenta resistência, conforto, segurança ou durabilidade.

Não são recolhidos dados pessoais ou biométricos de utilizadores reais; utilizam-se exclusivamente conjuntos de dados antropométricos públicos, o que delimita o âmbito empírico ao domínio técnico e

projectual. Entre estes, destaca-se a base local consolidada de medidas da mão e do membro superior distal, usada como infraestrutura intermédia para a selecção, comparação e normalização de medidas relevantes para a parametrização geométrica. A organização dos dados preserva informação sobre país, amostra, tipo de medida, estatística, fonte documental e granularidade dos subconjuntos analisados, tornando explícitas a cobertura e as limitações de cada fonte antes da sua tradução em parâmetros de projecto.

Embora o presente estudo não utilize participantes, a literatura metodológica ajuda a esclarecer como medições lineares e procedimentos de ajuste são operacionalizados em contextos aplicados. A Figura 3.2 constitui um precedente para a tradução de medidas em parâmetros de projecto; não representa um procedimento realizado nesta investigação.

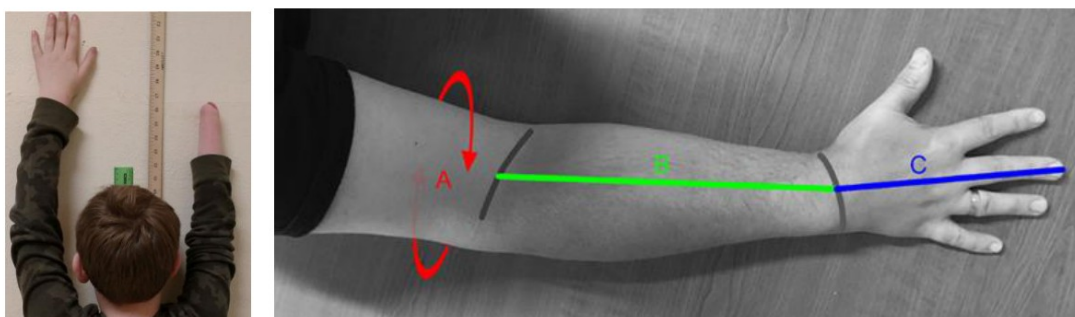


Figura 3.2 — Exemplo de recolha dimensional para ajuste de prótese impressa em 3D.

Fonte original: Kellam, S. M., Boleneus, G. J., Stewart, J., Richter, D. C., Michaelis, B. M., & Gerlick, R. E. (2019). An undergraduate engineering service learning project involving 3D-printed prosthetic hands for children. In American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition Proceedings.

3.5 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS

A avaliação usa seis critérios: conformidade da saída com o esquema; respeito pelos intervalos declarados; preservação das relações dimensionais definidas; aplicação dos valores na geometria; conclusão dos fluxos principais da plataforma; e preparação das peças para impressão. Cada critério tem uma evidência observável: resposta JSON, comparação numérica, malha exportada, estado da interface, ficheiro de projecto ou peça física. «Verificação» designa a confirmação de uma condição especificada; «avaliação» designa a interpretação conjunta dos resultados; «prova de conceito» designa o protótipo integrado. O termo «validação clínica» fica reservado a estudos com métodos, profissionais e participantes adequados, ausentes neste trabalho.

No módulo de IA, os critérios incidem na estrutura da resposta, nos limites e nas relações dimensionais internas. Não existe uma medida individual de referência para calcular erro anatómico. As respostas geradas são sugestões iniciais e podem diferir entre execuções; o estudo documenta exemplos e invariantes, sem estimar uma distribuição estatística do comportamento do modelo de linguagem.

As limitações principais são a ausência de participantes, dados clínicos, medições directas da mão, ensaios biomecânicos, protocolos normalizados de resistência, estudo longitudinal de desgaste e avaliação de usabilidade. Os dados populacionais apresentam diferenças de população, idade, sexo, lateralidade e método de medição. Os casos simulados representam situações de teste e não pessoas. A plataforma é um protótipo de investigação em staging, sem certificação como dispositivo médico e sem prontidão demonstrada para

utilização clínica ou doméstica. Estas limitações delimitam a força das conclusões, sem invalidar o estudo técnico que foi efectivamente realizado.

CAPÍTULO 4 — DESENVOLVIMENTO DO MODELO PARAMÉTRICO

4.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE DESIGN E REQUISITOS

Como referido anteriormente, o desenvolvimento de próteses de membro superior é enquadrado na literatura como um problema de elevada complexidade, situado na intersecção entre desempenho biomecânico, integração corpo-dispositivo e experiência vivida do utilizador (Cordella et al., 2016; Guo, 2025; Peerdeman et al., 2011). Este desafio ultrapassa a replicação formal da mão ou do segmento ausente. Implica a concepção de dispositivos capazes de conciliar funcionalidade, conforto, leveza, funcionamento consistente, controlo compreensível, aceitação estética e custos compatíveis com a produção, adaptação, manutenção e acesso continuado à prótese, num contexto em que continuam a registar-se taxas elevadas de rejeição e abandono.

A literatura associa estas taxas, de forma recorrente, a desconforto no encaixe, peso excessivo, limitações funcionais, baixa robustez e estratégias de controlo pouco intuitivas, evidenciando uma lacuna persistente entre a capacidade tecnológica dos dispositivos e as necessidades reais de uso (Biddiss et al., 2007; Cordella et al., 2016; Peerdeman et al., 2011).

Neste contexto, a definição de requisitos não constitui apenas uma etapa técnica de especificação, mas um processo de tradução entre problemas de uso, limitações clínicas, possibilidades tecnológicas e condições concretas de adoção. Assim, os requisitos considerados no projecto de uma prótese de membro superior devem ser entendidos como categorias interdependentes, que procuram responder simultaneamente ao desempenho funcional do dispositivo, à sua adequação ao corpo, à experiência quotidiana do utilizador e à viabilidade do seu desenvolvimento e manutenção.

A partir desta leitura, os requisitos de projecto podem ser organizados em categorias interdependentes. Os requisitos funcionais incluem padrões de preensão, graus de liberdade, amplitude de movimento, força, velocidade e capacidade de realizar atividades da vida diária. Os requisitos ergonómicos assumem particular centralidade, destacando-se o conforto, o baixo peso, a usabilidade, a facilidade de colocação e remoção da prótese e a adequação ao uso quotidiano prolongado. Ao nível técnico, definem-se parâmetros relativos a atuadores, sistemas de transmissão, sensores, estratégias de controlo, fontes de energia e selecção de materiais com propriedades mecânicas adequadas e compatibilidade biológica. Em termos de fabrico, emergem exigências de modularidade, reparabilidade, custo controlado e compatibilidade com fluxos de fabrico digital e aditivo. Acrescem ainda requisitos estéticos e psicossociais, relacionados com a identidade, a aceitação social e a incorporação corporal, cuja relevância é reiterada tanto por utilizadores como por clínicos e familiares (Biddiss et al., 2007; Brack & Amalu, 2021; Henao et al., 2025; Walker et al., 2019).

A tradução destas necessidades em parâmetros mensuráveis e programáveis constitui um ponto crítico no desenvolvimento de dispositivos médicos personalizados. Tal tradução implica converter necessidades qualitativas, como conforto, segurança ou facilidade de controlo, em especificações técnicas quantificáveis, como limites de peso, distribuição admissível de pressões, binário necessário nas articulações, número de graus de liberdade, autonomia energética ou tolerâncias dimensionais. As prioridades dos utilizadores nem sempre coincidem com os indicadores privilegiados pela engenharia, o que exige uma correspondência explícita entre

necessidade, critério de avaliação e decisão de projecto (Cordella et al., 2016; Hofmann et al., 2016; Jones et al., 2023).

No sistema paramétrico desenvolvido, esta relação foi operacionalizada apenas nas dimensões cobertas pelo protótipo: variáveis geométricas, restrições construtivas e limites de fabrico. Conforto, segurança e desempenho funcional permaneceram como requisitos provenientes da literatura e não foram convertidos em critérios empiricamente avaliados. Esta distinção evita apresentar a coerência geométrica como demonstração de adequação funcional.

As abordagens clássicas da engenharia de produto estruturam o desenvolvimento através da definição de funções, requisitos técnicos, alternativas e critérios de avaliação. Os modelos centrados no utilizador e as metodologias participativas acrescentam ciclos de prototipagem e avaliação com utilizadores, clínicos e familiares, reconhecendo que a definição do problema depende do desempenho mecânico e da experiência concreta de uso (Henao et al., 2025; Peerdeman et al., 2011; Walker et al., 2019). No domínio digital, a modelação paramétrica, a digitalização 3D e a simulação permitem incorporar alguns requisitos em modelos computacionais antes da produção física; cada requisito continua a exigir um critério de verificação próprio.

A formalização de constrangimentos nas fases iniciais do processo de design desempenha um papel estruturante, permitindo delimitar o espaço de solução antes da geração e avaliação de alternativas. Neste trabalho, estes constrangimentos são organizados em quatro categorias principais: materiais, mecânicos, anatómicos e produtivos. Esta organização permite distinguir os limites relacionados com as propriedades dos materiais, o comportamento estrutural e funcional do dispositivo, a adequação ao corpo do utilizador e as condições de fabrico.

Os constrangimentos materiais são definidos em termos de resistência, rigidez, durabilidade e compatibilidade biológica. Os constrangimentos mecânicos incluem limites de binário, deformação admissível, integridade estrutural sob carga e capacidades cinemáticas mínimas para a realização de tarefas quotidianas. Os constrangimentos anatómicos são integrados com base em dados antropométricos e, quando possível, na digitalização do membro residual, condicionando as geometrias, as zonas de contacto e os volumes internos. Por fim, os constrangimentos produtivos relacionam-se com as capacidades e limitações do fabrico aditivo, incluindo tolerâncias, orientação de impressão, tempo de fabrico, custo e escalonamento.

A explicitação destes limites desde as fases conceptuais permite enquadrar o processo como um exercício de optimização sujeito a múltiplas restrições, estruturando as decisões projectuais de forma clara, verificável e passível de análise crítica (Brack & Amalu, 2021; Herneth et al., 2024; Jones et al., 2023).

4.2 PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS E ESTRUTURA DO MODELO

No desenvolvimento de sistemas protésicos personalizados, as medições corporais funcionam como elemento de ligação entre o corpo do utilizador e a configuração geométrica e funcional do modelo paramétrico. No contexto das próteses de membro superior, estas medições não devem ser tratadas como valores isolados, mas como parte de um sistema estruturado de variáveis capaz de descrever a morfologia da mão, dos dedos, do punho e, quando aplicável, do antebraço ou do membro residual. A literatura recente converge em dois pontos: a personalização eficaz depende de medidas anatomicamente relevantes, e não de escalonamentos

genéricos; e essas medidas devem ser organizadas de modo a alimentar diretamente a lógica do modelo digital (Chatzioglou et al., 2024; Moreo, 2016; Rodríguez-Vega & Rodríguez-Vega, 2024).

Esta exigência de organizar as medições em parâmetros operáveis é particularmente evidente nos modelos digitais do dedo e da mão. A Figura 4.1 mostra um exemplo de decomposição paramétrica em comprimentos, larguras e secções articulares, o que clarifica o tipo de estrutura dimensional que sustenta a transição da antropometria para a geometria configurável.

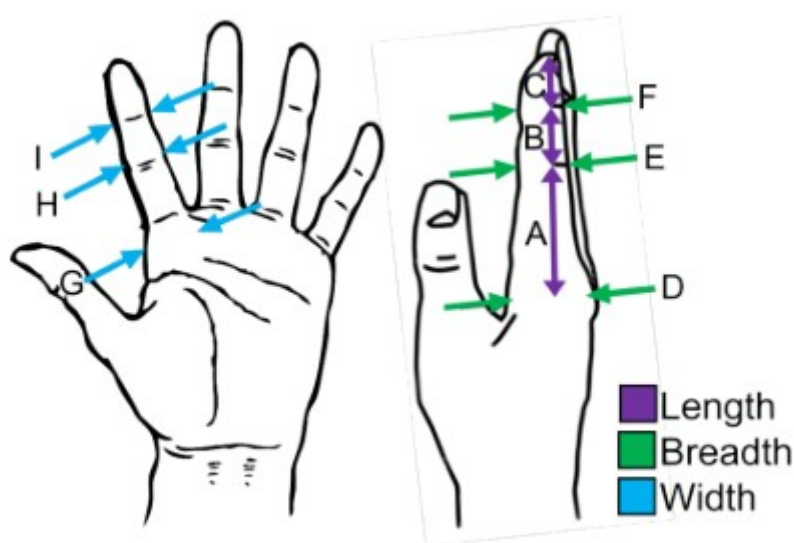


Figura 4.1 — Parâmetros antropométricos utilizados na modelação paramétrica de dedos protésicos.

Fonte original: Nini, L., Ceccarelli, A., Tagliamonte, N., Zollo, L., & Taffoni, F. (2024). Parametric 3D modeling of a customized prosthetic hand finger for additive manufacturing. In 2024 10th IEEE RAS/EMBS International Conference for Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob). IEEE. <https://doi.org/10.1109/BioRob60516.2024.10719909> (<https://doi.org/10.1109/BioRob60516.2024.10719909>)

Os parâmetros antropométricos mais relevantes concentram-se, em primeiro lugar, na definição da estrutura dimensional base da mão. Medidas como o comprimento da mão, a largura da mão e o comprimento da palma constituem descritores dimensionais primários, permitindo estabelecer a escala do modelo e definir a sua organização geral. Para além destas, incluem-se parâmetros relativos aos dedos, como comprimentos segmentares e proporções entre falanges, bem como as dimensões do polegar e do punho, essenciais para a funcionalidade e a integração da mão protésica no uso quotidiano (Chatzioglou et al., 2024; Nag et al., 2003).

Tabela 4.1 — Principais parâmetros antropométricos da mão e do membro superior relevantes para modelação paramétrica

Região	Parâmetro	Definição dimensional	Utilização potencial no modelo
Mão	Largura da mão	Distância entre	Definição do

Região	Parâmetro	Definição dimensional	Utilização potencial no modelo
		metacarpos II e V	volume da palma
Palma	Comprimento da palma	Base do dedo médio até ao punho	Estrutura e proporção da palma
Dedos	Comprimento dos dedos	MCP até ponta	Dimensionamento funcional
Dedos	Proporções falângicas	Relação entre segmentos	Definição cinemática
Dedos	Largura/profundidade	Secção transversal	Ajuste estrutural e estético
Polegar	Comprimento e orientação	Geometria e oposição	Preensão e usabilidade
Punho	Largura/profundidade	Dimensões do punho	Interface estrutural
Antebraço	Circunferência/comprimento residual	Medidas do membro residual	Ajuste do encaixe

CONJUNTOS MÍNIMOS DE PARÂMETROS POR NÍVEL DE AMPUTAÇÃO

O conjunto mínimo de parâmetros antropométricos varia em função do nível de amputação, dado que diferentes configurações protésicas exigem níveis distintos de detalhe dimensional. A redução das medições necessárias contribui para processos de personalização mais escaláveis e acessíveis, particularmente quando a recolha de dados é realizada fora de contextos clínicos especializados. (Moreo, 2016; Romero et al., 2025).

Tabela 4.2 — Conjuntos mínimos de parâmetros por nível de amputação

Nível de ausência do membro	Conjunto mínimo proposto pela literatura
Desarticulação do punho	Largura e profundidade do punho, comprimento da mão
Parcial da mão	Comprimento da palma, dimensões dos dedos remanescentes
Dedos (parcial)	Comprimento e largura do dedo, proporções falângicas
Mão completa (cosmética/funcional)	Comprimento da mão, largura da palma, comprimento dos dedos

Esta lógica permite estruturar o sistema paramétrico a partir de entradas essenciais, controlando a complexidade inicial do processo sem inviabilizar a geração de uma solução funcional. Importa, contudo, distinguir entre parâmetros mínimos de configuração e parâmetros de refinamento: os primeiros permitem gerar uma instância funcional do modelo; os segundos aumentam o grau de especificidade da configuração,

permitindo afinar a coerência proporcional, a adequação geométrica ou o desempenho cinemático quando existem dados adicionais disponíveis.

LIMITAÇÕES DO REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL

Uma limitação recorrente em abordagens simplificadas de modelação é o uso de redimensionamento proporcional (uniform scaling), no qual um modelo base é dimensionado proporcionalmente em todas as direções. Esta abordagem revela-se inadequada no contexto antropométrico, uma vez que as dimensões da mão apresentam correlações imperfeitas entre si e variam de forma desigual entre populações, sexos e grupos etários. Em consequência, indivíduos com largura de mão semelhante podem apresentar comprimentos digitais, proporções falângicas ou dimensões do polegar significativamente diferentes. A modelação paramétrica exige, por isso, a definição de parâmetros independentes que permitem derivar proporções locais sem pressupor uma homotetia global do modelo, isto é, sem assumir que a prótese deve ser redimensionada de forma proporcional como um todo, mantendo invariáveis todas as relações geométricas entre as suas partes. (Lim et al., 2018; Nag et al., 2003; Rodríguez-Vega & Rodríguez-Vega, 2024).

Esta limitação torna-se visualmente evidente na Figura 4.2, que compara um modelo uniformemente escalado com outro parametrizado a partir de variáveis independentes. A diferença mostra que a configuração exige o controlo das relações geométricas internas, ultrapassando o simples aumento ou redução do modelo-base.

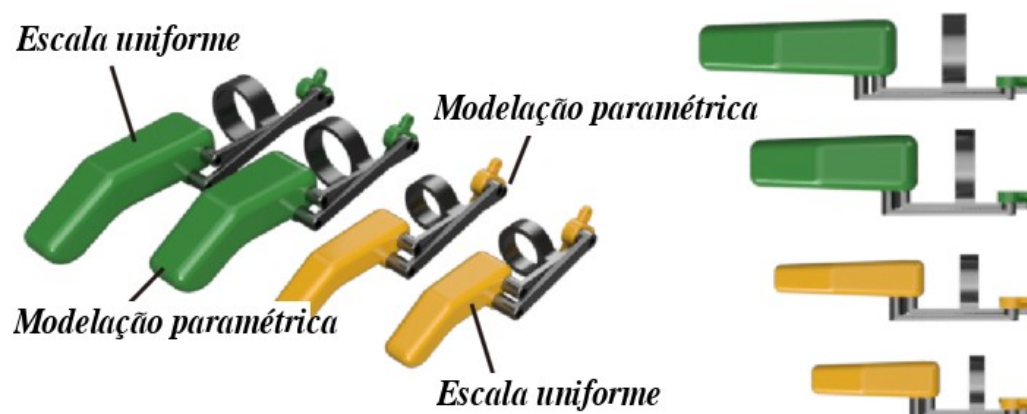


Figura 4.2 — Comparação entre o escalonamento uniforme e a modelação paramétrica de dedo protésico.

Adaptado de fonte original: Lim, D., Georgiou, T., Bhardwaj, A., O'Connell, G. D., & Agogino, A. M. (2018, August 26). Customization of a 3D printed prosthetic finger using parametric modeling. In Proceedings of the ASME 2018 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. <https://doi.org/10.1115/DETC2018-85645> (<https://doi.org/10.1115/DETC2018-85645>)

MÉTODOS DE RECOLHA DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS

A recolha de dados pode ser realizada por diferentes métodos, com implicações directas na precisão das medições e na sua tradução para parâmetros de projecto. A escolha do método depende do objectivo da medição: parametrização dimensional básica, reconstrução geométrica fina, desenho do encaixe ou obtenção de relações internas entre superfícies e estruturas ósseas. Em termos práticos, a literatura mostra que não há

um método universalmente superior; há, sim, uma adequação diferencial entre método, custo, acessibilidade e o tipo de dados necessários (Çıklaçandır et al., 2022; Herbst et al., 2021).

Tabela 4.3 — Métodos de recolha de dados antropométricos e suas características

Método	Dados obtidos	Vantagens	Limitações	Uso principal
Digitalização 3D	Geometria superficial	Elevada precisão, rapidez	Equipamento e processamento necessários	Encaixe e forma
Imagiologia médica	Estrutura interna e externa	Dados anatómicos detalhados	Alto custo e menor acessibilidade	Modelação biomecânica
Fotogrametria	Geometria aproximada	Acessível, potencial remoto	Precisão variável	Aquisição preliminar

BASES DE DADOS ANTROPOMÉTRICAS, EXTRACÇÃO E NORMALIZAÇÃO

A definição de parâmetros pode apoiar-se em bases de dados antropométricas de referência e em normas de medição corporal, que ajudam a estabilizar a nomenclatura, os pontos anatómicos e os intervalos esperados de variação. No presente projecto, esse apoio foi operacionalizado através da consolidação local de dados provenientes de estudos populacionais e de bases de referência. O conjunto `data/multi_population_hand.csv` contém 1.790 linhas em formato longo; cada linha representa uma estatística associada a uma medida e a um grupo, e não uma pessoa. O ficheiro cobre nove países — China, Estados Unidos da América, Índia, Jordânia, México, Nigéria, Países Baixos, Portugal e Turquia — e combina dados de estudos publicados, relatórios técnicos e subconjuntos DINED disponibilizados pela TU Delft.

Esta consolidação não cria uma nova norma antropométrica nem substitui a medição individual. A base funciona como infra-estrutura intermédia para três decisões de projecto: definir intervalos de referência para os parâmetros expostos; identificar dimensões recorrentes que possam servir como entradas mínimas; e testar a coerência geométrica de configurações derivadas de perfis populacionais. Os dados populacionais descrevem tendências e dispersões. O ajuste final ao corpo continua a exigir medições directas ou digitalização específica.

A selecção das fontes seguiu critérios explícitos. Foram incluídas fontes que apresentavam dados primários ou bases de dados reconhecidas, pelo menos uma dimensão relevante para a mão, dedos, palma, punho ou antebraço, identificação da população ou subgrupo e estatística descritiva claramente reportada, como médias, desvios-padrão, percentis ou intervalos. Foram excluídos estudos que reutilizavam dados secundários sem acesso claro à fonte original, artigos de engenharia que mencionavam dimensões de forma incidental, exemplos baseados num único sujeito e fontes sem informação suficiente sobre população, método ou unidade. Esta decisão explica, por exemplo, a exclusão dos valores percentílicos reproduzidos por Moreo (2016) a partir da base DINED: apesar de o trabalho ser relevante para a lógica de parametrização, a tabela não constitui recolha primária autónoma e seria metodologicamente redundante quando a fonte DINED podia ser tratada directamente (Moreo, 2016).

Tabela 4.4 — Fontes integradas na base local de dados antropométricos

Fonte	População e cobertura	Dados extraídos	Registos
DINED kima1993, TU Delft	Crianças neerlandesas, 2–12 anos	Médias e desvios-padrão de medições da mão por idade e sexo	528
DINED geron1998, TU Delft	Idosos neerlandeses, 50–80+ anos	Médias e desvios-padrão de medições da mão por grupos etários	210
DINED dined2004, TU Delft	Adultos neerlandeses, 20–60+ anos	Médias e desvios-padrão de medições da mão por sexo e idade	114
Rodríguez-Vega e Rodríguez-Vega (2024)	População mexicana, 15–59 anos	Comprimento da mão, comprimento da palma, largura da mão e diâmetro de preensão, com valores gerais e por grupos etários	360
Nag et al. (2003)	Mulheres indianas trabalhadoras	51 dimensões da mão, incluindo comprimentos, larguras, circunferências, profundidades e aberturas	255
Gordon et al. (2015)	Militares norte-americanos do ANSUR II	Medições da mão, punho e antebraço extraídas das estatísticas públicas do inquérito	154
Chatzioglou et al. (2024)	Jovens adultos da Turquia	Comprimentos dos cinco dedos da mão direita, por sexo e combinado	56
Hu et al. (2007)	Idosos chineses da área de Pequim	Larguras, comprimento da mão, comprimento do dedo e comprimento antebraço-ponta dos dedos	50

Fonte	População e cobertura	Dados extraídos	Registos
Ibiwari et al. (2025)	Atletas universitários da Nigéria	Comprimento da mão, largura da mão, comprimento palmar e 3.º dedo, por modalidade e sexo	32
Anacleto Filho et al. (2023)	Trabalhadores industriais portugueses	Comprimento e largura da mão, por sexo	20
Mistarihi (2020)	Trabalhadores com deficiência física na Jordânia	Comprimento da mão, largura da mão e comprimento cotovelo-ponta dos dedos	9
Lim et al. (2018)	Adultos jovens nos EUA	Comprimento e largura do dedo indicador para personalização de dedo protésico	2

A extracção foi realizada a partir das tabelas dos artigos e, quando aplicável, da interface estruturada das bases de dados. Nos artigos científicos, a leitura concentrou-se em duas zonas: a metodologia, para identificar instrumento, postura, mão medida e pontos anatómicos; e os resultados, para localizar as tabelas com médias, desvios-padrão, percentis, mínimos e máximos. Cada valor foi transcrito para uma estrutura comum que preserva a fonte documental, a página, a citação, o nome da medida, a região corporal, o protocolo de medição, a população, o país, o sexo, o grupo etário, a dimensão amostral, o tipo de estatística, as unidades convertidas e uma nota de qualidade quando necessário. A preservação da fonte, página, população e nota metodológica permite identificar a origem de cada valor e regressar ao documento original sempre que uma medida pareça incoerente.

A opção pelo formato longo resultou de uma decisão metodológica orientada para a flexibilidade da estrutura de dados. Em vez de criar uma linha por dimensão com colunas fixas para média, desvio-padrão e percentis, cada estatística foi registada como uma linha própria. Assim, uma mesma dimensão pode originar várias linhas relativas à média, ao desvio-padrão, ao P5, P50, P95, mínimo ou máximo.

Este formato facilita a integração de fontes incompletas, porque nem todos os estudos reportam o mesmo conjunto de estatísticas.

Na base actual, existem 612 médias, 609 desvios-padrão, 513 percentis, 28 mínimos e 28 máximos. Esta assimetria é metodologicamente relevante: os conjuntos ANSUR oferecem maior profundidade estatística, enquanto o DINED permite uma separação estruturada por idade e sexo, apenas com média e desvio-padrão

na interface consultada. Estudos como Mistarihi (2020) ou Lim et al. (2018) fornecem valores parciais, úteis como referência contextual e insuficientes para uma estimativa populacional com o mesmo detalhe (Gordon et al., 2015; Lim et al., 2018; Mistarihi, 2020).

As principais dificuldades encontradas dizem respeito à heterogeneidade dos protocolos. A expressão “comprimento da mão”, por exemplo, nem sempre corresponde ao mesmo trajeto anatômico: alguns estudos tomam como referência a linha de flexão do punho, outros o processo estilóide, enquanto outros definem o comprimento a partir de marcos funcionais da palma.

Do mesmo modo, verifica-se heterogeneidade no critério de selecção da mão analisada, com estudos que consideram a mão direita, a mão dominante ou, no caso do estudo português, a mão esquerda, em função das condições específicas de recolha de dados. (Anacleto Filho et al., 2023). Estas diferenças impedem que todos os dados sejam tratados como diretamente equivalentes e justificam o registo explícito dos respetivos protocolos de medição. A base de dados não elimina a heterogeneidade das fontes; pelo contrário, torna-a visível, permitindo que o modelo paramétrico utilize os valores antropométricos de forma contextualizada e metodologicamente informada. Foram igualmente identificadas dificuldades relacionadas com a granularidade e a representatividade dos dados. Algumas fontes apresentam amostras robustas, mas oferecem informação limitada sobre dimensões específicas da mão; outras disponibilizam medições detalhadas, mas circunscritas a populações muito particulares. Nag et al. (2003), por exemplo, fornece uma cobertura dimensional extensa, embora limitada a mulheres indianas trabalhadoras. Rodríguez-Vega (2024) apresentam uma amostra mexicana numerosa e grupos etários úteis para comparação, mas concentram-se em quatro dimensões principais. Ibiwari et al. (2025) acrescenta dados relativos a uma população africana, embora a amostra seja composta por atletas universitários, e não por população geral. Mistarihi (2020) é relevante por incluir trabalhadores com deficiência física, mas apresenta um número reduzido de registos e insuficiente desagregação por sexo. Estes casos foram mantidos por ampliarem a diversidade das referências antropométricas, sendo as suas limitações registadas nos metadados relativos à população, à dimensão amostral e à qualidade dos dados. Em sentido inverso, algumas fontes facilitaram a extracção. As tabelas com percentis claros, unidades explícitas e separação por sexo ou idade permitiram uma codificação directa e maior confiança na transcrição dos valores. No caso da DINED, a estrutura HTML da interface facilitou a identificação e a extracção consistente das médias e dos desvios-padrão, permitindo registar, para cada medida antropométrica, o valor médio observado no grupo e a respectiva dispersão interna. Esta informação foi recolhida mantendo a separação entre subconjuntos, sexo e grupos etários, embora os percentis não estivessem disponíveis na mesma interface.

O ANSUR II também foi particularmente útil por disponibilizar estatísticas amplas e uma grande amostra militar, permitindo trabalhar com medições da mão, punho e antebraço em escala populacional (Gordon et al., 2015; Molenbroek, 1998; Molenbroek et al., 2003; Steenbekkers & van Beijsterveldt, 1998). Ainda assim, estas fontes não resolvem o problema da personalização clínica, uma vez que amostras compostas por militares, crianças neerlandesas ou idosos chineses não podem ser diretamente extrapoladas para utilizadores com amputação de membro superior.

As decisões de normalização dos dados seguiram quatro princípios metodológicos. Em primeiro lugar, todas as medidas antropométricas foram convertidas para milímetros, centímetros e polegadas, mantendo-se a unidade originalmente utilizada em cada fonte. Esta decisão permite comparar valores entre estudos sem perder a referência ao formato de publicação original e reduz o risco de conversões ambíguas no momento de utilização dos dados. Em segundo lugar, valores provenientes de subgrupos com dimensão amostral reduzida, dados extraídos de figuras em vez de tabelas, desvios-padrão discrepantes ou definições anatômicas pouco explícitas foram mantidos na base, mas assinalados através de notas de qualidade. Deste modo, a incerteza associada a cada registo permanece documentada, em vez de ser eliminada sem justificação metodológica. Em terceiro lugar, as medidas foram agrupadas por região corporal, distinguindo dimensões da mão, dedos e palma, directamente relevantes para a geração da geometria principal, de dimensões do punho e antebraço, mais associadas à interface, à fixação ou à adaptação ao membro residual. Por fim, os valores recolhidos foram tratados como referências paramétricas, em lugar de prescrições dimensionais finais. A base antropométrica construída responde, assim, a uma necessidade específica do modelo desenvolvido: traduzir o enquadramento antropométrico da personalização protésica em intervalos, relações proporcionais e restrições utilizáveis no processo de modelação. Os dados delimitam o espaço de alteração dentro do qual o modelo pode operar com maior coerência geométrica e metodológica. Para tal, o sistema necessita de identificar as medidas recorrentes na literatura, os intervalos observados em diferentes populações, as dimensões que podem funcionar como entradas mínimas de configuração e as situações em que o redimensionamento uniforme se torna metodologicamente arriscado.

A base de dados construída permite comparar valores relativos ao comprimento da mão, à largura da palma, aos comprimentos digitais, às dimensões do punho e às relações com o antebraço, mantendo a referência à fonte, à população e ao contexto metodológico de cada linha.

Deste modo, a base de dados sustenta a passagem entre o enquadramento antropométrico e a modelação paramétrica tridimensional, usando OpenSCAD: os dados não geram automaticamente a prótese, mas delimitam o espaço de variação dentro do qual o modelo pode operar com maior coerência geométrica e metodológica.

Permanece uma limitação central. A maior parte dos dados disponíveis provém de populações sem amputação e não descreve a morfologia do membro residual nem a interacção dinâmica entre tecido, carga e encaixe. Para uma prótese definitiva, a referência mais adequada seria a medição directa do utilizador, idealmente complementada por digitalização tridimensional e avaliação da interface com o corpo. Nesta investigação, os dados antropométricos públicos estruturam o sistema, apoiam os ensaios de coerência dimensional e fundamentam decisões de parametrização; não substituem avaliação clínica, prova de conforto ou avaliação individual.

CORRESPONDÊNCIA ENTRE PERFIL POPULACIONAL E PARÂMETROS DO MODELO

A plataforma converte as linhas dos CSV em perfis agregados armazenados em data/app.db. No fecho do estudo existiam 100 perfis: 97 importados em lote, dois por importação CSV e um criado manualmente. A

correspondência entre uma descrição e estes perfis é determinística e encontra-se em `server/services/profileMapping.js`.

O algoritmo extrai sexo e idade do texto, com apoio opcional de um modelo de linguagem quando esses campos ficam incompletos. Para cada perfil, calcula uma pontuação: +3 por coincidência de sexo e -3 por conflito explícito; +3 por coincidência da categoria etária e -2 por conflito; até +1,5 pela proximidade numérica da idade; +1,5 quando o país do perfil ocorre literalmente na descrição; +1 para grupos identificados como média, mediana ou percentil 50; e +1 quando o nome do grupo indica medições da mão. A idade representativa de um intervalo é o seu ponto médio; num intervalo aberto, como «65+», acrescentam-se cinco anos ao limite. O perfil só é seleccionado quando a pontuação atinge 3. Quando o país indicado está ausente da base, esse critério não acrescenta pontuação.

Depois da selecção, um mapa canónico liga cada parâmetro a um caminho da estrutura antropométrica. Entre as ligações principais encontram-se `palm_breadth_mm` a `palm.width_mm`, `palm_length_mm` a `palm.length_mm`, os comprimentos dos cinco dedos aos respectivos campos `digits.*.total_length_mm`, os comprimentos proximais a `digits.*.proximal_length_mm` e `wrist_circumference_mm` a `wrist.circumference_mm`. Só são aplicados parâmetros numéricos presentes no modelo e com medida positiva no perfil. Cada valor é arredondado a uma casa decimal e limitado pelo mínimo e máximo declarados; os campos ausentes são ignorados e permanecem disponíveis para introdução manual ou sugestão da IA.

Este processo selecciona uma referência inicial e não um equivalente individual. A pontuação é uma regra de correspondência construída para o protótipo; não representa distância antropométrica validada entre populações. Um exemplo é o cenário «girl, 10 years old, ... Japan»: como o Japão está ausente, o algoritmo usa sexo, idade, proximidade etária e qualidade do grupo, sem evidência nacional japonesa.

ESTRUTURA PARAMÉTRICA E MAPEAMENTO DE PARÂMETROS

A estrutura do modelo paramétrico organiza os parâmetros segundo uma lógica hierárquica e relacional, distinguindo entre parâmetros primários, derivados, funcionais e construtivos. Esta distinção é metodologicamente importante porque impede que o modelo seja tratado como um conjunto plano de medidas independentes. Em vez disso, estabelece-se uma cadeia de transformação em que algumas variáveis funcionam como entradas principais do utilizador e outras como consequências geométricas, cinemáticas ou produtivas dessas entradas (Moreo, 2016; Romero et al., 2025).

Tabela 4.5 — Estrutura hierárquica dos parâmetros no modelo paramétrico

Tipo de parâmetro	Exemplos	Função no modelo	Relação com outras variáveis
Derivados	Proporções das falanges	Construção geométrica	Dependentes
Funcionais	Amplitude de movimento, posição articular	Desempenho	Ligação cinemática
Construtivos	Espessuras, folgas,	Fabrico	Ajuste técnico

Tipo de parâmetro	Exemplos	Função no modelo	Relação com outras variáveis
	tolerâncias		

A tradução destes parâmetros em geometria é realizada por meio de relações explícitas entre medições e componentes do modelo.

OPENSCAD: ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DA ESCOLHA

Antes de avançar para a formalização do modelo, importa clarificar o que é o OpenSCAD e por que motivo foi escolhido como ambiente de modelação paramétrica neste projecto. O OpenSCAD é um ambiente livre e open source de CAD tridimensional baseado em ficheiros de script, orientado para a criação de geometria sólida e não para a modelação artística de superfícies. O modelo é descrito num ficheiro .scad, escrito numa linguagem própria, e esse ficheiro é interpretado pelo programa para gerar o sólido correspondente. Do ponto de vista geométrico, o OpenSCAD assenta numa lógica de Constructive Solid Geometry (CSG), na qual primitivas como cubos, cilindros, esferas e extrusões são combinadas por operações booleanas, transformações e relações hierárquicas entre módulos (OpenSCAD Project, n.d.-a; OpenSCAD Project, n.d.-b; Ghali, 2008).

Esta natureza programável distingue o OpenSCAD dos ambientes CAD convencionais baseados sobretudo em manipulação gráfica directa. Em muitos sistemas CAD, o utilizador constrói uma sequência de operações num histórico visual e parametriza algumas características desse histórico; no OpenSCAD, pelo contrário, a própria descrição textual é o modelo paramétrico. As variáveis, funções e módulos não são uma camada posterior aplicada à geometria, mas a estrutura que a gera. Esta diferença é relevante para a investigação, porque torna as relações entre parâmetros, componentes e restrições mais explícitas, reexecutáveis e documentáveis, embora implique uma curva de aprendizagem maior e dificuldades conhecidas em tarefas de navegação código-vista, validação e criação de formas orgânicas complexas (Trautmann, 2021; Gonzalez Avila et al., 2024).

A escolha do OpenSCAD resulta, em primeiro lugar, da sua adequação a processos documentados e consistentes de design paramétrico. Por ser texto simples, o ficheiro-fonte pode ser versionado, comparado, analisado e reutilizado, o que favorece o registo das decisões de modelação e a regeneração das variantes. Esta característica é valorizada em hardware científico e open source, porque a documentação do processo tem importância equivalente ao ficheiro final exportado. Além disso, o OpenSCAD pode ser executado por linha de comando, receber valores por parâmetros e exportar automaticamente geometrias para formatos de fabrico digital, como STL ou 3MF, tornando-o compatível com fluxos de geração em lote e configuradores digitais (Machado et al., 2019; OpenSCAD Community, n.d.).

Em segundo lugar, o OpenSCAD adapta-se bem à arquitectura web proposta nesta dissertação. A separação entre definição geométrica e interface permite que o ficheiro .scad permaneça como núcleo técnico do modelo, enquanto a plataforma apresenta ao utilizador os parâmetros relevantes. Esta lógica já foi explorada em configuradores web baseados em OpenSCAD, nos quais utilizadores sem domínio da linguagem podem gerar variantes imprimíveis a partir de modelos parametrizados por designers. A existência de implementações em WebAssembly, como o OpenSCAD Web, reforça esta escolha, porque demonstra que o motor de geração pode

ser executado no navegador, associado a editores, visualizadores 3D e interfaces de personalização sem exigir a instalação local de software CAD completo (Nilsiam & Pearce, 2017; Brooks, 2026).

Em terceiro lugar, o OpenSCAD é particularmente compatível com um fluxo de design apoiado por inteligência artificial. Como a geometria é expressa em código curto, estruturado e relativamente legível, uma IA pode sugerir valores, explicar relações entre variáveis ou propor alterações ao script sem substituir a lógica paramétrica por uma geometria opaca. Trabalhos recentes sobre geração de modelos 3D a partir de linguagem natural e automação de desenho paramétrico mostram que modelos de linguagem podem atuar sobre scripts CAD, embora continuem a exigir revisão humana, verificação dimensional e validação técnica antes de qualquer aplicação produtiva ou clínica (ELhadad et al., 2026; Schöfer & Seibel, 2025; Gonzalez Avila et al., 2024).

No contexto específico das próteses e das tecnologias de apoio, esta escolha é ainda reforçada por estudos que usam modelação paramétrica para adaptar dedos protésicos, mãos mecânicas accionadas pelo corpo e outros dispositivos de apoio às medidas ou necessidades do utilizador. Estes trabalhos não eliminam a necessidade de ensaios funcionais, avaliação ergonómica ou validação clínica, mas demonstram que a personalização geométrica pode ser estruturada por parâmetros explícitos e por modelos reexecutáveis. Para este projecto, o OpenSCAD é, portanto, adequado não porque resolva sozinho o problema da prótese personalizada, mas porque oferece uma base transparente para ligar medidas antropométricas, regras de modelação, interface web, sugestões de IA, exportação para fabrico aditivo e revisão humana (Lim et al., 2018; Bustamante et al., 2018; Romani & Levi, 2020).

Tabela 4.6 — Mapeamento entre parâmetros antropométricos e elementos do modelo

Parâmetro antropométrico	Efeito geométrico previsto
Largura da palma	Volume da palma e espaçamento entre dedos
Comprimento dos dedos	Geometria das falanges
Circunferência do antebraço	Geometria do encaixe
Largura do punho	Interface palma-punho
Proporções falângicas	Relações cinemáticas dos mecanismos digitais

Este mapeamento constitui a base da modelação paramétrica, permitindo converter dados antropométricos em configurações geométricas e funcionais. Em termos práticos, a passagem da medição para a geometria não deve ser entendida como uma transposição linear, mas como a definição de relações controladas: certos parâmetros regulam a escala geral, outros definem proporções locais e outros ainda atuam como restrições de consistência geométrica, desempenho funcional ou compatibilidade com o processo de fabrico.

Antes da tradução do modelo para o ambiente de modelação paramétrica, torna-se necessário estabilizar três níveis: os dados de entrada, as relações entre parâmetros e os limites técnicos que condicionam a sua transformação em forma.

No contexto desta investigação, o papel da secção 4.2 é, portanto, delimitado com clareza: identificar quais são os parâmetros antropométricos relevantes, como são recolhidos ou inferidos, e de que modo se organizam antes de entrarem na estrutura computacional do modelo. A secção seguinte retoma precisamente esta base

para mostrar como esse sistema de entradas, dependências e restrições é formalizado em OpenSCAD como um modelo executável, modular e regenerável.

4.3 MODELAÇÃO PARAMÉTRICA EM OPENSCAD

A modelação paramétrica em OpenSCAD corresponde, nesta investigação, ao momento em que a estrutura definida na secção anterior deixa de ser um quadro conceptual e passa a constituir um modelo operacional, capaz de traduzir parâmetros, relações e restrições em geometrias configuráveis. Os parâmetros antropométricos seleccionados, as relações hierárquicas entre variáveis e os limites de configuração são inscritos em código, de modo a gerar a mesma geometria para um mesmo conjunto de valores e versão do modelo. A transição para OpenSCAD constitui, assim, a continuação lógica do mesmo problema: transformar dados corporais e regras de projecto num modelo configurável que preserve coerência formal e produtiva.

A modelação paramétrica em OpenSCAD é aqui entendida como uma abordagem em que a geometria resulta de regras explícitas, parâmetros definidos em código e relações de dependência entre componentes, em vez da edição manual isolada de formas. No desenvolvimento de próteses personalizadas de membro superior, esta lógica permite compreender a prótese como um conjunto configurável de variantes que pode ser regenerado a partir de novos dados antropométricos, requisitos funcionais e limites de fabrico. Os estudos analisados sobre modelação paramétrica aplicada a próteses e sobre modelação CAD programável associam estas abordagens a melhor documentação das decisões, consistência entre variantes e automatização em fluxos de personalização digital (Machado et al., 2019; Moreo, 2016; Romero et al., 2025).

Ao contrário de ambientes centrados na manipulação gráfica directa, o OpenSCAD opera como uma especificação computacional do objecto. Esta característica permite compreender o modelo como resultado geométrico e estrutura explícita de projecto, onde ficam registadas as relações entre entradas antropométricas, módulos geométricos, restrições construtivas e decisões formais. A modelação baseada em código articula-se, assim, com Research Through Design, pois o próprio modelo pode ser lido, analisado, testado e documentado como uma estrutura de conhecimento técnico-projectual.

A Figura 4.3 reforça esta passagem entre definição paramétrica, modelo virtual e protótipo físico. O seu valor para esta investigação não reside em replicar a solução apresentada, mas em tornar visível a cadeia que liga a decomposição dimensional do dedo, a modelação computacional e a verificação material, isto é, o mesmo tipo de continuidade que o modelo em OpenSCAD procura preservar (Nini et al., 2024).

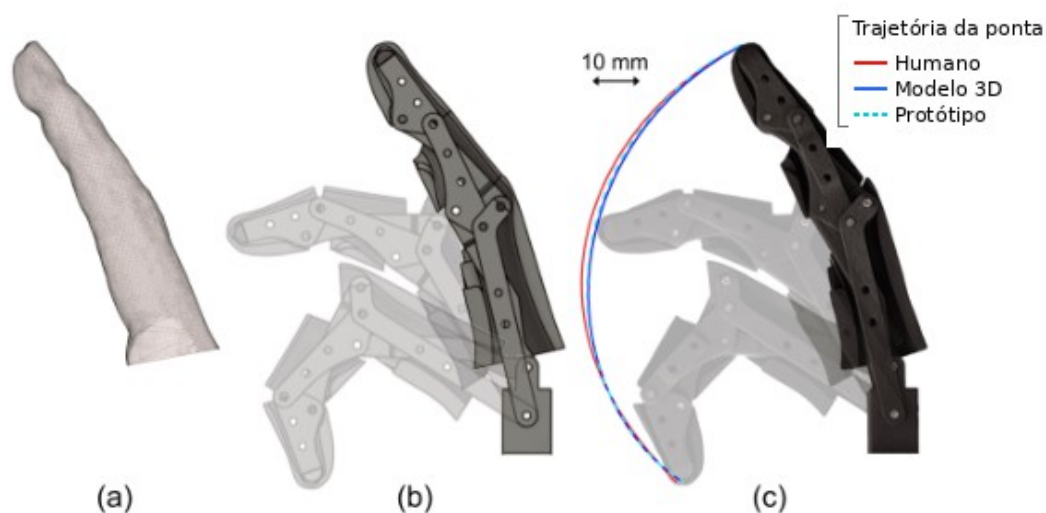


Figura 4.3 — Relação entre modelo paramétrico digital, prototipagem e verificação de um dedo protésico.

Fonte original: Nini, L., Ceccarelli, A., Tagliamonte, N., Zollo, L., & Taffoni, F. (2024). Parametric 3D modeling of a customized prosthetic hand finger for additive manufacturing. In 2024 10th IEEE RAS/EMBS International Conference for Biomedical Robotics and Biomechanics (BioRob). IEEE. <https://doi.org/10.1109/BioRob60516.2024.10719909> (<https://doi.org/10.1109/BioRob60516.2024.10719909>)

4.3.1 ESTRUTURA TÉCNICA, PARÂMETROS E RESTRIÇÕES

Num modelo paramétrico baseado em OpenSCAD, a organização interna pode ser compreendida como uma arquitetura em camadas.

Numa primeira camada situam-se os dados de entrada, provenientes de medições lineares, de dados consolidados de referência ou de digitalização tridimensional. Numa segunda camada, esses dados são transformados em parâmetros geométricos derivados, responsáveis por estabelecer proporções, espessuras, posições articulares e relações entre subcomponentes. Segue-se uma camada funcional, na qual se definem exigências de mobilidade, montagem ou integração mecânica, e uma camada de restrições produtivas, na qual se enquadram espessuras mínimas, folgas, tolerâncias e limites de fabrico. Esta organização permite controlar a personalização sem comprometer a coerência interna do sistema (Moreo, 2016; Nini et al., 2024; Saldarriaga et al., 2024).

Tabela 4.7 — Estrutura técnica em camadas de um modelo paramétrico em OpenSCAD para próteses personalizadas

Camada	Dados tratados	Função	Exemplos
Derivação geométrica	Parâmetros calculados a partir das entradas	Traduzir medidas em relações formais	Comprimentos segmentares, espessuras, offsets
Comportamento funcional	Parâmetros ligados ao uso e ao mecanismo	Regular movimento, montagem e desempenho	Amplitude articular, espaço para tendões, eixos
Restrições	Limites de fabrico e	Garantir fabrico e	Espessura mínima,

Camada	Dados tratados	Função	Exemplos
produtivas	consistência	robustez	folgas, raios mínimos

Quando transposta para o ambiente de modelação em OpenSCAD, esta arquitetura tende a materializar-se através de módulos relativamente autónomos. Em vez de concentrar toda a definição geométrica num único bloco de código, o modelo pode ser distribuído em módulos correspondentes à palma, aos dedos, às articulações, às interfaces de fixação ou ao encaixe. A modularidade apresenta aqui duas vantagens directas: reduz a opacidade do sistema e facilita a regeneração controlada de variantes. Num contexto protésico, isto permite que alterações nos parâmetros de entrada não se propaguem de forma arbitrária a todo o modelo, mas segundo relações previamente explicitadas e localizáveis. (Machado et al., 2019; Romero et al., 2025).

Outro aspecto central é a integração de restrições diretamente na lógica paramétrica. Em vez de tratar a compatibilidade com o fabrico aditivo como uma etapa exclusivamente posterior, o modelo pode incorporar, desde o início, limites mínimos de espessura, folgas entre elementos móveis, margens de tolerância e verificações condicionais para evitar combinações inválidas.

Este princípio é particularmente relevante em próteses produzidas por fabrico aditivo, nas quais pequenas alterações dimensionais podem comprometer a montagem, a resistência ou a viabilidade de impressão. Estudos sobre modelação paramétrica de dedos e encaixes protésicos personalizados mostram que a estabilidade do sistema depende da articulação entre parâmetros antropométricos e restrições construtivas, em lugar de decorrer da liberdade de alteração geométrica (Nini et al., 2024; Saldarriaga et al., 2024).

A modelação em OpenSCAD pode ser articulada a fluxos de dados mais complexos, incluindo a digitalização tridimensional e a automatização parcial do desenho. Trabalhos como os de Herbst et al. (2021) e Saldarriaga et al. (2024) mostram que a personalização tende a aproximar a medição, a parametrização e o fabrico, reduzindo o intervalo entre a captura anatómica e a geração de modelos prontos para produção. No caso desta investigação, essa articulação usa a lógica explícita do código como núcleo organizador para integrar dados, restrições e interfaces de configuração de modo consistente e documentado.

4.3.2 ANÁLISE CRÍTICA DA ABORDAGEM

A adopção do OpenSCAD neste projecto apresenta vantagens metodológicas relevantes, sobretudo pela forma como torna explícita a construção do modelo paramétrico. Ao ser definido por código, o modelo permite identificar relações entre variáveis, dependências e restrições com maior facilidade do que em muitos fluxos CAD baseados em operações gráficas. Esta condição favorece a transparência do processo, a análise crítica e a possibilidade de reconstituir as decisões de modelação, qualidades particularmente importantes num trabalho académico em que o modelo paramétrico constitui um instrumento de produção formal e um objecto de análise (Machado et al., 2019).

Uma segunda vantagem reside na afinidade entre a modelação baseada em código, a automatização e a partilha aberta. Os estudos analisados indicam que o OpenSCAD é particularmente adequado a fluxos de personalização digital em que o modelo é configurado através de parâmetros, evitando a edição manual da geometria a cada alteração. Esta característica permite associar o ficheiro-fonte a interfaces web, gerar múltiplas variantes de forma controlada e disponibilizar modelos reutilizáveis em comunidades distribuídas. A

possibilidade de ajustar o modelo sem editar directamente o código em cada iteração reforça a sua pertinência em contextos de personalização e fabrico digital (Nilsiam & Pearce, 2017). Para um projecto que aproxima parametrização, interface e apoio computacional, esta característica é especialmente relevante.

Contudo, esta abordagem apresenta limitações importantes. Uma delas prende-se com a exigência técnica e conceptual associada à programação. Mesmo quando o modelo é modular e bem estruturado, a edição directa em OpenSCAD requer capacidade de interpretar transformações geométricas, dependências paramétricas e operações booleanas. Por essa razão, a utilidade do OpenSCAD aumenta quando o sistema é mediado por camadas intermédias de interface ou por procedimentos que exponham apenas os parâmetros necessários à configuração. A segunda limitação é de natureza geométrica. A modelação por combinação de sólidos, habitualmente designada por Constructive Solid Geometry (CSG), favorece a criação de peças mecânicas, modulares e relativamente discretas, mas tende a ser menos adequada à definição de superfícies orgânicas complexas ou de interfaces anatómicas altamente irregulares, sobretudo quando comparada com ferramentas orientadas para superfícies livres.

Há ainda uma limitação relacionada com a interoperabilidade. Os estudos comparativos sobre OpenSCAD sublinham que este ambiente de modelação está fortemente orientado para formatos baseados em malhas, nos quais a geometria é representada por uma aproximação poligonal da superfície, como acontece nos ficheiros STL. Esta orientação favorece fluxos de fabrico digital e impressão 3D, mas pode dificultar a integração com certos circuitos CAD industriais ou com ambientes que exijam a preservação completa da informação paramétrica em formatos normalizados (Machado et al., 2019). Isto não invalida a adequação do OpenSCAD ao presente projecto, mas significa que a sua adoção deve ser vista como uma escolha situada: muito eficaz para estruturar um núcleo paramétrico explícito, menos adequada quando o objectivo depende de plena continuidade com certos fluxos proprietários de engenharia.

Por fim, a avaliação da abordagem exige articular a geração da geometria com as etapas seguintes. Mesmo quando a lógica paramétrica é clara e as restrições estão integradas, a confirmação técnica do modelo depende da inspecção durante a preparação para impressão 3D, do controlo dimensional, de eventual simulação estrutural e da observação da peça física.

Em consequência, o valor do OpenSCAD nesta investigação não reside numa promessa de automatização total, mas na capacidade de fornecer uma infraestrutura técnica clara para ligar a personalização antropométrica, a modularidade, as restrições de fabrico e a documentação do processo. É precisamente essa combinação entre explicitação, reexecução e possibilidade de revisão crítica que justifica a sua escolha como base para a modelação paramétrica aqui desenvolvida.

4.3.3 RELAÇÕES IMPLEMENTADAS NOS MODELOS AVALIADOS

As relações gerais das Tabelas 4.5 e 4.6 foram concretizadas de forma diferente em cada família. A Tabela 4.8 identifica as entradas activas, os cálculos derivados e os limites existentes nas versões usadas nos ensaios. As fórmulas descrevem a implementação; não representam relações anatómicas universais.

Tabela 4.8 — Relações paramétricas dos modelos avaliados

Modelo	Entrada principal	Relação implementada	Parâmetros derivados e limite
Flexy Beast	palm_breadth_mm e comprimentos dos cinco dedos	$xScaleFactor = (palm_breadth_mm + 5) / 55$; o comprimento médio regula o multiplicador geral dos dedos e os restantes comprimentos definem proporções relativas	fingerLength = middle_finger_length_mm / $(37 \times xScaleFactor)$; largura da palma entre 55 e 110 mm
Paraglider Hand	palm_breadth_mm e comprimentos dos cinco dedos	overall_scale = palm_breadth_mm / 66,4; a palma mantém escala uniforme para preservar furos circulares e os dedos recebem ajustes próprios	A palma Reborn exige scale(overall_scale / 1,25) no ponto de chamada; largura declarada entre 55 e 110 mm
UnLimbited Phoenix	palm_breadth_mm e, nas versões posteriores, comprimentos por dedo	HandPerc = palm_breadth_mm / 82 $\times 100$, limitado ao intervalo do modelo; a montagem é escalada de forma uniforme	HandPerc e HandPerc_override limitados entre 100% e 160%; valores de palma abaixo de 82 mm ficam no mínimo de 100%

No Flexy Beast, a largura metacarpal determina a escala global da palma e dos componentes estruturais. Os comprimentos digitais permitem alterar o alcance relativo de cada dedo, mas várias espessuras e interfaces continuam ligadas à escala da mão. No Paraglider, o escalonamento uniforme da palma é uma restrição deliberada: uma deformação diferente nos eixos X e Y transformaria os furos dos pinos em elipses e poderia impedir a montagem. Esta opção limita a adaptação local da palma, ao mesmo tempo que protege uma interface mecânica do desenho original.

No UnLimbited Phoenix, o piso de 82 mm decorre da gama dimensional adoptada pelo modelo integrado. Um perfil infantil abaixo desse valor gera a dimensão mínima suportada e deixa de representar a estimativa de entrada. O sistema deve, por isso, informar que o modelo não cobre esse perfil, em vez de descrever o resultado como adaptação anatómica. Esta diferença confirma que os limites pertencem à combinação entre dados, regras e arquitectura de cada modelo; não devem ser inferidos a partir do nome genérico «mão protésica».

Os parâmetros de lateralidade constituem uma classe separada. mirrored no Flexy Beast e no Paraglider e LeftRight no Phoenix são definidos pela interface. Desde a versão 14.19.0, estes campos possuem o papel

laterality, ficam fora do pedido de sugestões e são descartados caso surjam na resposta da IA. A regra geométrica permanece determinística e independente do texto gerado pelo modelo de linguagem.

4.4 ITERAÇÕES, REFINAMENTO E DISCUSSÃO INTERMÉDIA

O desenvolvimento do modelo paramétrico não ocorreu, desde o início, como uma sequência linear orientada para uma solução estável e definitiva. Pelo contrário, evoluiu através de ciclos sucessivos de formulação, teste, correcção e reconfiguração, em coerência com a perspectiva de Research Through Design, segundo a qual o próprio processo projectual constitui um meio de produção de conhecimento (Zimmerman, Forlizzi, & Evenson, 2007). Neste enquadramento, cada versão do modelo funcionou simultaneamente como protótipo operativo e como dispositivo crítico, permitindo tornar visíveis as limitações, reformular os critérios e aprofundar a compreensão das relações entre dados antropométricos, organização geométrica, requisitos funcionais e constrangimentos de fabrico.

A necessidade de iteração tornou-se particularmente evidente porque a modelação paramétrica, apesar da sua aparência sistemática, depende de um equilíbrio delicado entre abstracção e concretização. Numa fase inicial, a estrutura do sistema assentou na definição de um conjunto de parâmetros julgados essenciais e numa primeira hierarquia entre variáveis de entrada, valores derivados e restrições. No entanto, à medida que o modelo foi sendo testado em diferentes cenários, verificou-se que a mera disponibilidade de muitos parâmetros não aumentava, por si só, a capacidade de personalização. Pelo contrário, a exposição excessiva de variáveis tendia a tornar o sistema mais opaco, menos previsível e mais vulnerável a incoerências geométricas, confirmando a importância de limitar e estruturar cuidadosamente o espaço configurável (Ozdemir, Verlinden, & Cascini, 2022; Lei, Yao, Moon, & Bi, 2016).

Uma parte decisiva do refinamento incidiu na reorganização da arquitectura paramétrica. O objectivo passou de permitir alterações livres para garantir alterações controladas. Isto implicou reduzir redundâncias, clarificar dependências internas e distinguir os parâmetros estruturantes dos ajustamentos secundários. Procurou-se construir uma lógica hierárquica em que as relações críticas permanecessem explícitas e com origem identificável. Esta passagem favoreceu a manutenção do código e a solidez do modelo, dado que a literatura sublinha que a qualidade das relações paramétricas é determinante para famílias de produto adaptáveis e tecnicamente consistentes (Lei et al., 2016; Wiberg, Persson, & Ölvander, 2019).

À medida que a estrutura geral se consolidou, o trabalho iterativo deslocou-se para a decomposição do sistema em módulos relativamente autónomos. Esta organização modular permitiu isolar problemas, testar componentes de forma localizada e introduzir alterações sem comprometer integralmente o comportamento global do modelo. No contexto do presente projecto, esta estratégia revelou-se especialmente útil na articulação entre elementos estruturais, zonas de contacto, interfaces mecânicas e componentes de ligação. Para além de organizar o código, a divisão do modelo em módulos contribuiu para clarificar progressivamente a lógica do objecto, aproximando-o de uma estrutura configurável, mais sistemática e compatível com futuros contextos de interface ou de configuração apoiada (Nilsiam & Pearce, 2017).

As iterações também mostraram que a robustez de um modelo paramétrico só se torna legível quando confrontado com situações-limite. Um sistema pode parecer estável dentro de uma faixa reduzida de variação

e, ainda assim, revelar fragilidades relevantes quando submetido a combinações menos previsíveis de parâmetros. Foi precisamente nesse tipo de ensaio que surgiram problemas como interseções indevidas entre componentes, espessuras insuficientes em zonas críticas, desalinhamentos de interfaces, incompatibilidades entre dimensões derivadas e perdas localizadas de coerência proporcional. O refinamento consistiu, assim, menos na correcção pontual de erros isolados e mais na identificação de padrões recorrentes de instabilidade, o que levou à introdução progressiva de verificações condicionais, limites paramétricos e ajustes automáticos.

Outro eixo central do processo prendeu-se à relação entre personalização e fabrico. Nem todas as variações formalmente admissíveis se revelaram compatíveis com as exigências do fabrico. Algumas configurações gravavam geometrias excessivamente finas, folgas insuficientes ou desproporcionadas, transições abruptas e zonas potencialmente frágeis no contexto da impressão 3D. Neste sentido, a evolução do modelo confirmou a relevância de integrar critérios de Design for Additive Manufacturing à própria lógica paramétrica, em vez de tratá-los como uma verificação externa e posterior. A literatura sobre DfAM aponta precisamente para a necessidade de incorporar tolerâncias, espessuras mínimas, orientações de fabrico e limites materiais desde a fase de concepção, reduzindo falhas e encurtando os ciclos de reimpressão e de correcção (Chtioui, Gaha, & Benamara, 2023; Wiberg et al., 2019).

Em sistemas configuráveis para próteses, a coerência geométrica e a compatibilidade com o processo de impressão são insuficientes para assegurar a adequação ao uso. A articulação entre segmentos, o posicionamento relativo dos mecanismos, a distribuição de massa, as zonas sujeitas a esforço e a amplitude de movimento influenciam directamente o desempenho esperado do objecto. Por essa razão, várias versões do modelo implicaram reajustes que articularam a correcção formal da geometria com a procura de equilíbrio entre adaptação dimensional, comportamento funcional esperado e viabilidade material.

O refinamento correspondeu, assim, a uma negociação contínua entre a simplificação paramétrica e as exigências funcionais e materiais do protótipo.

Do ponto de vista metodológico, este percurso ultrapassa uma sucessão de tentativas e erros. Cada iteração reconfigurou a compreensão do problema e tornou mais explícitos aspectos que não eram plenamente antecipáveis na formulação inicial. Entre eles, destacam-se a dificuldade de traduzir certas qualidades anatómicas em relações paramétricas simples, a tendência de modelos demasiado abertos a perderem consistência e a necessidade de explicitar restrições para preservar a coerência perante as alterações. O conhecimento produzido abrange o estado final do modelo e o processo de convergência crítica que permitiu delimitar o que pode ser parametrizado neste contexto (Zimmerman et al., 2007).

A discussão intermédia decorrente destas iterações permite tirar algumas conclusões provisórias. Em primeiro lugar, confirma-se que a modelação paramétrica baseada em código constitui um enquadramento adequado para estruturar sistemas configuráveis, desde que a arquitetura seja disciplinada e os parâmetros expostos sejam criteriosamente seleccionados. Em segundo lugar, verifica-se que a robustez do sistema depende menos da quantidade de variáveis disponíveis do que da qualidade das relações estabelecidas entre elas. Em terceiro lugar, torna-se claro que a personalização eficaz exige integração simultânea de critérios antropométricos, funcionais e produtivos, não podendo ser reduzida a mera transformação geométrica. Por fim,

a iteração evidencia-se como mecanismo indispensável de convergência: não encerra definitivamente o sistema, mas estabiliza uma versão suficientemente consistente para sustentar as fases seguintes de plataforma, integração digital e exploração apoiada.

CAPÍTULO 5 — PLATAFORMA WEB E INTEGRAÇÃO DIGITAL

5.1 ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL E PERFIS DE UTILIZADOR

A plataforma web desenvolvida no âmbito deste projecto constitui a camada de mediação entre o modelo paramétrico, os dados de entrada e a configuração digital da mão protésica. Trata-se de um protótipo de investigação funcional, alojado na branch staging, e não de um produto preparado para utilização clínica. O seu enquadramento assenta numa interface que traduz dados antropométricos, decisões de configuração e critérios de fabrico em parâmetros operacionais, evitando que a edição dependa do contacto directo com o código. Esta leitura é coerente com os estudos sobre personalização digital e personalização em massa, que descrevem os configuradores como sistemas capazes de expor uma parte controlada do espaço de variação sem comprometer as relações do modelo-base (Ozdemir, Verlinden, & Cascini, 2022; Stralen, 2018).

Do ponto de vista funcional, a plataforma foi concebida para suportar um processo progressivo de personalização, no qual a definição geométrica da prótese resulta da articulação entre a recolha de dados, a selecção do modelo, o ajustamento de parâmetros, a visualização do resultado e a eventual exportação para prototipagem. Esta organização procura reduzir a distância entre o domínio técnico da modelação paramétrica e o contexto aplicado de utilização clínica, experimental ou de projecto.

Em vez de exigir que cada interveniente compreenda a estrutura interna do ficheiro OpenSCAD, o sistema disponibiliza uma camada de interacção mais acessível, baseada em controlos paramétricos, pré-visualização tridimensional e gestão de configurações.

Tal opção aproxima-se de abordagens recentes em plataformas de personalização de próteses, nas quais a interface funciona como meio de tornar observável, configurável e progressivamente verificável um processo que, de outro modo, permaneceria dependente de software especializado ou de mediação exclusivamente técnica (Peixoto et al., 2025).

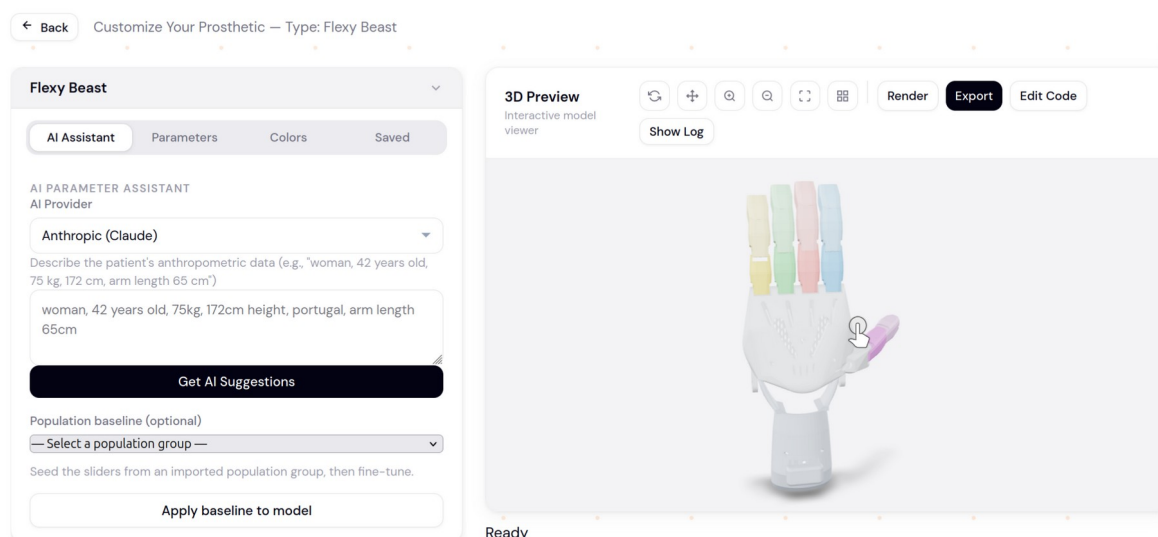


Figura 5.1 — Fluxo geral de produção personalizada de próteses a partir de plataforma web – Hand Fab
Produção própria

Neste sentido, a plataforma constitui uma infra-estrutura de mediação entre componentes técnicos, utilizadores e intervenientes especializados. A configuração é enquadrada como um processo distribuído, no qual diferentes intervenientes participam com graus distintos de responsabilidade, conhecimento e controlo.

Num contexto de próteses personalizadas, o resultado final pode depender da articulação entre o utilizador final, o designer, o técnico ou o clínico, bem como de condicionantes produtivas e de critérios de validação. A plataforma procura, assim, oferecer uma infra-estrutura digital que acomode essa pluralidade de agentes sem comprometer a consistência técnica da configuração paramétrica nem deslocar indevidamente a responsabilidade para o utilizador menos especializado (Bai, Yuan, Liu, Huang, & Feng, 2024; Quintero et al., 2018).

A definição dos perfis de utilizador constitui, por isso, uma decisão estruturante no desenho da plataforma, uma vez que determina como se distribuem responsabilidades, permissões e formas de intervenção no processo de personalização. O sistema organiza-se em três perfis principais: administrador, técnico e utilizador.

O perfil de administrador assegura a gestão global da plataforma, incluindo a criação de contas, a definição de permissões e a supervisão do ecossistema de configurações, incluindo da base de dados antropométricos. O perfil técnico, pensado para profissionais intermédios, como técnicos de ortoprotesia, clínicos ou operadores especializados, permite criar, editar e acompanhar configurações próprias e, quando aplicável, aceder às configurações dos utilizadores sob sua responsabilidade. O perfil de utilizador corresponde ao nível mais restrito, centrado na consulta das suas configurações, no acompanhamento do processo e em interações delimitadas pelo sistema.

Esta segmentação traduz uma lógica de controlo de acesso baseada em papéis, procurando equilibrar autonomia, segurança e responsabilidade distribuída ao tornar claros os limites de intervenção de cada perfil. A diferenciação participa directamente na forma como a plataforma enquadra a configuração.

Ao reservar certos parâmetros, decisões ou operações a perfis técnicos, o sistema reconhece que alguns aspectos da configuração exigem acesso condicionado. Em domínios sensíveis, como o das próteses, a interface deve tornar o processo visível e delimitar o campo de acção de acordo com critérios de supervisão e segurança. A literatura sobre interfaces clínicas e interacção em próteses inteligentes aponta para a necessidade de distinguir entre participação informada do utilizador e controlo técnico supervisionado, evitando a opacidade excessiva e a transferência imprudente de responsabilidade para agentes sem formação específica (Bai et al., 2024; Quintero et al., 2018).

Deste modo, o enquadramento conceptual da plataforma articula três objectivos complementares: tornar a lógica paramétrica operável em ambiente web, estruturar a configuração como um processo progressivo e compreensível e distribuir o acesso às operações de acordo com papéis diferenciados. Nesta fase, a plataforma permite editar parâmetros à distância e reorganiza o processo como uma sequência apoiada, documentada e sujeita a análise crítica. É nessa articulação entre capacidade de configuração, mediação pela interface e organização por perfis que a secção seguinte, dedicada à arquitectura geral do sistema, encontra a sua base conceptual.

5.2 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

O sistema organiza-se numa estrutura em camadas que distingue interface, configuração, cálculo geométrico, visualização, persistência e serviços externos. Esta opção torna operável um modelo paramétrico tecnicamente exigente em ambiente web sem concentrar interação, cálculo, armazenamento e controlo de acesso no mesmo componente. A Tabela 5.1 apresenta o fluxo completo antes da descrição de cada tecnologia.

Tabela 5.1 — Fluxo de dados e responsabilidades da plataforma

Etapas	Componente	Entrada e saída	Responsabilidade
1	Interface web	Modelo, perfil e valores editados	Recolher escolhas, apresentar limites e manter o estado da configuração
2	Configuração do modelo	models/models-config.json	Declarar parâmetros, tipos, intervalos, etiquetas, dependências e campos excluídos da IA
3	Serviço de IA no servidor	Descrição, esquema e referência populacional; resposta JSON	Intermediar a chamada ao fornecedor e devolver sugestões; não gera geometria
4	Web Worker	Código OpenSCAD e valores	Executar o cálculo fora da tarefa principal da interface
5	OpenSCAD em WebAssembly	Script e dependências; saída OFF, STL ou 3MF	Gerar a geometria no navegador segundo regras determinísticas
6	Conversão para GLB e model-viewer	Geometria OFF ou 3MF	Apresentar a pré-visualização tridimensional e as cores por peça
7	Exportação	Malha STL ou pacote 3MF	Assentar peças em Z=0, preservar milímetros no 3MF e disponibilizar ficheiros para preparação
8	Programa de preparação e impressora FFF	STL/3MF, perfil de impressão e filamento	Definir camadas, orientação, suportes e trajectórias; produzir o

Etapa	Componente	Entrada e saída	Responsabilidade
			protótipo físico
9	Servidor Express e SQLite	Utilizadores, configurações e relações de acesso	Autenticar, aplicar permissões e guardar estados da configuração

A Figura 5.2 mostra a arquitectura implementada e as fronteiras entre navegador, servidor, fornecedor externo de IA e fabrico. A geometria é calculada no navegador; autenticação, dados e pedidos de IA passam pelo servidor; e a preparação para impressão ocorre fora da plataforma.

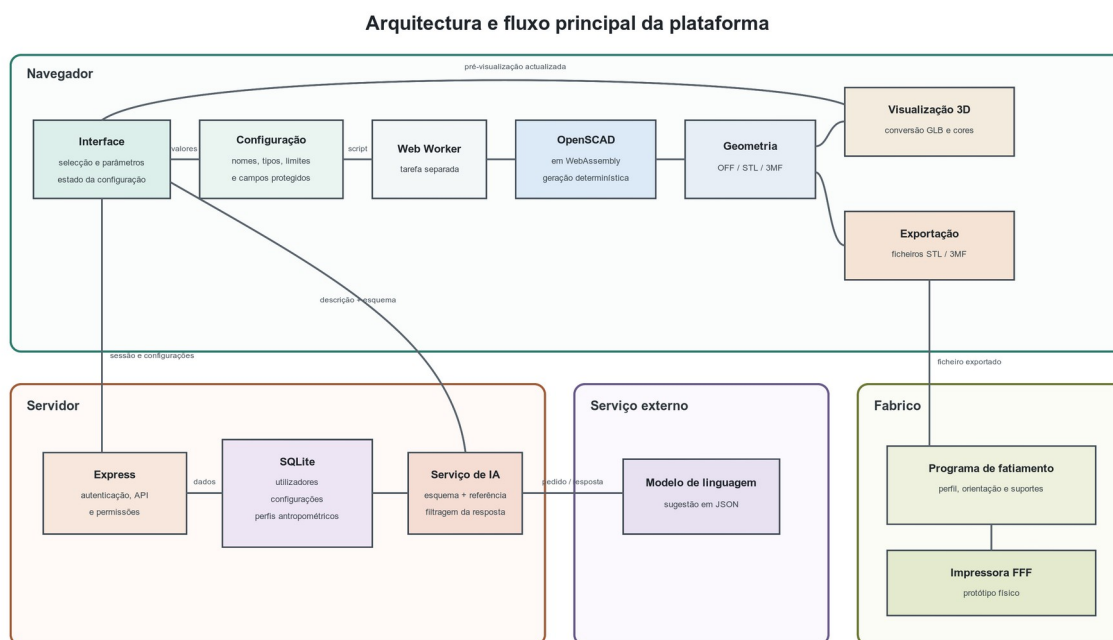


Figura 5.2 — Arquitectura e sequência principal entre interface, configuração, Web Worker, OpenSCAD em WebAssembly, visualização, serviços do servidor, IA externa e fabrico.

Produção própria.

A Figura 5.3 apresenta um precedente de arquitectura de produção personalizada em que a digitalização, o processamento de dados, a adaptação CAD e o fabrico aditivo são articulados num fluxo de ponta a ponta. No presente projecto, a continuidade é transferida para uma plataforma web e para modelos OpenSCAD executados localmente; a captura anatómica por digitalização não foi implementada (Górski et al., 2022).

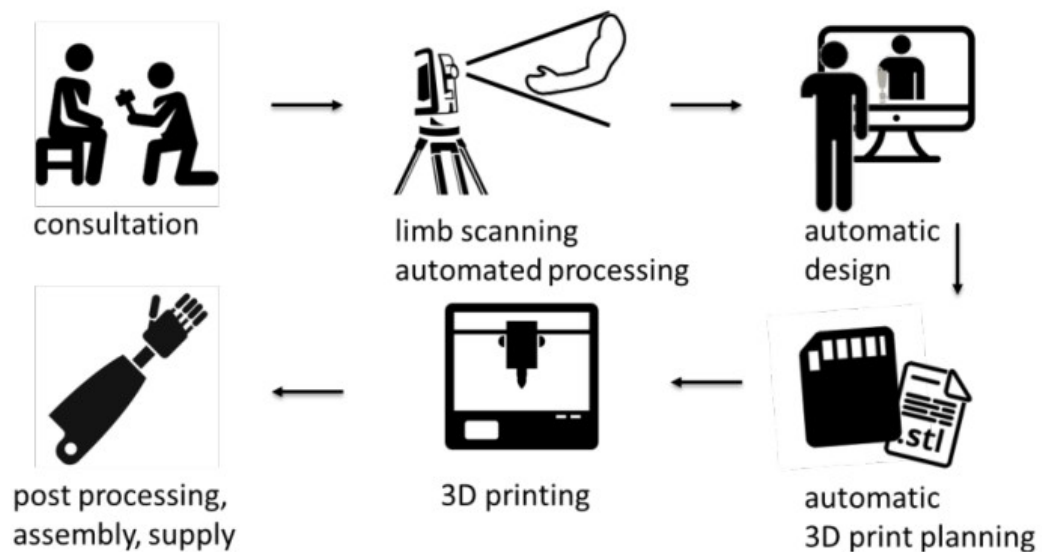


Figura 5.3 — Fluxo geral de produção personalizada de próteses a partir de digitalização, CAD adaptativo e fabrico aditivo.

Fonte original: Górski, F., Zawadzki, P., Wichniarek, R., Kuczko, W., Słupińska, S., & Żukowska, M. (2022). Automated design and rapid manufacturing of low-cost customized upper limb prostheses. *Journal of Physics: Conference Series*, 2198, 012040. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2198/1/012040> (<https://doi.org/10.1088/1742-6596/2198/1/012040>)

No navegador do utilizador, a aplicação integra os componentes responsáveis pela interface, pela recolha e edição de parâmetros, pela gestão do estado da sessão e pela visualização local dos modelos. No servidor, um serviço desenvolvido em Node.js, com recurso ao framework Express.js, assegura a disponibilização de ficheiros estáticos, o processamento de pedidos à API, a autenticação de utilizadores, a aplicação de permissões e a comunicação com a camada de persistência. Esta distribuição de responsabilidades evita que a interface dependa de processamento remoto contínuo para todas as operações e, simultaneamente, impede que tarefas sensíveis, como a gestão de utilizadores, o controlo de acessos e a comunicação com serviços externos, fiquem expostas diretamente no cliente. A arquitetura não corresponde, portanto, a uma simples divisão técnica entre “frente” (frontend) e “retaguarda” (backend), mas sim a uma estratégia de contenção da complexidade e de delimitação explícita de responsabilidades.

A camada de persistência assenta numa base de dados SQLite, utilizada para armazenar contas de utilizador, configurações guardadas, relações de atribuição técnica e tokens de autenticação. A escolha desta solução responde ao carácter prototípico e funcional do sistema nesta fase da investigação, privilegiando a leveza de implementação, a portabilidade e a facilidade de manutenção. As configurações paramétricas são armazenadas como estruturas JSON associadas a um modelo e a um utilizador, permitindo preservar diferentes instâncias, recuperá-las em momentos posteriores e compará-las como estados distintos do processo de projecto. A base de dados funciona como repositório administrativo e sustenta a continuidade do processo, a gestão prática de versões e o acompanhamento das variantes produzidas.

Um dos aspectos mais relevantes da arquitetura é que a renderização geométrica não é executada no servidor. Em vez disso, o cálculo e a geração da geometria tridimensional ocorrem localmente no navegador, através de uma versão do OpenSCAD compilada para WebAssembly, tecnologia que permite executar código de elevado desempenho em ambiente web. Este processo é realizado num Web Worker, isto é, numa tarefa separada da interface principal, evitando que a geração do modelo bloqueie a interação do utilizador com a plataforma. Esta decisão reduz a carga computacional do backend, diminui a dependência de um serviço remoto de renderização e favorece uma interação mais imediata durante a edição paramétrica. Ao mesmo tempo, preserva-se uma fronteira clara: o servidor mantém-se responsável pela autenticação, armazenamento, gestão de configurações e intermediação de chamadas a serviços de inteligência artificial, enquanto o cliente assume a computação geométrica intensiva. A arquitetura resultante é, assim, híbrida: centraliza funções de controlo e persistência, mas distribui localmente a geração formal do modelo.

No plano da segurança e do controlo de acesso, a arquitetura incorpora autenticação baseada em JSON Web Token (JWT), um mecanismo que permite verificar a identidade do utilizador através de credenciais digitais temporárias. A plataforma utiliza ainda tokens de atualização armazenados em cookies HttpOnly, isto é, cookies que não podem ser acedidos diretamente por scripts executados no navegador, reduzindo a exposição a certos tipos de ataque. Estes mecanismos são complementados por validação de dados, limitação de pedidos e bloqueio explícito de ficheiros sensíveis.

Estes mecanismos integram o desenho do sistema, sobretudo num contexto em que múltiplos perfis de utilizador operam sobre configurações potencialmente sensíveis e a plataforma articula autonomia de uso com supervisão técnica. A literatura sobre interfaces de configuração em contexto protésico sublinha a importância de equilibrar participação, diferenciação de permissões e enquadramento seguro das operações críticas (Quintero et al., 2018; Bai et al., 2024). Neste sentido, a arquitetura estrutura os componentes segundo requisitos de personalização apoiada, gestão de vários utilizadores e evolução futura da plataforma.

5.3 INTEGRAÇÃO OPENS CAD VIA WEBASSEMBLY (WASM)

A integração do OpenSCAD por meio de WebAssembly, como referido anteriormente, constitui um dos elementos técnicos mais relevantes da plataforma, pois permite executar localmente, no navegador, um modelo paramétrico baseado em código, sem depender de um serviço externo de renderização contínua. O OpenSCAD funciona como linguagem e ambiente de modelação em que a geometria é definida por instruções escritas, parâmetros numéricos e relações explícitas entre componentes, em vez de resultar exclusivamente de manipulação gráfica directa. O WebAssembly (WASM), por sua vez, possibilita a execução de aplicações compiladas com desempenho próximo ao nativo no contexto da web. A articulação entre ambos torna viável um cenário particularmente pertinente para esta investigação: preservar a lógica algorítmica do modelo e, ao mesmo tempo, disponibilizá-la num ambiente de utilização mais acessível, orientado por uma interface (Machado et al., 2019; Nilsiam & Pearce, 2017).

Operacionalmente, a integração articula três elementos principais: os ficheiros .scad, formato de script utilizado pelo OpenSCAD para definir modelos geométricos por código; os parâmetros introduzidos ou ajustados na interface; e o ambiente de execução em WebAssembly. Quando o utilizador altera uma

configuração, a plataforma envia os valores actualizados para um Web Worker, que aplica esses parâmetros ao modelo em OpenSCAD e gera a geometria tridimensional correspondente. O resultado é depois devolvido ao visualizador no navegador, permitindo observar os efeitos das alterações sem recorrer a software CAD instalado localmente. Este fluxo estabelece uma ligação directa entre edição paramétrica, cálculo geométrico e resposta visual, permitindo documentar, verificar e analisar o processo dentro da plataforma.

Do ponto de vista metodológico, esta solução tem implicações importantes. Em primeiro lugar, preserva o estatuto do modelo paramétrico como especificação explícita e não como caixa negra geométrica. A plataforma não substitui o OpenSCAD por uma representação simplificada desligada do código; antes, torna o próprio núcleo algorítmico operável em ambiente web. Em segundo lugar, esta integração reduz a distância entre modelação e interacção, permitindo que a exploração formal decorra num contexto mais observável e iterativo. O utilizador não necessita de dominar a sintaxe do OpenSCAD para beneficiar da estrutura paramétrica do modelo, mas essa estrutura continua a ser a base efetiva da geometria apresentada. Neste sentido, a plataforma atua como uma camada intermédia entre a disciplina técnica do código e a experiência configurável descrita na literatura sobre configuradores e sistemas de personalização digital (Nilsiam & Pearce, 2017; Ozdemir et al., 2022).

Do ponto de vista técnico, o uso de Web Workers é especialmente relevante porque impede que a renderização bloqueie a interface principal. Em modelos geometricamente mais exigentes, o cálculo pode ser intensivo; se fosse executado diretamente na thread principal do navegador, comprometeria a fluidez da interacção. Ao mover esse trabalho para um processo separado, a plataforma mantém uma experiência mais estável, mesmo quando a geração não é instantânea. A renderização permanece integralmente no lado do cliente, o que reforça a autonomia local do sistema e reduz o tráfego e a carga associados ao backend. Esta decisão complementa a arquitetura híbrida descrita na secção anterior: o servidor conserva funções de autenticação, persistência e mediação com serviços externos, enquanto o navegador assume a computação geométrica diretamente relacionada com a exploração paramétrica.

Esta integração tem valor estratégico no contexto da investigação, pois aproxima a modelação baseada em código da operação através de uma plataforma web. A literatura sobre OpenSCAD sublinha a sua afinidade com fluxos consistentes, configuradores digitais e partilha de modelos paramétricos em ambientes abertos, embora muitas vezes fora de contextos protésicos e clínicos (Machado et al., 2019; Nilsiam & Pearce, 2017). No presente projecto, a adopção de WASM integra, na mesma infra-estrutura, a transparência do modelo paramétrico, o acompanhamento das interacções e a actualização iterativa da geometria.

Não obstante as vantagens, esta solução introduz limitações que importa reconhecer: O desempenho da renderização depende da complexidade do modelo, dos valores paramétricos escolhidos e dos recursos do dispositivo do utilizador, podendo resultar em tempos de espera mais longos para geometrias mais exigentes. Acresce que o carregamento inicial do módulo WASM, a serialização de dados entre a interface e o worker e a própria conversão da saída geométrica para formatos visualizáveis introduzem sobrecarga que não existe da mesma forma em ambientes CAD locais dedicados. Assim, a integração de OpenSCAD via WebAssembly deve ser entendida como um compromisso tecnicamente situado: amplia a acessibilidade e a autonomia local,

mas apenas dentro dos limites computacionais e operacionais do navegador. O valor da solução reside, por isso, menos numa promessa de desempenho absoluto e mais na capacidade de tornar executável, em ambiente web, um núcleo paramétrico explícito, verificável e sujeito a revisão crítica.

5.4 ESTRUTURA FUNCIONAL DA PLATAFORMA

A estrutura funcional da plataforma organiza-se num conjunto de módulos interligados que suportam o ciclo de configuração paramétrica: selecção do modelo, introdução e edição de parâmetros, visualização tridimensional, sugestões apoiadas por IA, gestão de configurações e administração multiutilizador. Esta organização modular distribui as funcionalidades da plataforma e estrutura o processo como uma sequência clara de operações.

Em vez de expor o utilizador a um ambiente indiferenciado de opções, a plataforma reparte o trabalho por etapas e componentes com funções distintas, o que está de acordo com a literatura sobre configuradores digitais, segundo a qual a eficácia da personalização depende, em grande medida, da clareza com que o sistema delimita o espaço de ação disponível e articula feedback com decisão (Ozdemir et al., 2022; Peixoto et al., 2025).

A Figura 5.4 ilustra um precedente particularmente próximo desta lógica: uma ferramenta paramétrica orientada a terapeutas ocupacionais, na qual múltiplas variantes de produto podem ser configuradas a partir de dimensões, materiais e pesos ajustáveis. A sua pertinência para esta dissertação reside em demonstrar que a parametrização ganha valor quando é mediada por uma interface dirigida a profissionais que não são necessariamente especialistas em modelação CAD.

(Li & Aflatoony, 2025).

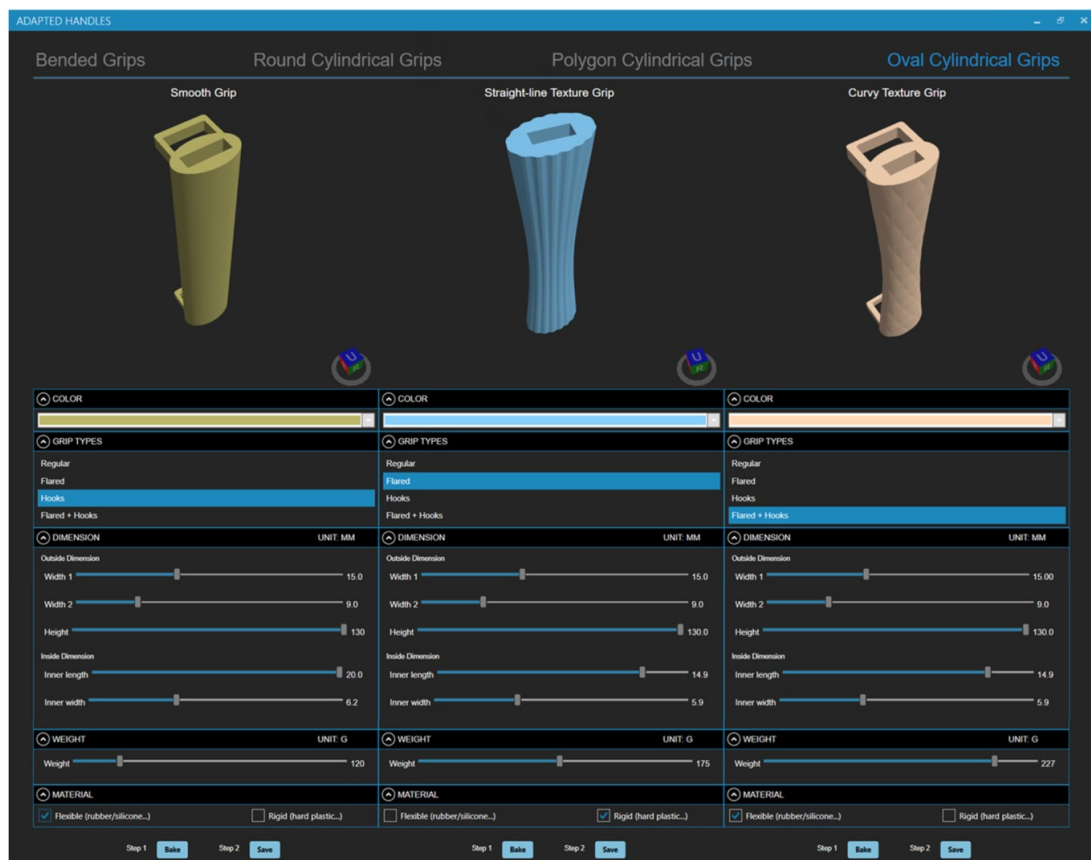


Figura 5.4 — Ferramenta paramétrica para configuração de ajudas técnicas com variação de dimensões, materiais e peso.

Fonte original: Li, M., & Aflatoony, L. (2025). Parametric design and three-dimensional printing: Enabling occupational therapists to develop custom hand grips. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 20(6), 1829-1837. <https://doi.org/10.1080/17483107.2025.2483953> (<https://doi.org/10.1080/17483107.2025.2483953>)

O ponto de entrada do sistema é o módulo de selecção de modelos. Cada modelo é descrito por um ficheiro de configuração que inclui o identificador, a descrição, o ficheiro OpenSCAD associado e a lista de parâmetros editáveis. A partir dessa estrutura, a interface gera automaticamente os controlos necessários para editar esses parâmetros, incluindo campos numéricos, selectores de valores dentro de intervalos definidos, caixas de selecção e campos de texto. Esta opção reduz a rigidez do sistema e permite acomodar famílias distintas de modelos paramétricos sem exigir reprogramação manual de cada ecrã. Em termos funcionais, este módulo atua como mediador entre a biblioteca de modelos e a interface, convertendo uma estrutura técnica de ficheiros e parâmetros num ponto de entrada compreensível para a configuração.

O núcleo operativo da plataforma situa-se, depois, na articulação entre o módulo de edição paramétrica e o de visualização 3D. Quando os parâmetros são alterados, o sistema recompõe o código, aciona a renderização local e devolve ao utilizador a geometria actualizada. Esta ligação directa entre edição e pré-visualização é decisiva do ponto de vista funcional, pois transforma a manipulação de variáveis abstratas em observação imediata das suas consequências formais. Funções de reposição de valores por defeito, actualização incremental

e exportação de ficheiros STL ou 3MF alargam esta utilidade para além da mera experimentação visual, aproximando a plataforma de um ambiente de prototipagem e de preparação para fabrico. A literatura sobre interfaces para configuração apoiada em contexto protésico sugere precisamente que a legibilidade do processo melhora quando o utilizador consegue relacionar a ação, a consequência geométrica e a possibilidade de validação num mesmo circuito de interacção (Peixoto et al., 2025; Quintero et al., 2018).

Sobre esta base opera o módulo de apoio por inteligência artificial, que introduz uma camada adicional de mediação sem substituir a lógica principal da configuração. A partir de uma descrição livre do utilizador, ou de medidas antropométricas parciais, a interface constrói dinamicamente um pedido que inclui o esquema actual do modelo seleccionado: nomes dos parâmetros, legendas, tipos, limites mínimos e máximos e valores correntes. Esse pedido é enviado ao servidor por uma rota autenticada, que atua como intermediário entre a plataforma e o serviço externo de IA. A resposta esperada é um objecto JSON simples, composto apenas por pares parâmetro-valor. A aplicação aceita apenas chaves existentes no esquema, descarta parâmetros desconhecidos e aplica os valores resultantes aos controlos antes de accionar uma nova renderização em OpenSCAD/WebAssembly.

Esta arquitectura corrige uma fragilidade identificada numa versão anterior do sistema, em que o pedido à IA permanecia demasiado associado a um modelo já removido e podia induzir sugestões com nomes de parâmetros inexistentes. Ao ancorar a sugestão no esquema actual do modelo activo, a IA passa a operar sobre a mesma gramática paramétrica que a interface, os perfis antropométricos importados e o modelo OpenSCAD. Este módulo propõe pontos de partida compatíveis com o esquema e reduz a carga inicial de parametrização. A IA integra-se no fluxo como apoio à decisão, sob controlo humano, e não gera autonomamente a prótese.

A evolução posterior do módulo acrescentou uma referência opcional baseada em dados populacionais. Quando a interface envia a descrição do utilizador e o identificador do modelo, o servidor procura o perfil antropométrico populacional com melhor pontuação segundo sexo, idade aproximada e país, e projecta as médias desse perfil sobre os parâmetros disponíveis no modelo activo. O bloco de referência é anexado ao pedido enviado à IA, permitindo orientar a sugestão sem se sobrepor a medições fornecidas pelo utilizador. Esta solução estabelece continuidade entre três formas de introdução de dados: selecção manual de um perfil populacional, importação de perfis antropométricos e sugestão apoiada por IA.

Outro componente central é o módulo de gestão de configurações. A possibilidade de nomear, guardar, recuperar, actualizar e eliminar instâncias é particularmente relevante num processo iterativo, em que diferentes variantes podem corresponder a hipóteses sucessivas ou a estados finais. Este módulo transforma a configuração de um acto momentâneo numa sequência acumulativa, na qual diferentes estados podem ser recuperados e comparados. A gestão de configurações integra, assim, a estrutura funcional que permite acompanhar o processo ao longo do tempo.

Por fim, a plataforma inclui um módulo administrativo e de controlo de acesso que suporta a organização multi-utilizador. Este módulo assegura a criação de contas, a diferenciação de permissões, a atribuição de utilizadores a técnicos e a delimitação das ações acessíveis a cada perfil.

A sua presença confirma que a estrutura funcional da plataforma abrange a manipulação de parâmetros, a visualização de formas e a gestão das relações entre agentes, responsabilidades e níveis de intervenção. Neste sentido, a aplicação obtém sugestões paramétricas através do servidor, que comunica com serviços externos por intermédio de um proxy seguro, enquadrando essa capacidade numa estrutura funcional mais ampla, em que configuração, supervisão e persistência coexistem como partes de um mesmo sistema operativo.

A biblioteca organiza diferentes famílias como modelos registados, cada uma com parâmetros, dependências, limites e modos de visualização próprios. Na versão 14.67.0, quatro modelos surgem no ficheiro de configuração: Flexy Beast, UnLimbited Phoenix Hand, Paraglider Hand e Cyborg Beast. Os ensaios dimensionais comparativos desta dissertação abrangem os três primeiros; o Cyborg Beast foi integrado posteriormente e não entra nas tabelas comparativas. A reconstrução designada pec Phoenix hand permanece como material de desenvolvimento no repositório e não está registada na plataforma. Esta distinção impede confundir biblioteca actual, conjunto avaliado e trabalhos exploratórios.

Tabela 5.2 — Estado dos modelos no fecho do estudo

Modelo	Registado na versão 14.67.0	Ensaio dimensional comparativo	Projecto de preparação arquivado
Flexy Beast	Sim	Sim	Sim, Bambu Lab A1
Paraglider Hand	Sim	Sim	Sim, Prusa MINI
UnLimbited Phoenix Hand	Sim	Sim	Sim, Bambu Lab A1
Cyborg Beast	Sim	Não	Não incluído neste estudo
pec Phoenix hand	Não	Não	Desenvolvimento separado

A integração consistiu em traduzir cada modelo para uma interface comum de parâmetros e em manter as restrições mecânicas específicas. O facto de um modelo aparecer na plataforma confirma a sua integração técnica; não confirma adequação clínica nem equivalência funcional entre famílias.

No caso do Paraglider Hand, também conhecido como Flexible Flyer, a integração partiu de uma mão mecânica accionada pelo corpo, derivada da linhagem Phoenix e UnLimbited. O desafio principal não foi reconstruir a geometria dos dedos, já definida em OpenSCAD, mas alinhar a lógica original do modelo com os nomes canónicos usados pelo sistema. A palma passou a ser controlada pela largura metacarpal, enquanto os dedos foram associados a comprimentos digitais independentes. Esta separação foi importante porque a largura da palma e o comprimento dos dedos não variam necessariamente de forma proporcional. Ao mesmo tempo, a palma teve de manter escalonamento uniforme, uma vez que os furos cilíndricos para pinos metálicos não podem ser deformados em elipses sem comprometer a montagem. Assim, certas medidas, como o comprimento

e a espessura da palma, foram mantidas como informação contextual para a IA e para o perfil antropométrico, mas não foram usadas como transformações geométricas ativas nesse modelo.

A integração do Paraglider revelou limitações práticas da execução de OpenSCAD em WebAssembly. Alguns ficheiros originais usavam construções sintáticas sem suporte na versão compilada para navegador, o que impediu a definição de módulos durante a renderização. A solução foi manter cópias corrigidas dos ficheiros necessários, preservar a origem do modelo e controlar explicitamente as dependências carregadas para o sistema virtual de ficheiros do navegador. Esta etapa mostrou que a compatibilidade web depende da qualidade geométrica do modelo e da forma como bibliotecas, ficheiros importados e variantes de sintaxe são organizados no fluxo digital.

O trabalho realizado sobre modelos do tipo Cyborg Beast/Flexy Hand teve uma função complementar. Estes modelos foram usados como base exploratória para testar uma reparametrização mais ampla, em que a geometria original foi reorganizada em torno de medidas antropométricas da palma, dos dedos, do punho e do membro residual. A versão antropométrica resultante não foi tratada como simples escala global: incorporou comprimentos digitais, espessuras estruturais, canais internos, parâmetros de hardware e dimensões de encaixe derivadas de medidas do antebraço. Essa experiência foi útil para clarificar a diferença entre adaptar um modelo existente por multiplicadores gerais e reconstruir a sua lógica dimensional em torno de uma estrutura antropométrica coerente. Mesmo quando determinados modelos permaneceram como material de desenvolvimento e comparação, contribuíram para estabilizar a taxonomia de parâmetros que a plataforma passou a exigir aos modelos ativos.

Em conjunto, estes casos mostram que a expansão da plataforma depende menos da quantidade de modelos disponíveis e mais da existência de uma gramática comum de integração. Cada nova prótese a integrar no sistema exige três operações: identificar quais parâmetros antropométricos são relevantes, decidir que parâmetros podem alterar a geometria sem quebrar interfaces mecânicas e declarar essas relações de forma compreensível para a interface, para o renderizador e para a camada de IA. A biblioteca de modelos torna-se, assim, um campo de validação técnica da própria arquitetura: quanto mais heterogêneos forem os modelos integrados, mais clara se torna a necessidade de separar dados antropométricos, regras geométricas, restrições de fabrico e sugestões apoiadas.

5.5 GESTÃO DE PARÂMETROS, VERSÕES E EXPANSÃO

Controlar parâmetros constitui uma das condições centrais para transformar um modelo paramétrico num sistema utilizável e persistente. No caso da plataforma desenvolvida, essa gestão é operacionalizada através de ficheiros de configuração que descrevem cada parâmetro segundo atributos como nome, tipo, valor inicial, limites, incrementos e agrupamento temático. Esta estrutura formaliza a relação entre o código OpenSCAD, o espaço de alteração permitido e os mecanismos de controlo disponibilizados ao utilizador. Em termos metodológicos, esta opção aproxima-se da lógica descrita na literatura sobre configuradores e personalização digital, segundo a qual a eficácia do sistema depende da capacidade de expor parâmetros relevantes dentro de limites claros e controlados, preservando a coerência interna do modelo-base (Ozdemir et al., 2022; Lei et al., 2016).

Ao descrever os parâmetros em estruturas independentes do código geométrico principal, a plataforma obtém duas vantagens. Primeiro, permite identificar as variáveis editáveis, os seus intervalos e a articulação com a interface. Segundo, permite adaptar a estrutura do sistema: os parâmetros podem ser adicionados, removidos ou ajustados sem reescrever toda a lógica de interação. A gestão de parâmetros funciona, assim, como camada intermédia entre a definição geométrica e a experiência de uso, mantendo o modelo tecnicamente explícito sem exigir contacto directo com a sintaxe interna.

A gestão de versões manifesta-se, neste estágio do projecto, sobretudo através do armazenamento de configurações. A plataforma conserva diferentes conjuntos de parâmetros associados ao mesmo modelo, atribuindo-lhes identificação, notas descritivas e associação a um utilizador. Embora esta solução seja mais simples do que os sistemas completos de gestão de versões usados no desenvolvimento de software, permite acompanhar a configuração ao longo do tempo, preservar variantes e comparar estados sucessivos. Cada configuração registada constitui uma instância documentada do processo, passível de recuperação e comparação. Esta capacidade é importante num contexto em que a configuração resulta de uma sequência de aproximações, testes e correcções.

Do ponto de vista funcional, a persistência dessas configurações em estruturas JSON associadas a modelos e utilizadores reforça a continuidade entre interação, revisão e reutilização. O sistema deixa, assim, de limitar a configuração ao estado temporário da sessão e passa a preservar um registo das configurações realizadas, possibilitando retomar soluções anteriores, documentar alternativas exploradas e preparar comparações futuras entre versões. Esta forma de gestão prática de versões é coerente com o carácter experimental da plataforma: ainda não pretende substituir mecanismos mais sofisticados de gestão de revisões, mas fornece uma base suficiente para sustentar o acompanhamento iterativo do desenvolvimento e a análise reflexiva do processo.

Quanto à capacidade de expansão, a plataforma beneficia de uma arquitetura modular e orientada por ficheiros de configuração. A separação entre modelos, parâmetros, interface, autenticação e persistência permite acrescentar novos modelos em OpenSCAD, novos tipos de parâmetros ou novas rotinas de apoio sem reestruturar integralmente a aplicação. Na prática, a introdução de um novo modelo exige sobretudo a adição do ficheiro .scad correspondente e o seu registo no ficheiro de configuração dos modelos (models-config.json). Esta estrutura evidencia uma lógica de expansão baseada menos na duplicação de código e mais na extensão controlada da plataforma. Esta característica é consistente com a literatura sobre sistemas paramétricos e famílias de produto, que associa robustez e expansão sustentável à qualidade das estruturas relacionais, e não ao aumento indiscriminado de opções ou de módulos independentes (Lei et al., 2016; Ozdemir et al., 2022).

Todavia, esta lógica de expansão deve ser analisada criticamente.

O recurso ao SQLite é adequado a um protótipo funcional com um número reduzido ou moderado de acessos simultâneos, mas poderá revelar limitações em cenários de utilização mais intensiva, com maior volume de configurações, operações frequentes de leitura e escrita ou necessidades mais exigentes de registo e sincronização.

De forma semelhante, a renderização local através de WASM depende do desempenho do dispositivo do utilizador, o que pode originar diferenças na experiência e limita a complexidade geométrica. A expansão da

plataforma depende da capacidade de integrar novas funções e modelos sem comprometer a clareza da organização interna, o desempenho, a segurança e a facilidade de manutenção.

Neste sentido, a secção confirma uma conclusão importante para o projecto: a gestão de parâmetros, de configurações e da expansão futura integra a própria lógica de design da plataforma. A capacidade de configuração, a persistência e o crescimento controlado sustentam uma personalização paramétrica tecnicamente viável, documentável e sujeita a revisão ao longo do desenvolvimento.

CAPÍTULO 6 — INTEGRAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

6.1 PAPEL DA IA NO SISTEMA PROPOSTO

No sistema desenvolvido, a IA assume uma função distinta daquela que surge com maior frequência nos estudos sobre próteses. Enquanto grande parte da investigação consultada se concentra em tarefas de controlo, interpretação de biosinais, reconhecimento de gestos e adaptação funcional, esta investigação explora a IA como camada de apoio à configuração paramétrica, articulada com dados antropométricos, modelos geométricos explícitos e interface web.

Os estudos consultados indicam que, no caso das próteses de membro superior, os métodos computacionais de adaptação e controlo têm incidido sobretudo na interpretação de sinais, na intenção motora e no desempenho operativo do dispositivo. Esta linha de trabalho difere do uso de um modelo de linguagem para sugerir parâmetros iniciais de geometria, que constitui o foco desta plataforma (Cordella et al., 2016; Marinelli et al., 2022; Peerdeman et al., 2011).

Em contrapartida, continuam pouco consolidadas as abordagens que articulam, no mesmo sistema, a entrada antropométrica, o modelo paramétrico explícito, a sugestão apoiada de parâmetros e a supervisão técnica. Esta lacuna é central para a presente investigação, pois permite situar a proposta como uma articulação entre componentes que os estudos consultados tendem a desenvolver de forma fragmentada.

Neste enquadramento, a IA assume a função de camada complementar de apoio à configuração, operando sobre uma base paramétrica já definida e articulando-se com a lógica geométrica do modelo, a decisão de projecto e a verificação técnica. A literatura sobre modelação paramétrica aplicada a próteses personalizadas e sobre fabrico aditivo mostra que existe fundamento técnico para construir geometrias configuráveis com base em regras explícitas, parâmetros dimensionais e relações geométricas controladas. Estudos sobre próteses paramétricas para diferentes níveis de amputação de membros superiores, sobre a personalização de dedos protésicos por modelação paramétrica e sobre encaixes protésicos personalizados para próteses transradiais mostram que a personalização pode ser estruturada através de modelos explícitos e fluxos CAD/CAM ajustáveis (da Silveira Romero et al., 2025; Lim et al., 2018; Saldarriaga et al., 2024). O sistema aqui proposto parte desta premissa: a geometria é produzida por um modelo paramétrico explícito, definido em OpenSCAD e manipulável através de parâmetros cuja origem e efeito podem ser identificados.

É neste ponto que a IA assume uma função específica. Actua como mecanismo de mediação entre os dados de entrada e a exploração inicial do espaço paramétrico. O seu papel é apoiar a tradução de informação antropométrica e de critérios de fabrico em sugestões paramétricas compatíveis com o esquema, reduzindo a complexidade associada à definição manual de valores iniciais e à navegação em sistemas com múltiplas dependências internas. Esta posição aproxima-se de abordagens orientadas por dados, mantendo a necessidade de interpretação humana (Gu et al., 2024).

No processo de desenvolvimento, a IA funciona como uma ferramenta de apoio à decisão e à iteração: propõe pontos de partida, ajuda a comparar cenários, acelera os ciclos de teste e permanece articulada com a estrutura técnica do sistema.

Entre os antecedentes mais próximos desta lógica encontram-se trabalhos que combinam personalização anatômica, modelação paramétrica, fabrico aditivo e componentes inteligentes, como o estudo de Romero et al. (2025), bem como modelos de optimização estrutural orientados por dados anatómicos e restrições de adaptação, como o proposto por Gu et al. (2024).

Esta leitura é coerente com a arquitectura da plataforma descrita no capítulo anterior. O sistema separa a camada de interface, a lógica paramétrica, a renderização local em WebAssembly e a comunicação controlada com serviços externos de IA. Tal organização preserva uma ligação verificável entre a entrada inicial, a sugestão produzida pela IA e o resultado geométrico gerado pelo modelo. O sistema mantém a IA sob supervisão: sugere valores sem determinar a configuração, apoia a exploração sem validar o resultado e acelera tarefas sem substituir o julgamento técnico. Esta opção é importante, considerando que a supervisão clínica ou técnica permanece limitada em vários estudos que articulam modelação digital, CAD, IA, co-design apoiado ou impressão 3D (Romero et al., 2025; Elbreki et al., 2022; Idris et al., 2024). O valor da IA reside no apoio a um processo já estruturado por lógica paramétrica explícita, requisitos de fabrico e responsabilidade humana.

6.2 IA NA PARAMETRIZAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E APOIO À DECISÃO

No domínio da parametrização, a inteligência artificial torna-se mais relevante quando opera sobre uma estrutura geométrica previamente formalizada. Em sistemas como o aqui proposto, isso significa receber dados antropométricos e restrições de fabrico e convertê-los em sugestões iniciais para os parâmetros já definidos no modelo. A literatura sobre próteses paramétricas e personalização anatômica mostra que a configuração depende de relações explícitas entre medidas, proporções e componentes geométricos (Saldarriaga et al., 2024; da Silveira Romero et al., 2025). Neste enquadramento, a IA ajuda a propor valores dentro dos intervalos definidos e combinações iniciais sujeitas a verificação.

No plano da personalização, esta mediação é importante porque a adaptação de uma prótese exige o controlo independente de diferentes parâmetros anatómicos, funcionais e construtivos, ultrapassando a simples alteração proporcional da escala do modelo. A literatura indica que diferentes parâmetros podem ter de ser controlados de forma independente para respeitar as proporções anatómicas, o conforto, a mobilidade e os requisitos de montagem. O estudo de Lim et al. (2018), por exemplo, demonstra que o comprimento e a largura de um dedo protésico podem exigir ajustamentos independentes, uma vez que não evoluem necessariamente segundo uma relação linear e proporcional. Este resultado reforça a necessidade de parametrizações mais precisas do que simples operações de escala.

De forma convergente, Gu et al. (2024) mostram que abordagens orientadas por dados podem apoiar a adaptação estrutural e a qualidade do ajuste ao corpo, sugerindo que métodos inteligentes podem ajudar a antecipar relações entre geometria, desempenho e conforto. No sistema proposto, a IA funciona, assim, como uma camada de inferência preliminar sobre um espaço paramétrico já estruturado, orientando a exploração inicial das configurações.

A operacionalização desta lógica ocorre em dois objectos distintos. O primeiro é um vetor numérico de parâmetros geométricos, consumido diretamente pela interface e pelos modelos OpenSCAD. O segundo é um contexto semântico para a IA, que descreve a origem das medições, campos em falta, incerteza, valores

atípicos, tolerâncias, hardware seleccionado e notas sobre parâmetros derivados. Esta separação é importante porque impede confundir cálculo geométrico com raciocínio apoiado: os parâmetros numéricos alimentam o modelo; o contexto semântico ajuda a IA a explicar, ponderar ou sugerir ajustes, mas não substitui as regras determinísticas que geram a geometria.

No protótipo implementado, esta separação é materializada pela construção dinâmica do pedido enviado ao modelo de linguagem. O pedido inclui a descrição livre do utilizador, o esquema vivo do modelo seleccionado, os nomes exatos dos parâmetros, as legendas, os tipos, os limites e os valores correntes. Quando existe correspondência com um perfil populacional importado, inclui também as médias medidas desse grupo como referência explícita. Deste modo, a IA não infere valores num espaço aberto: opera dentro de uma gramática paramétrica previamente declarada, limitada pelo modelo ativo e sujeita a filtragem posterior pela aplicação.

A designação "modelo" é usada, nesta investigação, em dois sentidos técnicos distintos: o modelo de linguagem responsável pela sugestão paramétrica e o modelo CAD paramétrico ao qual essa sugestão é aplicada. Para evitar ambiguidade metodológica, a Tabela 6.1 explicita a configuração de IA efetivamente implementada no protótipo e a sua relação com os modelos paramétricos disponibilizados na plataforma.

Tabela 6.1 — Especificação técnica dos modelos de IA e do contrato de sugestão paramétrica

Elemento	Especificação no protótipo
Função da IA	Sugestão inicial de parâmetros antropométricos e geométricos a partir de descrições em linguagem natural; não gera autonomamente a geometria final nem valida clinicamente a prótese.
Endpoint de integração	POST /api/ai/suggest, através de chamada autenticada e limitada por frequência, com as chaves de API mantidas no servidor.
Fornecedor e modelo usados na validação	Anthropic, com o modelo claude-sonnet-4-6, definido como opção predefinida no backend do protótipo.
Modelo alternativo disponibilizado	OpenAI, com o modelo gpt-4, acessível através da mesma rota de sugestão paramétrica.
Seleção do fornecedor	A interface permite escolher entre Anthropic (Claude) e OpenAI (GPT-4); o pedido enviado ao servidor identifica o fornecedor através do campo provider.
Parâmetros da chamada avaliada	Máximo de 1024 tokens; o código não fixa a temperatura na chamada ao claude-sonnet-4-6, pelo que fica em vigor a configuração do fornecedor. O percurso OpenAI fixa temperatura de 0,7, mas não

Elemento	Especificação no protótipo
	integra a avaliação reportada.
Contrato de resposta	Objeto JSON simples no formato parâmetro-valor; chaves desconhecidas são rejeitadas ou ignoradas e apenas parâmetros pertencentes ao modelo ativo podem ser aplicados.
Enquadramento dos dados	O pedido inclui o esquema vivo do modelo, limites mínimos e máximos, valores correntes, legendas dos parâmetros e, quando disponível, médias de perfis antropométricos populacionais.
Modelos CAD registados na versão 14.67.0	Flexy Beast, Paraglider Hand, UnLimbited Phoenix e Cyborg Beast. A avaliação comparativa abrangeu os três primeiros.

O apoio à decisão emerge precisamente desta capacidade de transformar dados de entrada em cenários comparáveis. Em vez de produzir uma única configuração apresentada como “ótima”, a integração da IA revela maior utilidade quando ajuda a explicitar compromissos entre robustez, leveza, amplitude de ajuste, rapidez de fabrico, facilidade de montagem e adequação anatómica. Esta lógica está alinhada com exemplos recentes de integração entre digitalização, modelação paramétrica, fabrico aditivo e sistemas inteligentes, como o trabalho de Romero et al. (2025), ainda que aí a componente de IA esteja mais ligada ao controlo mioelétrico do que à sugestão paramétrica em ambiente web. A pertinência desse precedente reside menos na equivalência técnica directa e mais no facto de mostrar que a personalização digital e a camada inteligente podem coexistir no mesmo fluxo, desde que cada componente mantenha uma função claramente delimitada.

É por isso que, nesta investigação, a personalização apoiada por IA deve ser entendida como uma prática de human-in-the-loop. O sistema procura ampliar a capacidade de análise e de exploração do protesista, do designer ou do utilizador informado. A IA pode sugerir configurações iniciais, organizar alternativas, sinalizar dependências entre parâmetros e tornar mais claras certas consequências de projecto, a aceitação final, porém, continua dependente de verificação técnica e de julgamento contextual. Deste modo, a parametrização apoiada por IA não corresponde a uma automatização cega da personalização, mas a um mecanismo de apoio à decisão que atua sobre uma base geométrica explícita, documentada e tecnicamente verificável.

6.3 AVALIAÇÃO DAS SUGESTÕES PARAMÉTRICAS APOIADAS POR IA

A avaliação desta componente verifica a coerência das sugestões face ao esquema e aos intervalos de referência adoptados. O termo «antropométrica» descreve a origem dos campos e das referências; não significa que exista confirmação anatómica individual. Os resultados são apresentados no Capítulo 8, mantendo esta secção dedicada ao protocolo.

O protocolo executado em 28 e 29 de Junho de 2026 usou o fornecedor Anthropic e o modelo claude-sonnet-4-6. A chamada admitia 1024 tokens e não fixava a temperatura. O pedido incluía a descrição do caso, o identificador do modelo, nomes exactos dos parâmetros, tipos, limites, valores correntes, etiquetas

explicativas e, quando existia correspondência, uma referência populacional. O pedido exigia um objecto JSON com pares parâmetro-valor. A plataforma extraía o primeiro objecto JSON, ignorava chaves desconhecidas e aplicava apenas campos pertencentes ao modelo activo. Esta filtragem foi observada na amostra; a versão avaliada ainda não possuía validação integral por esquema no servidor.

Foram usados cinco perfis baseados em indicadores demográficos e três cenários de ausência unilateral com diferentes níveis de detalhe: medidas completas da mão contralateral, uma medida directa e descrição demográfica. Uma bateria complementar reuniu 15 cenários de entrada vaga, comparativa, multilingue ou sem medidas. Para examinar a lateralidade, foram ainda arquivadas 12 execuções antes da correcção, correspondentes a pedidos de mão esquerda e direita repetidos quatro vezes. Os cenários simulam entradas possíveis e não constituem avaliação centrada no utilizador, porque nenhuma pessoa participou no estudo.

Os critérios foram: JSON interpretável; chaves pertencentes ao esquema; valores dentro dos intervalos; preservação das medidas fornecidas; ordem relativa dos dedos definida no protocolo; resposta diferenciada a idade e sexo quando a base continha referência compatível; e propagação dos valores para a geometria. Países ausentes da base, como Brasil, Japão e Alemanha, funcionaram como testes de resposta a cobertura incompleta. Nesses casos, o país não sustenta uma correspondência nacional: o mecanismo selecciona o perfil disponível com melhor pontuação noutros atributos.

A cadeia contém operações determinísticas e uma operação gerada por modelo de linguagem. A distinção é sintetizada na Tabela 6.2.

Tabela 6.2 — Distribuição de tarefas entre regras, IA e supervisão humana

Tarefa	Mecanismo	Resultado
Identificar sexo e idade explícitos	Analizador de texto e, quando faltam campos, extracção opcional por claude-haiku-4-5-20251001 a temperatura 0	Atributos para procurar uma referência populacional
Escolher o perfil disponível mais próximo	Pontuação por sexo, grupo etário, idade e país, com critérios de desempate de qualidade	Referência quantitativa; não corresponde a diagnóstico nem a correspondência nacional garantida
Sugerir campos em falta	claude-sonnet-4-6	Ponto de partida sujeito a alterações entre execuções
Respeitar tipos e limites	Configuração do modelo e filtragem da aplicação	Valores aplicáveis aos controlos conhecidos
Definir lateralidade	Controlo da interface com o papel laterality	Escolha fixa excluída das sugestões
Gerar a geometria	Regras OpenSCAD executadas em WebAssembly	Forma determinística para um mesmo conjunto de parâmetros e versão de código

Tarefa	Mecanismo	Resultado
Aceitar, corrigir ou rejeitar a configuração	Designer ou técnico responsável	Decisão humana antes da exportação e de qualquer utilização posterior

O protocolo não mede exactidão clínica da IA, porque não existe uma referência individual para cada cenário. Também não compara fornecedores, modelos de linguagem, temperaturas ou estratégias de pedido. A interpretação limita-se ao comportamento observado no modelo, nas versões e nos casos documentados.

6.4 AJUSTE, VERIFICAÇÃO E LIMITAÇÕES ÉTICAS E TÉCNICAS

A introdução de IA num sistema como o proposto exige distinguir claramente entre sugestão paramétrica, ajuste efetivo e validação final. Uma recomendação produzida por um modelo de IA pode ser útil como ponto de partida, mas não equivale a uma prova de adequação funcional, de conforto ergonómico ou de segurança estrutural. O ajuste real de uma prótese depende sempre de confirmação em contexto técnico e, idealmente, de iterações de teste, observação e refinamento. Por essa razão, os valores sugeridos pela IA devem ser entendidos como hipóteses operativas sujeitas a validação posterior, e não como prescrições definitivas.

Do ponto de vista técnico, subsistem limitações significativas. A IA pode produzir sugestões aparentemente coerentes, mas inadequadas para casos extremos, perfis antropométricos pouco representados ou combinações paramétricas fora da distribuição esperada. Pode também introduzir inconsistências difíceis de detectar se a sua saída não for confrontada com restrições geométricas, limites de fabrico e critérios funcionais explícitos. Assim, a integração responsável da IA depende de salvaguardas incorporadas no sistema, incluindo limites paramétricos, verificação de intervalos, controlo de coerência entre módulos, comparação entre alternativas e supervisão humana capaz de identificar sugestões tecnicamente infundadas ou insuficientemente justificadas. Esta necessidade de enquadramento crítico é coerente com a literatura sobre responsabilidade no design apoiado por IA, que sublinha a importância de compreender os dados considerados, os critérios aplicados e os limites das sugestões produzidas pelo modelo (Panchal et al., 2019; Yüksel et al., 2023).

A Figura 6.1 sintetiza esta tensão entre desafios de explicabilidade e princípios de IA responsável. No contexto desta investigação, a figura mostra que a responsabilidade depende do desempenho preditivo e de condições como transparência, possibilidade de examinar as decisões, privacidade, justiça e prestação de contas. Estes princípios reforçam a opção do sistema por uma IA de apoio, limitada por regras e sujeita a revisão humana (Barredo Arrieta et al., 2020).

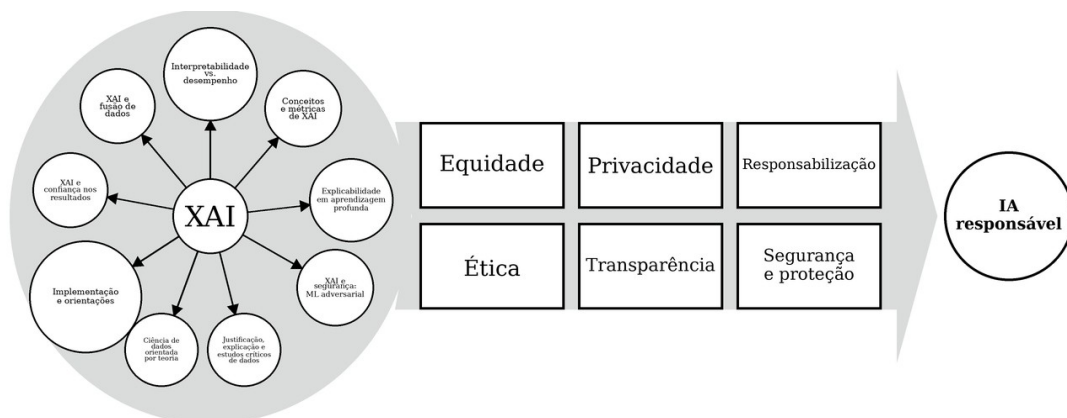


Figura 6.1 — Relação entre desafios de explicabilidade e princípios de IA responsável.

Adaptação de Barredo Arrieta, A., Díaz-Rodríguez, N., Del Ser, J., Bennetot, A., Tabik, S., Barbado, A., García, S., Gil-López, S., Molina, D., Benjamins, R., Chatila, R., & Herrera, F. (2020). Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. *Information Fusion*, 58, 82-115. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012> (<https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012>)

As limitações éticas assumem particular relevância num domínio associado a dispositivos personalizados e potencialmente sensíveis, exigindo atenção à recolha excessiva de dados, à exposição desnecessária de informação pessoal e ao risco de aceitar sugestões algorítmicas como se fossem neutras ou automaticamente válidas.

Mesmo quando a plataforma utiliza apenas dados antropométricos não clínicos ou cenários experimentais, a sua arquitetura deve limitar a recolha ao necessário, controlar quem pode aceder às configurações e explicitar que a IA atua como apoio à configuração, e não como autoridade técnica ou clínica.

A plataforma deve comunicar de forma clara que a IA desempenha uma função de apoio à decisão no processo de configuração, sem assumir autoridade clínica ou validar autonomamente a adequação da prótese. Esta delimitação é essencial para evitar deslocamentos indevidos de responsabilidade e para definir corretamente o âmbito da ferramenta

Por fim, subsiste uma limitação metodológica mais ampla: a qualidade da IA depende da qualidade das estruturas em que se insere. Sem modelos paramétricos bem definidos, sem critérios de validação claros e sem dados suficientemente representativos, a IA tende a amplificar incerteza em vez de a reduzir. Neste sentido, a sua integração só se torna relevante quando articulada com uma base projectual explícita, com procedimentos de verificação e com uma compreensão crítica das suas margens de erro. A principal contribuição da IA para o sistema proposto não reside, portanto, numa promessa de automatização total, mas na possibilidade de reforçar processos de personalização e decisão, desde que permaneça enquadrada por regras, validação e responsabilidade humanas.

CAPÍTULO 7 — PRINCÍPIOS DE INTERFACE E DECISÕES DE INTERACÇÃO

7.1 ESTRATÉGIA DE INTERACÇÃO E DECISÕES DE UI/UX

O ponto de partida desta secção é a organização, através da interface, de um sistema de modelação paramétrica baseado em código. A aplicação apresenta uma sequência de acções: seleccionar um modelo, introduzir dados antropométricos, ajustar parâmetros, observar a geometria, guardar a configuração e exportar ficheiros. Esta sequência descreve uma decisão projectual implementada; a sua facilidade de uso não foi avaliada com participantes.

Esta opção traduz uma decisão deliberada de desenho da interface: a plataforma não procura ocultar a natureza técnica do sistema, mas reorganizá-la em operações compreensíveis, sequenciais e verificáveis. Esta abordagem aproxima-se de modelos que valorizam a orientação inicial do utilizador no contacto com a plataforma, a navegação guiada e a redução da carga interpretativa em processos de personalização protésica (Colombo et al., 2015; Peixoto et al., 2025).

Do ponto de vista estrutural, a interface adopta uma composição modular orientada por tarefa. A selecção do modelo funciona como ponto de entrada; os parâmetros surgem como elementos editáveis; a visualização tridimensional apresenta o resultado da geração; e as acções de guardar, recuperar e exportar prolongam o processo. A organização foi concebida para manter uma relação clara entre intenção, acção e consequência formal. A redução de carga cognitiva e a adequação desta sequência a diferentes perfis permanecem hipóteses de design que exigem avaliação com utilizadores (Peixoto et al., 2025; Quintero et al., 2018).

Uma decisão relevante reside na tradução da lógica paramétrica para linguagem operacional. Cada controlo dá acesso a uma relação geométrica definida no modelo. A plataforma expõe uma parte delimitada do espaço de configuração e reserva parâmetros críticos a regras ou perfis com maior responsabilidade. Esta contenção reduz a possibilidade de combinações fora dos limites declarados, embora o seu efeito na compreensão e na confiança ainda não tenha sido medido.

A articulação entre edição paramétrica e pré-visualização constitui outra decisão relevante, pois a renderização local através de WebAssembly permite que a resposta visual resulte directamente da geometria gerada pelo sistema, evitando o recurso a imagens estáticas ou a representações simplificadas desligadas do modelo.

A pré-visualização resulta da geometria gerada e permite comparar o valor introduzido com a forma apresentada. O Web Worker separa o cálculo da tarefa principal da interface. Esta decisão técnica evita o bloqueio directo durante a execução, mas o tempo percebido, a compreensão dos estados e a qualidade da interacção não foram medidos (Abbas Alili et al., 2023; Colombo et al., 2015; Peixoto et al., 2025).

A interface privilegia a clareza operacional em relação à exuberância formal, em coerência com o contexto do projecto: trata-se de uma ferramenta de configuração protésica, e não de um configurador lúdico ou promocional.

As decisões de desenho da interface procuram, assim, favorecer a clareza operacional, a consistência entre controlos, a previsibilidade das acções e o registo das alterações, mediando a passagem entre os dados do utilizador, as regras paramétricas, a assistência algorítmica e o resultado tridimensional. Esta clareza é

particularmente relevante em sistemas protésicos inteligentes, nos quais importa equilibrar autonomia do utilizador, supervisão técnica e diferenciação de permissões entre utilizadores e profissionais (Bai et al., 2024; Quintero et al., 2018).

Deste modo, a estratégia de interacção constitui uma especificação projectual para expor parâmetros, resultados e estados guardados. A avaliação da clareza desta especificação requer observação de uso futura.

A interface medeia o conhecimento técnico, os dados de entrada e a decisão de projecto. A sua organização preserva continuidade com a lógica paramétrica e com o papel de apoio atribuído à IA.

7.2 PAPÉIS PREVISTOS E DISTRIBUIÇÃO DE DECISÕES

A plataforma prevê formas distintas de participação, porque designers, técnicos, clínicos e utilizadores finais não intervêm sobre os mesmos parâmetros nem assumem o mesmo grau de responsabilidade. Estes papéis resultam do enquadramento teórico e da arquitectura de permissões; não foram confirmados por observação de práticas profissionais ou por testes com utilizadores.

Em sistemas de personalização protésica, diferentes domínios de configuração exigem distribuições distintas de autoridade. Quando estão em causa parâmetros ligados à geometria do encaixe, à biomecânica, à tolerância dos tecidos ou à viabilidade de fabrico, o papel do profissional tende a ser dominante, pois envolve interpretação especializada, validação contextual e responsabilidade técnica. Em contrapartida, quando a configuração incide sobre preferências de controlo, clareza do sistema ou aspectos estéticos que o utilizador consegue avaliar diretamente, a sua participação torna-se mais substantiva.

O contraste entre estes domínios é central para compreender a diferenciação entre perfis de uso, ainda que a literatura directa sobre plataformas paramétricas para o membro superior permaneça escassa e muitas conclusões tenham de ser complementadas por evidência transferível de contextos adjacentes (Cordella et al., 2016; Saldarriaga et al., 2024).

Para o designer, o técnico de próteses e ortóteses ou o clínico, a plataforma foi concebida como ambiente de configuração, teste, comparação e supervisão. A literatura indica que estes profissionais valorizam relações compreensíveis entre parâmetros e consequências geométricas, continuidade com o raciocínio técnico e preservação do conhecimento prático. A adequação da implementação a essas expectativas permanece por testar (Colombo et al., 2015; Quintero et al., 2018; Bai et al., 2024).

Para o utilizador final, foram previstos consulta da configuração, visualização do modelo e acompanhamento do processo. O estudo não permite afirmar que estas funções aumentem a compreensão, a confiança ou a participação.

A aceitação de uma prótese relaciona-se com o desempenho funcional, a percepção de adequação, a participação e o controlo sobre o resultado. Os estudos analisados indicam que a comunicação do funcionamento pode influenciar a experiência de utilização.

Na plataforma, os limites dos parâmetros e os efeitos geométricos são apresentados como suporte à decisão. O efeito desta apresentação na facilidade de utilização e na confiança subjectiva permanece por avaliar.

As plataformas de personalização estética e os sistemas com visualização explícita do espaço de decisão sugerem que a participação ativa do utilizador aumenta quando as opções editáveis são claras, compreensíveis e associadas a consequências de baixo risco. (Peixoto et al., 2025).

A diferença entre estes níveis de participação torna-se mais clara quando se consideram três domínios de personalização que os estudos analisados abordam de forma diferenciada. O primeiro domínio diz respeito à geometria do encaixe e ao ajustamento biomecânico, predominando aqui uma lógica clínica. Neste caso, a pessoa pode fornecer feedback sobre conforto, tolerância ou preferência, mas a decisão permanece centrada no interveniente com competência técnica e responsabilidade pela validação. O segundo domínio corresponde à personalização do controlo e à afinação de sistemas interativos, nos quais a autoridade do utilizador tende a aumentar, uma vez que a sensação de controlo, a carga cognitiva e a adequação do comportamento do sistema em uso dependem da sua avaliação directa. O terceiro domínio relaciona-se com a personalização estética e identitária, em que a autonomia do utilizador pode ser mais ampla, dado que o risco clínico e biomecânico é menor e o critério de adequação depende mais directamente da sua percepção.

A coexistência destes perfis e domínios justifica a adoção de permissões diferenciadas e de uma experiência graduada por papéis. O sistema não distribui o mesmo poder de edição a todos os agentes, pois isso reduziria a segurança, a coerência e a legibilidade do processo. Em vez disso, estrutura diferentes níveis de acesso, permitindo que determinadas ações sejam reservadas a perfis técnicos, enquanto outras se mantêm acessíveis ao utilizador que acompanha a sua configuração. Esta diferenciação não deve ser entendida como uma limitação arbitrária, mas como uma decisão de desenho que procura equilibrar autonomia, segurança e responsabilidade. Os estudos recentes sobre próteses inteligentes e interfaces configuráveis reforçam esta leitura, ao defenderem modelos de controlo nos quais os parâmetros críticos permanecem sob supervisão profissional, enquanto ajustes mais delimitados podem ser acessíveis ao utilizador final (Bai et al., 2024; Quintero et al., 2018).

A Figura 7.1 evidencia a importância de analisar a utilização concreta do dispositivo, para além da sua configuração digital. A avaliação com utilizadores permite identificar problemas relacionados com o ajuste ao corpo, o modo de ativação, o conforto e a adequação funcional, aspectos que dificilmente são detectados de forma suficiente apenas através do modelo digital. Para esta investigação, a imagem constitui um ponto de referência metodológico: embora a plataforma possa tornar o processo mais claro e configurável, a validação futura continua a depender da observação do uso em contexto real (Silva et al., 2018).



Figura 7.1 — Exemplo publicado de teste de uma prótese impressa em 3D com um utilizador; esta actividade não integrou a avaliação da presente dissertação.

Fonte original: Silva, L. A. da, Medola, F. O., Rodrigues, O. V., Rodrigues, A. C. T., & Sandnes, F. E. (2018). Interdisciplinary-based development of user-friendly customized 3D printed upper limb prosthesis. Comunicação em conferência.

A plataforma propõe uma colaboração assimétrica: o perfil técnico possui maior capacidade de configuração e o utilizador final dispõe de consulta e acompanhamento. Esta distribuição é coerente com abordagens human-in-the-loop e com a necessidade de supervisão, mas os seus efeitos sobre rapidez, compreensão e qualidade da decisão não foram avaliados (Alili et al., 2023; Oldfrey et al., 2024).

7.3 MEDIAÇÃO DO PROCESSO DE DESIGN E REFLEXÃO CRÍTICA

A interface permite editar parâmetros e medeia o processo de design. Introduce uma camada entre o modelo algorítmico, a decisão técnica e a interpretação do utilizador, organizando uma sequência de leitura de dados, proposta de configuração, avaliação visual, revisão e eventual exportação para fabrico. Esta sequência corresponde ao processo implementado; os seus efeitos no trabalho de diferentes intervenientes são inferências projectuais apoiadas pela literatura.

Neste sentido, a interface assume uma dimensão simultaneamente operacional e epistemológica, ao influenciar a forma como o problema é compreendido, como as alternativas são exploradas e como as decisões são justificadas.

Ao disponibilizar parâmetros editáveis, visualização tridimensional, sugestões apoiadas por IA e gestão de versões, a plataforma contribui para estruturar o trabalho de projecto e documentar a evolução das decisões. Essa estrutura estabelece igualmente limites: o utilizador explora o espaço de soluções permitido pelo modelo e pela interface. Os estudos analisados sugerem que as plataformas relevantes neste domínio recorrem a mecanismos concretos de mediação, como controlo diferenciado de permissões, exposição selectiva de variáveis, pontos de partida algorítmicos, visualização orientada pelo problema e supervisão integrada na interface.

A articulação entre maior capacidade de intervenção e delimitação do campo de decisão torna-se particularmente visível em sistemas que distinguem, de forma deliberada, os parâmetros acessíveis ao utilizador daqueles que permanecem reservados a profissionais ou a rotinas automáticas de ajuste. (Bai et al., 2024; Alili et al., 2023).

Uma implicação desta leitura é que a plataforma medeia tanto quem utiliza o sistema como aquilo que se torna visível no processo. A visualização tridimensional, os indicadores de estado, os limites paramétricos e os mecanismos de feedback participam ativamente na forma como o problema é compreendido, interpretado e avaliado.

Ao tornar certas relações mais visíveis e outras menos acessíveis, a interface produz uma forma específica de legibilidade do processo de personalização. O mesmo se aplica aos mecanismos de comparação e revisão: quando o sistema oferece variantes, propõe valores iniciais ou assinala incongruências, está a intervir na forma como as alternativas são construídas antes mesmo de serem escolhidas.

Nesta perspectiva, a mediação digital participa na forma como as decisões de projecto são preparadas, avaliadas e justificadas. Esta observação conduz a uma reflexão crítica sobre o papel da plataforma no próprio processo de design.

Uma interface bem desenhada pode criar uma sensação de evidência ou neutralidade em decisões condicionadas por critérios de projecto, pressupostos técnicos e escolhas interpretativas. A apresentação de um parâmetro como controlo disponível, ou de uma sugestão com aparência de coerência técnica, não significa que a solução esteja validada ou represente a melhor opção em todos os contextos. A mediação da interface deve ser avaliada pela eficiência e pela forma como torna visíveis dependências, incertezas e responsabilidades. A literatura analisada reforça esta cautela: resultados positivos de usabilidade ou rapidez de afinação mantêm a necessidade de definir quem decide, quais parâmetros podem ser alterados, quais decisões ficam pré-estruturadas pelo sistema e em que condições essas alterações são seguras ou adequadas (Peixoto et al., 2025; Quintero et al., 2018; Bai et al., 2024).

A mediação do processo de design preserva a responsabilidade pelas decisões de projecto e a necessidade de validação técnica, reorganizando ambas num ambiente digital mais controlado e explícito.

A plataforma foi concebida para distribuir a capacidade de intervenção de forma diferenciada: concentra certas decisões em perfis técnicos, abre outras ao acompanhamento do utilizador e enquadra outras através de sugestões produzidas por IA.

É precisamente nessa articulação entre interface, lógica paramétrica, sugestão apoiada, visibilidade seletiva e responsabilidade crítica que reside o valor metodológico deste sistema enquanto contributo para o design de próteses personalizadas.

CAPÍTULO 8 — AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO

8.1 ESTRATÉGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação foi organizada em quatro níveis: funcionamento dos componentes da plataforma; coerência das sugestões de IA; propagação dos parâmetros para a geometria; e passagem dos ficheiros para preparação e impressão. Os critérios foram definidos na Secção 3.5. Os resultados demonstram condições técnicas específicas e não equivalem a avaliação clínica, funcional ou de experiência de utilização.

8.1.1 VERIFICAÇÃO TÉCNICA DA PLATAFORMA

A versão 14.67.0 da branch staging, commit d5b6f0d5a41950663d54c70b9ab9bad7f8c2d53b, foi inspeccionada no fecho do estudo. A Tabela 8.1 distingue resultados executados nesta verificação, dados observados na base local e ensaios arquivados de versões anteriores.

Tabela 8.1 — Evidência técnica do funcionamento da plataforma

Componente	Procedimento	Resultado	Limite da evidência
Correspondência de perfis	npm run test:unit, 13 de Julho de 2026	10 testes aprovados, 0 falhas	Abrange análise de sexo, idade, grupos etários e selecção de perfil; não cobre a interface completa
Catálogo de modelos	Inspecção de models/models-config.json	Quatro modelos registados e respectivos parâmetros carregáveis por configuração	Confirma a declaração dos modelos; três integram a comparação dimensional
Base antropométrica da aplicação	Consulta de data/app.db	100 perfis: 97 importados em lote, dois por CSV e um manual	O número de perfis da aplicação difere do número de linhas dos CSV de origem, porque cada perfil agrega várias medições
Persistência	Consulta da estrutura e dos registos de teste	Tabelas de utilizadores, configurações, perfis e atribuições técnicas presentes; uma configuração guardada no estado consultado	Confirma dados existentes, sem ensaio de carga ou acessos simultâneos
Renderização e	Relatórios e testes	Geração em	A bateria

Componente	Procedimento	Resultado	Limite da evidência
exportação	end-to-end arquivados no registo de alterações	WebAssembly, conversão para GLB e exportação STL/3MF documentadas nas versões correspondentes	Playwright da versão 14.67.0 não foi repetida no ambiente desta revisão
Serviço de IA	Inspecção das rotas e dos serviços	Chamada autenticada, escolha de fornecedor, limite de frequência, referência populacional e resposta textual implementados	A disponibilidade depende de chaves e serviços externos

Estes resultados confirmam a existência e a integração dos componentes examinados. Não demonstram desempenho sob carga, segurança integral, compatibilidade com todos os navegadores ou uso autónomo por pessoas sem formação técnica.

8.1.2 PREPARAÇÃO PARA IMPRESSÃO E PROTÓTIPOS FÍSICOS

A evidência de fabrico inclui 116 ficheiros 3MF gerados para três modelos e quatro idades, três projectos com parâmetros de preparação e fotografias de peças físicas. Os 116 ficheiros representam exportações digitais, distribuídas por placas combinadas e peças individuais; esse total não corresponde a 116 impressões físicas. Os três perfis encontram-se em docs/print-validation/bambulab1_flexy_beast_teen_15_print.3mf, docs/print-validation/bambulab1_unlimbed_phoenix_hand_teen_15_print_project.3mf e docs/print-validation/prusa_mini_paraglider_15_teen_print_profile.3mf. Cada projecto identifica um caso adolescente de 15 anos e a impressora usada. Os parâmetros comparáveis foram mantidos nas restantes impressões, segundo o registo do projecto.

Tabela 8.2 — Projectos de preparação para impressão arquivados

Modelo e cenário	Impressora e programa	Parâmetros principais	Evidência observada
Flexy Beast, 15 anos	Bambu Lab A1, Bambu Studio 1.10.02.76	Camada 0,24 mm; duas paredes; enchimento 15% em grelha; suporte em árvore; aba 5 mm; objectos atribuídos ao extrusor PLA	Dez segmentos digitais importados; programa regista 0 arestas corrigidas e 0 faces degeneradas
UnLimbited Phoenix, 15 anos	Bambu Lab A1, Bambu Studio	Mesmos parâmetros do projecto Flexy Beast;	Oito conjuntos de peças importados;

Modelo e cenário	Impressora e programa	Parâmetros principais	Evidência observada
	1.10.02.76	objectos atribuídos ao extrusor PLA	programa regista 0 arestas corrigidas e 0 faces degeneradas
Paraglider Hand, 15 anos	Prusa MINI, PrusaSlicer 2.8.1	Camada 0,20 mm; duas paredes; enchimento 15% em grelha; PLA; bico 0,4 mm; mesa 60 °C; suporte e aba desactivados	Projecto 3MF com configuração da impressora, do filamento e da placa

Os dois projectos Bambu contêm três materiais disponíveis na configuração, mas as peças presentes estão atribuídas ao extrusor 1, identificado como PLA. A documentação disponível não permite uma comparação controlada entre PLA e PETG. Por isso, não se retiram conclusões sobre resistência, fragilidade ou durabilidade relativas dos materiais.

Uma inspecção complementar com trimesh, arquivada com os cenários de 29 de Junho de 2026, examinou peças da configuração infantil. Os critérios foram fecho da superfície, carácter múltiplo da geometria, número de corpos e faces de área nula. A Tabela 8.3 mostra que a preparação aceite pelo programa de fatiamento não implica que a malha de origem seja um sólido fechado sem defeitos.

Tabela 8.3 — Inspeção computacional de malhas na configuração infantil

Modelo e peça	Fecho	Múltiplos corpos	N.º de corpos	Faces nulas	Interpretação
Flexy Beast, palma	Sim	Sim	1	0	Malha fechada segundo os critérios usados
Flexy Beast, dedo médio	Sim	Sim	3	0	Três corpos fechados, coerentes com a construção segmentada
Paraglider Hand, palma	Sim	Sim	1	142	O fatiamento pode aceitar a peça, mas a malha contém faces degeneradas
Paraglider Hand, dedo médio	Não	Sim	4	26	Requer inspecção ou reparação antes de uma conclusão sobre qualidade geométrica
UnLimbited Phoenix, palma	Não	Não	5	6	A malha original contém descontinuidades que o redimensionamento não

Modelo e peça	Fecho	Múltiplos corpos	N.º de corpos	Faces nulas	Interpretação
					elimina

Os projectos Bambu registam zero arestas corrigidas e zero faces degeneradas nas peças importadas. Esse indicador pertence ao diagnóstico do Bambu Studio para os ficheiros concretos do projecto e usa um procedimento distinto do trimesh. A diferença entre os registos deve ser mantida, pois nenhum dos resultados autoriza a concluir que todas as variantes de cada modelo possuem a mesma qualidade de malha.

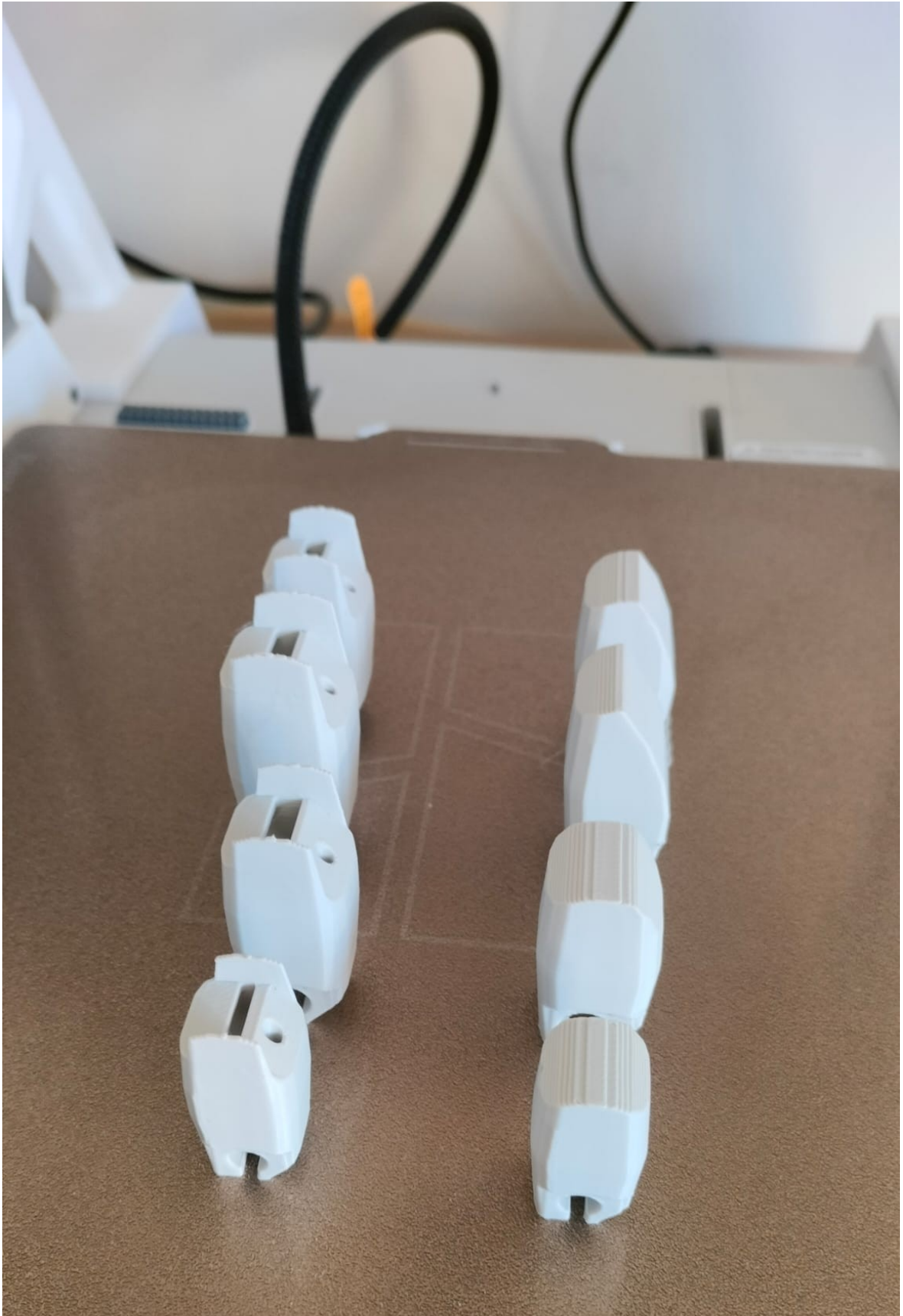


Figura 8.1 — Segmentos do Flexy Beast produzidos e assentes na plataforma da Bambu Lab A1.

Fonte: produção própria.



Figura 8.2 — Série física de segmentos Flexy Beast identificados pelas idades simuladas de 8, 15, 28 e 70 anos. A imagem permite comparar escala e conclusão das peças, sem constituir medição dimensional ou ensaio mecânico.

Fonte: produção própria.



Figura 8.3 — Série física de segmentos Paraglider Hand identificados pelas idades simuladas de 8, 15, 28 e 70 anos. A imagem documenta a transição para peças físicas e não demonstra ajuste anatómico.

Fonte: produção própria.

A Figura 8.4 apresenta um precedente de avaliação funcional baseado em tarefas quotidianas. No presente trabalho, funciona como enquadramento de uma etapa futura posterior à verificação técnica e material (Romero et al., 2025).



Figura 8.4 — Tarefas funcionais usadas em avaliação de prótese personalizada de membro superior.

Fonte original: Romero, E., Garcia, J. G., Parra, M., Caballa, S., Saldarriaga, A. M., Luque, E. F., Rodriguez, D. J., Abarca, V. E., & Elias, D. A. (2025). An affordable AI-driven and 3D-printed personalized myoelectric prosthesis: Design, development, and assessment. IEEE Access, 13. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3596475>

8.2 AVALIAÇÃO DA COERÊNCIA DAS SUGESTÕES DE IA

O primeiro conjunto experimental incidiu sobre cinco perfis simulados, construídos a partir de idade, sexo, altura, peso, país, comprimento do braço e constituição física. Como estes perfis não incluíam medições directas da mão, a avaliação verificou a conformidade das respostas com o esquema, os intervalos e as relações dimensionais internas definidas. O ensaio examina o fluxo perante informação incompleta; não permite concluir que as dimensões correspondam à mão de uma pessoa concreta ou que a plataforma seja fácil de usar por pessoas sem formação técnica.

Nas cinco execuções arquivadas, a IA produziu JSON válido, usou parâmetros existentes, respeitou os limites declarados do modelo e manteve a ordenação definida entre os comprimentos dos dedos. Brasil, Japão e Alemanha não estão representados na base local. Nesses três casos, o país indicado não podia sustentar uma correspondência populacional directa; a selecção do perfil de referência dependeu dos restantes atributos e das regras de desempate. Este limite impede interpretar a indicação do país como adaptação antropométrica à população nacional mencionada.

Tabela 8.4 — Entradas utilizadas nos cenários de avaliação da IA

Conjunto experimental	Tipo de perfil criado	Descrição usada como entrada	Finalidade da verificação
Ensaio 1 — indicadores populacionais indiretos	Adulto masculino com dados demográficos e regionais	man, 28 years old, 82 kg, 180 cm height, Brazil, arm length 70 cm	Testar a inferência paramétrica sem medições directas da mão
Ensaio 1 — indicadores populacionais indiretos	Criança do sexo feminino, com estrutura corporal pequena	girl, 10 years old, 32 kg, 138 cm height, Japan, small frame	Examinar a redução das dimensões e dos componentes mecânicos perante uma idade inferior
Ensaio 1 — indicadores populacionais indiretos	Mulher idosa com dados demográficos e regionais	woman, 65 years old, 68 kg, 160 cm height, Nigeria, arm length 62 cm	Comparar os parâmetros com os limites do modelo num perfil adulto feminino e sénior
Ensaio 1 — indicadores populacionais indiretos	Adulto masculino com indicação qualitativa de mãos largas	man, 50 years old, 95 kg, 175 cm height, Germany, broad hands, arm length 66 cm	Verificar a resposta do sistema a uma característica anatómica descrita qualitativamente
Ensaio 1 — indicadores populacionais indiretos	Adolescente masculino alto e magro	teenage boy, 15 years old, 60 kg, 168 cm height, India, slim build, arm length 67 cm	Testar a fronteira entre perfil pediátrico e dimensões próximas de adulto
Ensaio 2 — amputação unilateral	Entrada completa com medições da mão intacta	Medições completas da mão esquerda intacta: palma 84 mm; indicador 72 mm; médio 78 mm; anelar 75 mm; mínimo 58 mm; polegar 64 mm; prótese necessária para a mão direita	Confirmar a preservação dos valores fornecidos e a geração contralateral
Ensaio 2 — amputação unilateral	Entrada parcial com dados demográficos e uma medição directa	Homem, 40 anos; mão direita intacta; largura da palma 90	Confirmar a manutenção da medida fornecida e a estimativa

Conjunto experimental	Tipo de perfil criado	Descrição usada como entrada	Finalidade da verificação
		mm; prótese necessária para a mão esquerda	proporcional dos campos em falta
Ensaio 2 — amputação unilateral	Entrada apenas demográfica	Mulher, 30 anos, asiática oriental, 158 cm; prótese necessária para a mão direita	Verificar a adaptação do sistema quando não existem medições directas da mão

Fonte: elaboração própria a partir dos prompts registados em docs/ai_anthropometric_validation.md, dos metadados em docs/flexy-beast-ai-sim/run-metadata.json, docs/paraglider-ai-sim/run-metadata.json e docs/phoenix-ai-sim/run-metadata.json, e dos cenários em docs/ucd-ai-sim/. A coluna apresenta a descrição do caso simulado enviada no pedido; o pedido completo incluía o esquema actual do modelo, os intervalos permitidos e a instrução de devolver apenas JSON válido.

A leitura dos registos mostra respostas distintas consoante o detalhe da entrada. Nos perfis adultos, os valores sugeridos permaneceram dentro dos intervalos usados pelo sistema. No perfil infantil, os comprimentos e os parâmetros das articulações flexíveis foram reduzidos. Este comportamento corresponde às instruções presentes nas legendas do esquema; não constitui demonstração de ajuste anatómico. No perfil adolescente, uma regra preliminar assinalou a palma como excessiva. A comparação posterior com o intervalo de referência usado no ensaio mostrou que o limite do teste era demasiado rígido. A regra foi corrigida, mas a ausência de uma medição individual impede classificar a sugestão como exacta.

O segundo conjunto experimental avaliou três cenários de ausência unilateral com graus distintos de informação. No caso com medições completas da mão intacta, os valores fornecidos foram mantidos na resposta arquivada. No caso parcial, a largura da palma declarada foi mantida e os restantes comprimentos foram preenchidos. No caso demográfico, a resposta incluiu o conjunto de parâmetros requerido. Estes resultados descrevem as respostas observadas e não demonstram a correcção anatómica dos valores estimados.

A lateralidade foi examinada num ensaio separado com 12 pedidos repetidos. Onze pedidos produziram resposta interpretável e um terminou por falha de análise. Nos sete pedidos de mão esquerda com resposta, o campo mirrored indicou mão direita; os quatro pedidos de mão direita foram devolvidos como mão direita. A versão 14.19.0 retirou a lateralidade do conjunto de parâmetros sugeridos e atribuiu-a ao controlo da interface. Após a alteração, nove execuções em nove omitiram o campo de lateralidade, incluindo um cenário em que o texto entrava em conflito com a escolha da interface.

Tabela 8.5 — Síntese da avaliação das sugestões de IA

Eixo avaliado	Resultado observado	Interpretação
Conformidade com o esquema	Respostas interpretáveis, campos previstos e valores dentro dos limites definidos	O esquema de parâmetros reduziu a ocorrência de sugestões inválidas
Relações dimensionais internas	Dedo médio mais longo, dedo mínimo mais curto e	As relações definidas no protocolo foram respeitadas; o

Eixo avaliado	Resultado observado	Interpretação
	polegar inferior ao dedo médio nos casos arquivados	resultado não equivale a adequação anatômica individual
Entradas completas	Medições fornecidas mantidas sem alteração	A IA preservou os valores diretamente declarados pelo utilizador
Entradas parciais	Campos em falta estimados a partir da medida fornecida	O sistema combinou dados explícitos com referências populacionais
Entradas apenas demográficas	Conjunto completo de parâmetros dentro dos intervalos	O fluxo gerou um ponto de partida que requer confirmação por medição ou por um profissional competente
Lateralidade antes da correcção	0/7 respostas correctas para pedidos de mão esquerda; 4/4 para mão direita; uma falha de análise	A IA não oferecia comportamento aceitável neste parâmetro
Lateralidade após a correcção	Campo omitido em 9/9 execuções	A escolha passou a ser determinística e independente da resposta da IA

A bateria complementar reuniu 15 cenários com descrições vagas, comparativas, multilingues, sem medidas ou com valores fora dos limites. Os ficheiros preservam as entradas e as respostas, mas o estudo não reuniu extracções suficientes para estimar estatisticamente a estabilidade do modelo de linguagem. Em algumas execuções, parâmetros de hardware foram incluídos; noutras, permaneceram nos valores correntes. Assim, a conclusão limita-se à conformidade dos casos registados e ao valor das salvaguardas determinísticas. Entradas equivalentes podem originar números ou conjuntos de campos diferentes, pelo que cada sugestão exige revisão antes de ser aplicada.

8.3 VERIFICAÇÃO GEOMÉTRICA ENTRE MODELOS

A verificação geométrica testou se os valores sugeridos chegavam à malha exportada em três modelos activos da plataforma: Flexy Beast, Paraglider Hand e UnLimbited Phoenix. Para cada modelo foram comparados um valor de referência por omissão e três perfis simulados: criança, mulher adulta e homem adulto. As execuções arquivadas devolveram valores dentro dos intervalos declarados. O ensaio compara a resposta dimensional das geometrias; não avalia ajuste ao corpo, conforto, função ou segurança.

Tabela 8.6 — Modelos e mecanismos de escala avaliados

Modelo	Entradas antropométricas principais	Mecanismo de escala	Implicação observada
Flexy Beast	Largura da palma e comprimentos dos cinco dedos	Escalas independentes para palma e dedos	Aceitou os valores inferiores usados no ensaio
Paraglider Hand	Palma e dedos, com parâmetros adicionais de contexto	Escala geral da palma e ajustes por dedo	Respondeu aos três perfis após a correcção da escala da palma
UnLimbited Phoenix	Largura da palma	Escala uniforme limitada por valor mínimo	Impediu reduções abaixo do limite definido no modelo

Nota: os rácios apresentados são adimensionais. Um valor de 1,000 corresponde à dimensão da configuração de referência; valores inferiores indicam redução e valores superiores indicam aumento face a essa configuração.

Os resultados mostraram que o Flexy Beast e o Paraglider Hand responderam de forma semelhante aos mesmos perfis, reduzindo ou aumentando a maior dimensão da palma. O perfil infantil produziu rácios de 0,761 e 0,747 face ao valor de referência; a mulher adulta ficou em 0,932 e 0,928; e o homem adulto em 1,148 e 1,157. No Phoenix, o limite mínimo impediu a redução abaixo de cerca de 82 mm de largura da palma e manteve os perfis pequenos no tamanho mínimo previsto pelo modelo.

Tabela 8.7 — Rácio adimensional da maior dimensão da palma exportada face ao valor de referência

Perfil	Flexy Beast	Paraglider Hand	UnLimbited Phoenix
Valor de referência	1,000	1,000	1,000
Criança	0,761	0,747	1,000 após a correcção
Mulher adulta	0,932	0,928	1,000
Homem adulto	1,148	1,157	1,171

Antes da correcção, um percurso alternativo do Phoenix tinha produzido um rácio de 0,760 no perfil infantil. Esse valor foi rejeitado porque ultrapassava o limite mínimo declarado para o modelo; por isso, não integra a Tabela 8.7 como resultado aceite.

Esta verificação revelou três fragilidades técnicas que não eram visíveis na análise numérica isolada. A primeira estava no mecanismo de correspondência populacional: a análise inicial de sexo e idade era demasiado frágil, e certas abreviaturas presentes no texto de entrada podiam ser interpretadas incorrectamente, confundindo unidades de medida com indicação de sexo masculino.

A correcção passou por uma análise mais robusta do texto de entrada, capaz de reconhecer termos em diferentes línguas, respeitar fronteiras de palavra e classificar de forma mais fiável os grupos etários.

A segunda fragilidade foi identificada no modelo Paraglider. Neste caso, a dimensão da palma da mão protésica não estava a responder corretamente aos valores sugeridos, porque permanecia associada a uma escala interna herdada da biblioteca original. A correcção consistiu em aplicar novamente a escala no ponto do código responsável pela geração dessa geometria. A terceira fragilidade surgiu no modelo UnLimbited Phoenix, onde um parâmetro alternativo permitia ultrapassar o limite mínimo de escala definido para o modelo. A correcção passou por aplicar esse mesmo limite também a esse percurso alternativo de geração.

Esta etapa mostra que a avaliação das sugestões deve continuar para além da resposta em JSON. A malha exportada e a preparação para impressão podem revelar dependências internas, limites de escala, problemas de espessura, folgas insuficientes e heranças de código ausentes da análise numérica. Os modelos integrados respondem de forma distinta aos mesmos perfis: o Flexy Beast aceitou a redução usada no ensaio, o Paraglider passou a propagar a escala para a palma após a correcção e o Phoenix manteve o limite dimensional da biblioteca original. A selecção de um modelo para uma pessoa concreta exige critérios e dados que este ensaio não avaliou.

8.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS FACE AOS OBJECTIVOS

Face aos objectivos, os resultados sustentam a integração técnica do design paramétrico, dos dados antropométricos, da interface web e da IA num protótipo de investigação. A informação textual pode originar um conjunto inicial de parâmetros editáveis e visualizáveis, desde que os valores sejam limitados pelo esquema, confirmados na geometria e revistos por uma pessoa competente. O estudo não mediu se este fluxo reduz esforço, tempo, custo ou dependência de especialistas.

A avaliação delimita o papel da IA. Uma resposta isolada não constitui prescrição; não existe uma medição clínica individual que permita calcular erro anatómico; e a lateralidade mostrou que parâmetros críticos devem permanecer sob regras determinísticas. A verificação geométrica identificou limites próprios de cada modelo. As peças físicas confirmaram que as configurações seleccionadas podiam ser preparadas e produzidas nas condições registadas, sem sustentar conclusões sobre ajuste, montagem completa, resistência, conforto ou uso continuado.

O resultado metodológico central é a sequência de controlo formada pelo esquema de parâmetros, limites, filtragem de campos, referência populacional, execução em OpenSCAD/WebAssembly, exportação, preparação e impressão. As correcções de correspondência populacional, escala e lateralidade mostram que o conhecimento projectual surgiu da construção, do ensaio e da reformulação do artefacto, em coerência com Research Through Design. Esta sequência permite localizar falhas técnicas e explicitar onde termina a evidência produzida.

CAPÍTULO 9 — CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

9.1 RESPOSTA AO PROBLEMA E ÀS PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO

A investigação desenvolveu um protótipo de plataforma para configurar modelos de mão protésica através de parâmetros, referências antropométricas, sugestões de IA, execução de OpenSCAD no navegador e exportação para fabrico aditivo. A avaliação sustenta o funcionamento técnico deste fluxo nas condições registadas. O estudo não estabelece eficácia médica, adequação anatómica individual ou prontidão para utilização real.

Quanto à primeira pergunta, o design paramétrico e a IA apoiaram a configuração preliminar através de funções distintas. O esquema definiu nomes, tipos, intervalos e valores correntes; a IA propôs conjuntos iniciais de parâmetros nos casos arquivados; as regras determinísticas controlaram a lateralidade e a geração geométrica; e a decisão final permaneceu sob responsabilidade humana. Esta distribuição tornou explícito o limite da IA como mecanismo de sugestão. Conforto, ajuste individual e desempenho funcional ficaram fora da avaliação.

Quanto à segunda pergunta, a combinação de ciclos de Research Through Design, ensaios unitários, cenários simulados, inspecção de respostas JSON, medição de malhas, exportação, preparação em programas de fatiamento e observação de peças físicas permitiu examinar diferentes etapas do mesmo percurso. A análise revelou falhas de correspondência populacional, lateralidade, propagação de escala, limites mínimos e integridade de malha. Cada método incidiu sobre um objecto específico e, em conjunto, permitiram relacionar valores, geometria e materialização. Ensaios dimensionais das peças, séries controladas, resistência e avaliação clínica exigem protocolos posteriores.

Quanto à terceira pergunta, o Design Industrial articulou os componentes através da organização dos parâmetros por função, da definição de permissões, da apresentação da geometria e da sequência entre configuração, visualização, exportação e preparação para fabrico. A arquitectura separou interface, persistência, sugestão por IA e processamento geométrico no navegador. Esta separação permitiu localizar a origem de cada transformação e reservar decisões críticas para regras ou pessoas responsáveis.

A hipótese principal recebeu apoio nos três modelos comparados: o sistema completou o fluxo entre configuração, geração, exportação e preparação, embora com limites próprios de cada biblioteca. As hipóteses secundárias foram igualmente apoiadas pelos casos estudados. O controlo independente expôs relações ocultas pelo escalonamento uniforme; a IA forneceu pontos de partida dentro do esquema, mas revelou uma falha sistemática de lateralidade; e a análise das malhas e dos protótipos identificou problemas ausentes da resposta numérica. Estas conclusões permanecem circunscritas às versões, cenários e condições documentadas.

9.2 CONTRIBUTOS DA INVESTIGAÇÃO

O contributo projectual é o protótipo integrado e a definição do seu fluxo: selecção do modelo, introdução ou sugestão de parâmetros, visualização, exportação e preparação para fabrico. A separação entre parâmetros antropométricos, parâmetros geométricos, escolhas de apresentação e lateralidade torna explícita a distribuição das decisões.

O contributo técnico é a integração de modelos OpenSCAD com uma configuração comum, execução no navegador, exportação STL/3MF, base antropométrica local e apoio de IA limitado pelo esquema activo. As correcções do mecanismo de correspondência, da escala da palma no Paraglider, do limite mínimo no Phoenix e da lateralidade mostram problemas concretos e as respectivas soluções.

O contributo metodológico é a documentação dos ciclos de Research Through Design que ligam situação, artefacto, ensaio, resultado e alteração. A passagem sucessiva pela resposta numérica, geometria exportada, projecto de fatiamento e peça física revelou falhas que ficariam ocultas num único nível de análise.

O contributo para o conhecimento em Design Industrial reside em duas conclusões delimitadas. Primeiro, a personalização paramétrica depende da correspondência explícita entre fonte antropométrica, nome do parâmetro, regra geométrica e resultado material. Segundo, a IA tem utilidade como apoio à configuração inicial quando as decisões críticas são protegidas por regras, limites e supervisão humana. Estas conclusões resultam do protótipo e dos casos estudados; a sua transferência para outros modelos ou regiões corporais requer nova implementação e nova avaliação.

9.3 LIMITAÇÕES

Os casos de teste são simulados e não incluem participantes, medições clínicas ou dados individuais de uma pessoa amputada. Por esse motivo, os valores sugeridos foram comparados com esquemas e referências populacionais, sem cálculo de erro face a uma mão concreta. A base antropométrica combina populações, idades, sexos, lados medidos e protocolos diferentes; alguns países mencionados nos cenários não estão nela representados.

Os registos da IA correspondem a conjuntos finitos de execuções e a versões específicas do código. Não foi realizado um estudo estatístico com amostras extensas por cenário. A versão actual da branch staging foi inspeccionada e os dez ensaios unitários disponíveis foram concluídos, mas a bateria completa no navegador não foi novamente executada no fecho da dissertação.

A avaliação física baseia-se em três perfis de preparação, configurações reutilizadas noutras impressões e registo fotográfico das peças. Não existem medições dimensionais sistemáticas das peças, comparação controlada entre PLA e PETG, ensaios de carga, desgaste, conforto, segurança, montagem funcional completa ou utilização prolongada.

O estudo examinou em profundidade três modelos activos. O Cyborg Beast está registado na plataforma, mas não integra a comparação geométrica principal. Os resultados relativos ao Flexy Beast, Paraglider Hand e UnLimbited Phoenix dependem das respectivas bibliotecas, intervalos e mecanismos de escala.

9.4 TRABALHO FUTURO

A primeira etapa futura deve criar uma referência dimensional verificável. Para cada perfil, devem registar-se medidas de entrada, dimensões da malha e dimensões da peça impressa nos mesmos pontos anatómicos, com instrumentos, tolerâncias e critérios de aceitação definidos. Esta etapa permitiria quantificar os desvios introduzidos pela modelação, exportação, fatiamento e impressão.

A segunda etapa deve alargar os ensaios da IA. Cada cenário deve ser executado várias vezes, com registo do modelo, parâmetros de geração, resposta completa, erros, campos omitidos e taxa de cumprimento de cada

regra. A interface deve mostrar a fonte populacional usada, os dados em falta e avisos quando a dimensão estimada fica fora da gama do modelo escolhido. A validação do esquema JSON deve ocorrer no servidor antes de a sugestão chegar à interface.

A terceira etapa deve avaliar fabrico e função por protocolos separados. Os ensaios devem comparar materiais e impressoras com corpos de prova e componentes equivalentes, medir folgas e montagem, e aplicar testes de carga, fadiga e desgaste adequados ao uso previsto. Só depois desta caracterização deve avançar uma avaliação com participantes e profissionais, mediante enquadramento ético e clínico apropriado.

A quarta etapa deve estudar a interface com os grupos de utilizadores previstos. As tarefas, erros, tempo, compreensão das sugestões, confiança e distribuição de responsabilidade devem ser avaliados com pessoas amputadas, designers, técnicos e profissionais de saúde. Esta etapa permitirá verificar se o fluxo facilita a configuração e se os avisos e controlos apoiam decisões informadas.

Por fim, a integração de novas regiões corporais deve começar pela definição de requisitos, dados, parâmetros e limites específicos. A arquitectura de configuração oferece uma base possível, mas ainda não demonstra que o sistema funcione para dispositivos destinados ao pé, à perna ou ao braço.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Akasaka, M., Veeckman, C., Georges, A., Schuurman, D., & Coorevits, L. (2022). A framework for configuring participation in living labs. <https://www.semanticscholar.org/paper/305d55af5fda06b4d1b33e7d29c1f16d1b7ea488>
- Akyol, P., Barker, T., Hall, R., Morrissey, K., McCarthy, J., & Mackley, K. L. (2021). DiaFit: Designing customizable wearables for Type 1 diabetes monitoring. <https://www.semanticscholar.org/paper/ea18361f7564fb19db367899adb6295a07bfa05c>
- Albin, T., & Molenbroek, J. F. M. (2023). Introduction to the special issue, anthropometry in design. <https://repository.tudelft.nl/file/Fileda5bfdc9-98bc-41d3-a402-553d5f0d0a63>
- Alili, A., Nalam, V., Li, M., Liu, M., Feng, J., Si, J., & Huang, H. (2023). A novel framework to facilitate user preferred tuning for a robotic knee prosthesis. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 31, 895-903. <https://doi.org/10.1109/TNSRE.2023.3236217>
- Alluhydan, A., Alsaadi, S., Almutairi, A., & Alharbi, A. (2023). Functionality and comfort design of lower-limb prosthetics: A review.
- Anacleto Filho, P. C., da Silva, L., Mattos, D., Pombeiro, A., Castellucci, H. I., Colim, A., Carneiro, P., & Arezes, P. (2023). Establishing an anthropometric database: A case for the Portuguese working population. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 97, 103473. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2023.103473>
- Anderson, C. B., Stephens, A. R., Scully, A., Pasquina, P. F., & Highsmith, M. J. (2024). A narrative review of prosthesis design decision making after lower-limb amputation for developing shared decision-making resources.
- Andrysek, J. (2010). Lower-limb prosthetic technologies in the developing world: A review of literature from 1994-2010.
- Ao, Y., Li, S., & Duan, H. (2025). Artificial intelligence-aided design (AIAD) for structures and engineering: A state-of-the-art review and future perspectives. *Archives of Computational Methods in Engineering*. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11831-025-10264-1.pdf>
- ASTM International. (2024). Standard guide for assessing fit accommodation of exoskeletons for manufacturers and designers. <https://www.astm.org/f3661-24.html>
- Atallah, H., Qufabz, T., Naeem, R., Bakhsh, H. R., Ferriero, G., Varga, D., Derkács, E., & Molics, B. (2025). The current state of 3D-printed prostheses clinical outcomes: A systematic review. *Journal of Functional Biomaterials*, 16(10), 370. <https://doi.org/10.3390/jfb16100370>
- Bai, X., Yuan, J., Liu, M., Huang, H., & Feng, J. (2024). Human factors considerations of interaction between wearers and intelligent lower-limb prostheses: A prospective discussion. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 21, 187. <https://doi.org/10.1186/s12984-024-01475-x>
- Baldock, C., Greaves, M., Chockalingam, N., & Kark, L. (2023). Adjustable prosthetic sockets: A systematic review of industrial and research design characteristics and their justifications.
- Baron, A., Gatzweiler, C., Geislinger, A., Huber, C., & Aszmann, O. C. (2020). 3D multi-material printing of an anthropomorphic, personalized replacement hand for use in neuroprosthetics using 3D

scanning and computer-aided design: First proof-of-technical-concept study. *Prosthesis*, 2(4), 274-287.
<https://doi.org/10.3390/prosthesis2040021>

Barredo Arrieta, A., Díaz-Rodríguez, N., Del Ser, J., Benetot, A., Tabik, S., Barbado, A., García, S., Gil-López, S., Molina, D., Benjamins, R., Chatila, R., & Herrera, F. (2020). Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. *Information Fusion*, 58, 82-115. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012>

Base local consolidada de dados antropométricos da mão e do membro superior distal. (2026). [Conjunto de dados]. Material de apoio da investigação, data/multi_population_hand.csv, repositório da plataforma.

Bates, T., Ferguson, J., & Pierrie, S. N. (2020). Technological advances in prosthesis design and rehabilitation following upper extremity limb loss.
<https://www.semanticscholar.org/paper/905056ffa9fa963e8df8b974d90b94c05a5f7e29>

Baumann, C., & Maria, P. (2023). Improving access to prosthetic limbs in Germany: An explorative review.

Biddiss, E., Beaton, D., & Chau, T. (2007). Consumer design priorities for upper limb prosthetics. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 2(6), 346-357.
<https://doi.org/10.1080/17483100701714733>

Brack, T., & Amalu, E. H. (2021). A review of technology, materials and R&D challenges of upper limb prosthesis for improved user suitability. *Journal of Orthopaedics*, 24, 88-96.
<https://doi.org/10.1016/j.jor.2021.03.011>

Bradtmiller, B. (2022). Design for all, design for disabled: How important is anthropometry?
<https://researchonline.jcu.edu.au/76898/>

Brooks, C. (2026). OpenSCAD Web [Computer software]. GitHub.
<https://github.com/CameronBrooks11/openscad-web>

Burnap, A., Hauser, J., & Timoshenko, A. (2019). Design and evaluation of product aesthetics: A human-machine hybrid approach.
<https://www.semanticscholar.org/paper/7a7994f2de74a61cbdeb3c230d1ee343a0d5e783>

Bustamante, M., Vega-Centeno, R., Sanchez, M., & Mio, R. (2018). A parametric 3D-printed body-powered hand prosthesis based on the four-bar linkage mechanism. In *International Conferences on Biological Information and Biomedical Engineering*.

Cabibihan, J.-J., Abubasha, M. K., & Thakor, N. V. (2021). Suitability of the openly accessible 3D printed prosthetic hands for war-wounded children. *Frontiers in Robotics and AI*, 7, 594196.
<https://doi.org/10.3389/frobt.2020.594196>

Cabibihan, J.-J., Pattofatto, S., Jomaa, M., Benallal, A., & Carrozza, M. C. (2018). A method for 3-D printing patient-specific prosthetic arms with high accuracy shape and size. *IEEE Access*, 6, 25029-25039.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2831907>

Chadwell, A., Kenney, L., Thies, S., Galpin, A., & Head, J. (2020). Technology for monitoring everyday prosthesis use: A systematic review.

- Chainando, N., Faephu, C., Suwaphong, N., Bureerat, S., Limphirat, W., Thammajaruk, P., & Syafrudin, M. (2025). Applying 3D scanning and printing techniques to produce upper limb prostheses: Bibliometric analysis and scoping review. *Prosthesis*, 7(2), 26. <https://www.mdpi.com/2673-1592/7/2/26/pdf?version=1740996517>
- Chapman, K., Allen, C., & Kendall, E. (2025). Methods for co-designing health communication initiatives with people with disability: A scoping review. *Health Communication*. <https://doi.org/10.1080/10810730.2025.2462679>
- Chatzioglou, G. N., Pinar, Y., & Govsa, F. (2024). Biometric analysis hand parameters in young adults for prosthetic hand and ergonomic product applications. *Anatomy & Cell Biology*, 57, 172-182. <https://doi.org/10.5115/acb.23.310>
- Choudhury, M. M., Eisenbart, B., & Kuys, B. (2025). Artificial intelligence (AI) in the design process: A review and analysis on generative AI perspectives. <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/36E8736EEB55F0B38C2C9AB47EF381FE/S2732527X25100771a.pdf/div-class-title-artificial-intelligence-ai-in-the-design-process-a-review-and-analysis-on-generative-ai-perspectives-div.pdf>
- Chtioui, N., Gaha, R., & Benamara, A. (2023). Design for additive manufacturing: Review and framework proposal. <https://sei.ardascience.com/index.php/journal/article/download/185/169>
- Clarkson, J., & Coleman, R. (2010). Inclusive design. *Design Studies*. <https://doi.org/10.1080/09544821003693689>
- Cole, E. (2011). Patient-centered design: Interface personalization for individuals with brain injury.
- Colombo, G., Facoetti, G., Rizzi, C., & Vitali, A. (2015). Low cost hand-tracking devices to design customized medical devices. *Interacción*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-21067-436>
- Cordella, F., Ciancio, A. L., Sacchetti, R., Davalli, A., Cutti, A. G., Guglielmelli, E., & Zollo, L. (2016). Literature review on needs of upper limb prosthesis users.
- Costabile, M. F., Fogli, D., Lanzilotti, R., Marcante, A., Mussio, P., Provenza, L. P., & Piccinno, A. (2007). Meta-design to face co-evolution and communication gaps between users and designers.
- Cross, N. (1982). Designerly ways of knowing. *Design Studies*, 3(4), 221-227. [https://doi.org/10.1016/0142-694X\(82\)90040-0](https://doi.org/10.1016/0142-694X(82)90040-0)
- Çıklaçandır, S., Yilmaz, M., Ozmert, O. S., Şahin, A. M., & Mihçin, S. (2022). Comparison of traditional, MRI, and 3D scanning anthropometric measurements in hand prosthesis design. <https://www.semanticscholar.org/paper/a24aab5d4434a01eeda73c8a62f921580ceba54>
- da Silveira Romero, R. C., Costa, K. A., Reis, P. H. R. G., & Vimieiro, C. B. S. (2025). Development of parametric prostheses for different levels of human hand amputations manufactured through additive manufacturing. *Applied Sciences*, 15, 4467. <https://doi.org/10.3390/app15084467>
- Dechev, N., Penner, A., Barlow, I., Vukovic, G., & Lalji, M. (2023). Accessible prosthetic arms: Victoria Hand Project and the impact of 3D printing.
- Design Council. (2020). Framework for innovation. <https://www.designcouncil.org.uk/our-resources/framework-for-innovation/>

- Dexter, M., Crooks, E., Davies, P., & Simm, W. (2013). Open design and cystic fibrosis: Enabling participation in the design process.
- Diment, L. E., Thompson, M. S., & Bergmann, J. H. M. (2018). Three-dimensional printed upper-limb prostheses lack randomised controlled trials: A systematic review. *Prosthetics and Orthotics International*, 42(1), 7-13. <https://doi.org/10.1177/0309364617704803>
- Domínguez-Ruiz, M., Ráez-Ballesteros, E., & Castillo-Castañeda, E. (2023). Low limb prostheses and complex human prosthetic interaction: A systematic literature review.
- Elbreki, A. M., Alshari, K., Ramdan, S., & Rajab, Z. (2022). Practical design of an upper prosthetic limb using three dimensional printer with an artificial intelligence based controller. In 2022 International Conference on Engineering & MIS (ICEMIS). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICEMIS56295.2022.9914291>
- ELhadad, N., Aboulhassan, A., & Hassan, Y. M. I. (2026). LLM-based 3D model generation of MHE for OpenSCAD. *Procedia Computer Science*.
- Engdahl, S., Gonzalez, M. A., Lee, C., & Gates, D. H. (2024). Perspectives on the comparative benefits of body-powered and myoelectric upper limb prostheses. <https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12984-024-01436-4>
- Figoli, F. A., Mattioli, F., & Rampino, L. (2022). AI in design idea development: A workshop on creativity and human-AI collaboration. <https://dl.designresearchsociety.org/cgi/viewcontent.cgi?article=2915&context=drs-conference-papers>
- Fink, C., & Diamond, Y. (2023). Prosthesis options and management in upper extremity amputation. <https://www.semanticscholar.org/paper/3532a770446eb6144ef25a6b0162d1f98b61e0ff>
- Fischer, G., Fogli, D., & Piccinno, A. (2017). Revisiting and broadening the meta-design framework for end-user development.
- Fischer, G., Giaccardi, E., Ye, Y., Sutcliffe, A. G., & Mehandjiev, N. (2004). Meta-design.
- Fisher, M., & Johansen, E. (2020). Human-centered design for medical devices and diagnostics in global health. <https://www.semanticscholar.org/paper/89c3c6bd56f4d0b54f5da3e3c96f18e815d9f5d4>
- Frangos, P., Mierdel, S., & Koirala, S. (2016). Democratising design in scientific innovation: Application of an open value network to open source hardware design.
- Franke, N., & von Hippel, E. (2002). Satisfying heterogeneous user needs via innovation toolkits: The case of Apache security software.
- Frayling, C. (1994). Research in art and design (Royal College of Art Research Papers, Vol. 1, No. 1, 1993/4). Royal College of Art.
- Ghali, S. (2008). Constructive solid geometry. In *Introduction to geometric computing*.
- Ghillebert, J., Schoukens, J., & Vanderborght, B. (2019). Guidelines and recommendations to investigate the efficacy of a lower-limb prosthetic device: A systematic review.
- Gonzalez Avila, J. F., Pietrzak, T., Girouard, A., & Casiez, G. (2024). Understanding the challenges of OpenSCAD users for 3D printing. In *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM. <https://arxiv.org/abs/2408.01796>

- Gordon, C. C., Blackwell, C. L., Bradtmiller, B., Parham, J. L., Barrientos, P., Paquette, S. P., Corner, B. D., Carson, J. M., Venezia, J. C., Rockwell, B. M., Mucher, M., & Kristensen, S. (2015). 2012 anthropometric survey of U.S. Army personnel: Methods and summary statistics (Report No. NATICK/TR-15/007). U.S. Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center.
- Gordon, C. C., Churchill, T., Clauser, C. E., Bradtmiller, B., McConville, J. T., Tebbetts, I., & Walker, R. A. (1989). Anthropometric survey of U.S. Army personnel: Methods and summary statistics 1988 (Technical Report NATICK/TR-89/044). U.S. Army Natick Research, Development and Engineering Center.
- Górski, F., Zawadzki, P., Wichniarek, R., Kuczko, W., Słupińska, S., & Żukowska, M. (2022). Automated design and rapid manufacturing of low-cost customized upper limb prostheses. *Journal of Physics: Conference Series*, 2198, 012040. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2198/1/012040>
- Govender, R., Abrahamsén-Alami, S., Larsson, A., Borde, A., Liljeblad, A., & Folestad, S. (2020). Independent tailoring of dose and drug release via a modularized product design concept for mass customization. *Pharmaceutics*.
- Gu, Y., He, L., Zeng, H., Li, J., Zhang, N., Zhang, X., & Liu, T. (2024). A data-driven design framework for structural optimization to enhance wearing adaptability of prosthetic hands. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 32. <https://doi.org/10.1109/TNSRE.2024.3430070>
- Guo, M. (2025). Human-centered design strategies for prosthetics based on user needs. *Interdisciplinary Humanities and Communication Studies*, 1(1), 39-48.
- Hafner, B. J., & Sawers, A. B. (2016). Issues affecting the level of prosthetics research evidence: Secondary analysis of a systematic review.
- Henao, J. C., Phillips, S. T., Brooks, T. L., Pienta, K. J., Brantley, J. S., & Carey, S. L. (2025). Upper-limb prosthetic requirements from the healthcare providers, end-users and relatives' perspectives. *Journal of Hand Therapy*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.jht.2025.01.004>
- Herbst, Y., Georgopoulou, A., Dettwyler, M., Fernandez, A., Bacher, M., & Paik, J. (2021). Scan-driven fully-automated pipeline for a personalized, 3D printed low-cost prosthetic hand. In 2021 IEEE 17th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE) (pp. 1188-1194). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CASE49439.2021.9551649>
- Herneth, T., Hiesl, A., Stief, F., & Farago, D. (2024). Functional kinematic and kinetic requirements of the upper limb during activities of daily living: A recommendation on necessary joint capabilities for prosthetic arms. In 2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) (pp. 1-8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IROS58592.2024.10801868>
- Hippel, E. von, & Katz, R. (2002). Shifting innovation to users via toolkits. *Management Science*, 48(7).
- Hofmann, M. H., Griffiths, D., & Margetts, E. (2016). Helping hands: Requirements for a prototyping methodology for upper-limb prosthetics users. In *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1769-1780). ACM. <https://doi.org/10.1145/2858036.2858346>
- Howard, D., Davies, L., Dwyer, A., & Williams, J. (2022). Assessing the use of co-design to produce bespoke assistive technology solutions within a current healthcare service: A service evaluation.

- Hu, H., Li, Z., Yan, J., Wang, X., Xiao, H., Duan, J., & Zheng, L. (2007). Anthropometric measurement of the Chinese elderly living in the Beijing area. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 37(4), 303-311. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2006.11.006>
- Hussaini, A., Kyberd, P., Mulindwa, B., Ssekitoileko, R., Keeble, W., Kenney, L., & Howard, D. (2023). 3D printing in LMICs: Functional design for upper limb prosthetics in Uganda.
- Ibiwari, B. W., Osemeke, B. E., Progress, V. D., Khadija, A., & Chikere, O. P. (2025). Hand anthropometric measurement and grip strength for basketball and volleyball players in higher institutions in Port Harcourt metropolis. *International Journal of Science Academic Research*, 6(8), 10513-10517.
- Ibrahim, M. T., Azman, H., Adzahar, N. S. I. A., Ismail, M. A., & Shaharuddin, S. (2024). Techniques for measuring the fluctuation of residual lower limb volume in clinical practices: A systematic review of the past four decades. *Applied Sciences*, 14(6), 2594. <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/6/2594/pdf?version=1710932396>
- Idris, M. Z., Hashim, M. E. A. H. B., Albakry, N., & Septian, N. (2024). Exploring the integration of artificial intelligence in co-design framework for designer. <https://ebpj.e-iph.co.uk/index.php/EBProceedings/article/download/6348/3640>
- Jones, M. L. H., Vrieling, A. H., Steadman, J., & Kyberd, P. J. (2023). Evidencing the effectiveness of upper limb prostheses: A multi-stakeholder perspective on study requirements. *Frontiers in Health Services*, 3, 1123682. <https://doi.org/10.3389/frhs.2023.1123682>
- Kadenhe, N., Al Musleh, M., & Lompot, A. (2025). Human-AI co-design and co-creation: A review of emerging approaches, challenges, and future directions. <https://www.semanticscholar.org/paper/61c04706b7af0be5be4b0d15f595d4ab41874d12>
- Kandikjan, T., Djokikj, J., Mircheski, I., & Angeleska, E. (2022). Integrating parametric design and additive manufacturing knowledge in industrial design education. <https://www.semanticscholar.org/paper/7d28a8c124ef0a3599dd937791a3f3e093775ac0>
- Kannenbergh, A., Buis, A. W. P., Sengeh, D. M., & Worsley, P. R. (2024). Insights into the spectrum of transtibial prosthetic socket design from expert clinicians and their digital records. *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, 5. <https://doi.org/10.3389/fresc.2024.1354069>
- Kaygan, H., & Kaygan, P. (2025). Clients and carers: Healthcare professionals' roles in medical device development processes in SMEs. *The Design Journal*, 28(2), 213-231. <https://doi.org/10.1080/14606925.2024.2420152>
- Kellam, S. M., Boleneus, G. J., Stewart, J., Richter, D. C., Michaelis, B. M., & Gerlick, R. E. (2019). An undergraduate engineering service learning project involving 3D-printed prosthetic hands for children. In *American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition Proceedings*.
- Kerr, A., Del Din, S., Clarkson, P. J., & Rochester, L. (2024). A participatory model for cocreating accessible rehabilitation technology for stroke survivors: User-centered design approach.

Khanolkar, P., Vrolijk, A., & Olechowski, A. (2023). Mapping artificial intelligence-based methods to engineering design stages: A focused literature review.

<https://www.semanticscholar.org/paper/4d63443d45e1a7156c5972ef009ed07bb0650117>

Krahe, C., Bräunche, A., Jacob, A., Stricker, N., & Lanza, G. (2020). Deep learning for automated product design. <https://www.semanticscholar.org/paper/a5b9b4f63805f2b1773bc8214b29e38dbac27975>

Kuhl, M., Lutz, J., Krause, D., & Vielhaber, M. (2020). Design of personalized devices: The tradeoff between individual value and personalization workload. *Applied Sciences*.

Lei, N., Yao, X., Moon, S. K., & Bi, G. (2016). An additive manufacturing process model for product family design.

<https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/10356/83735/1/An%20additive%20manufacturing%20process%20model%20for%20product%20family%20design.pdf>

Li, M., & Aflatoony, L. (2025). Parametric design and three-dimensional printing: Enabling occupational therapists to develop custom hand grips. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 20(6), 1829-1837. <https://doi.org/10.1080/17483107.2025.2483953>

Li, X., Demirel, H., Goldstein, M., & Sha, Z. (2021). Exploring generative design thinking for engineering design and design education. <https://peer.asee.org/38349.pdf>

Lim, D., Georgiou, T., Bhardwaj, A., O'Connell, G. D., & Agogino, A. M. (2018, August 26). Customization of a 3D printed prosthetic finger using parametric modeling. In *Proceedings of the ASME 2018 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference*. <https://doi.org/10.1115/DETC2018-85645>

Lindell, E., Tingsvik, H., Guo, L., & Peterson, J. (2021). 3D body scan as anthropometric tool for individualized prosthetic socks. <https://sciendo.com/pdf/10.2478/aut-2021-0007>

Machado, F., Malpica, N., & Borromeo, S. (2019). Parametric CAD modeling for open source scientific hardware: Comparing OpenSCAD and FreeCAD Python scripts. *PLOS ONE*, 14(12), e0225795. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225795>

Manero, A., Smith, P., Sparkman, J., Dombrowski, M., Courbin, D., Kester, A., Womack, I., & Chi, A. (2019). Implementation of 3D printing technology in the field of prosthetics: Past, present, and future. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16, 1641. <https://doi.org/10.3390/ijerph16091641>

Manz, S. M., Menges, M. M., Schaffernicht, E., Mattes, K., & Kannenberg, A. (2022). A review of user needs to inform the development of lower-limb prostheses.

Marinelli, M., Putrino, D., Stella, F., & Guglielmelli, E. (2022). Active upper limb prostheses: A review on current state and upcoming breakthroughs.

Menaka, S., Raja, W., Ramakrishnan, S., Karthikeswaran, D., Sridar, K., & Sivaranjani, T. (2025). AI-driven computer-aided design (CAD) systems: Leveraging neural networks for optimized engineering product development. *International Journal of Applied Mathematics*, 38(5s). <https://ijamjournal.org/ijam/publication/index.php/ijam/article/download/341/311>

- Mikołajewski, D., Rojek, I., Kotlarz, P., Dorożyński, J., & Kopowski, J. (2023). Personalization of the 3D-printed upper limb exoskeleton design: Mechanical and IT aspects. *Applied Sciences*.
- Millet, A., Akle, A. A., & Legardeur, J. (2018). Human centred criteria for healthcare design. <https://www.semanticscholar.org/paper/267b655f123f4f167f1f9e7e6c8a1f17f73a73d0>
- Mistarihi, M. Z. (2020). A data set on anthropometric measurements and degree of discomfort of physically disabled workers for ergonomic requirements in work space design. *Data in Brief*, 30, 105420. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105420>
- Molenbroek, J. F. M. (1998). Geron study on Dutch elderly anthropometry. DINED database. Delft University of Technology. <https://dined.io.tudelft.nl>
- Molenbroek, J. F. M., Kroon-Ramaekers, Y. M. T., & Snijders, C. J. (2003). Revision of the Dutch standard for furniture in schools. *Ergonomics*, 46(5), 491-498. <https://doi.org/10.1080/0014013031000085635>
- Moreo, A. M. (2016). Parametric design of a 3D printable hand prosthesis for children in developing countries [Master's thesis, Delft University of Technology].
- Nag, A., Nag, P. K., & Desai, H. (2003). Hand anthropometry of Indian women. *Indian Journal of Medical Research*, 117, 260-269.
- Nilsiam, Y., & Pearce, J. M. (2017). Free and open source 3-D model customizer for websites to democratize design with OpenSCAD. *Designs*, 1(1), 5. <https://doi.org/10.3390/designs1010005>
- Nini, L., Ceccarelli, A., Tagliamonte, N., Zollo, L., & Taffoni, F. (2024). Parametric 3D modeling of a customized prosthetic hand finger for additive manufacturing. In 2024 10th IEEE RAS/EMBS International Conference for Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob). IEEE. <https://doi.org/10.1109/BioRob60516.2024.10719909>
- Oldfrey, B., Ramirez, D. Z. M., Miodownik, M., et al. (2024). A scoping review of digital fabrication techniques applied to prosthetics and orthotics: Part 1 of 2—Prosthetics. *Prosthetics and Orthotics International*. <https://doi.org/10.1097/PXR.0000000000000351>
- OpenSCAD Community. (n.d.). OpenSCAD User Manual/Using OpenSCAD in a command line environment. Wikibooks. Retrieved July 7, 2026, from <https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCADUserManual/UsingOpenSCADinacommandlineenvironment>
- OpenSCAD Project. (n.d.-a). OpenSCAD: The programmers solid 3D CAD modeller. Retrieved July 7, 2026, from <https://openscad.org/>
- OpenSCAD Project. (n.d.-b). OpenSCAD source repository [Computer software]. GitHub. Retrieved July 7, 2026, from <https://github.com/openscad/openscad>
- Ozdemir, M., Verlinden, J., & Cascini, G. (2022). Design methodology for mass personalisation enabled by digital manufacturing. <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/0F2B66A61E2CE6410F9D1F335244EB9C/S2053470122000038a.pdf/div-class-title-design-methodology-for-mass-personalisation-enabled-by-digital-manufacturing-div.pdf>

Panchal, J. H., Fuge, M., Liu, Y., Missoum, S., & Tucker, C. S. (2019). Special issue: Machine learning for engineering design. *Journal of Mechanical Design*.

<https://www.semanticscholar.org/paper/2c4f7ca9381db7debefe61d04da51f9e8e63d09d>

Parlamento Europeu, & Conselho da União Europeia. (2017). Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices.

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj>

Peerdeman, B., Boere, D., Witteveen, H., Huis in 't Veld, R., Hermens, H., Stramigioli, S., Rietman, H., Veltink, P., & Misra, S. (2011). Myoelectric forearm prostheses: State of the art from a user-centered perspective. *Journal of Rehabilitation Research and Development*, 48(6), 719-738.

<https://doi.org/10.1682/JRRD.2010.08.0161>

Peixoto, S., Martins, N., Miranda, D., Matos, D., & Carvalho, V. (2025). The design process in the development of an online platform for personalizing wearable prostheses: A preliminary approach. *Designs*, 9(2), 39. <https://doi.org/10.3390/designs9020039>

Peters, C., & Richter, P. (2023). Individualizing patient pathways through modularization: Design and evaluation of healthcare-specific modularization parameters.

Quintero, D., Reznick, E., Lambert, D. J., Rezazadeh, S., Gray, L., & Gregg, R. D. (2018). Intuitive clinician control interface for a powered knee-ankle prosthesis: A case study. *IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine*, 6, 2600209. <https://doi.org/10.1109/JTEHM.2018.2880199>

Ramnath, S., Haghighi, P., Kim, J. H., Detwiler, D., Berry, M., Shah, J., Aulig, N., Wollstadt, P., & Menzel, S. (2019). Automatically generating 60,000 CAD variants for big data applications.

<https://www.semanticscholar.org/paper/40a0b51e5b01234cec3e807158b26a284ea77e0f>

Resnik, L., Klinger, S. L., Krauthamer, V., & Barnabe, K. (2010). U.S. Food and Drug Administration regulation of prosthetic research, development, and testing.

<https://www.semanticscholar.org/paper/71e1fef52dde69cbcea4f62c709f7c6689f9463d>

Rezwana, J., & Maher, M. (2022). Understanding user perceptions, collaborative experience, and user engagement in different human-AI interaction designs for co-creative systems.

<https://arxiv.org/pdf/2204.13217>

Richardson, C., & Dillon, M. P. (2017). User experience of transtibial prosthetic liners: A systematic review.

Rodríguez-Vega, G., & Rodríguez-Vega, D. A. (2024). Normative data for the anthropometric hand dimensions of the Mexican population. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-15.

<https://doi.org/10.31637/epsir-2024-932>

Romani, A., & Levi, M. (2020). Parametric design for online user customization of 3D printed assistive technology for rheumatic diseases. In *International Conference on Augmented and Virtual Reality*.

Romero, E., Garcia, J. G., Parra, M., Caballa, S., Saldarriaga, A. M., Luque, E. F., Rodriguez, D. J., Abarca, V. E., & Elias, D. A. (2025). An affordable AI-driven and 3D-printed personalized myoelectric

prosthesis: Design, development, and assessment. *IEEE Access*, 13.

<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3596475>

Saeidnia, H. R., & Ausloos, M. (2024). Integrating artificial intelligence into design thinking: A comprehensive examination of the principles and potentialities of AI for design thinking framework.

<https://www.semanticscholar.org/paper/e2b8a10036428046443e24dc33ec5306876afdbb>

Saldarriaga, A. M., Romero, E., Abarca, V. E., & Elias, D. A. (2024). A parametric design approach for affordable customized 3D socket for transradial upper limb prostheses. In 2024 10th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT).

<https://doi.org/10.1109/CoDIT62066.2024.10708382>

Samuelsson, K. A. M., Töytäri, O., Salminen, A.-L., & Brandt, Å. (2012). Effects of lower limb prosthesis on activity, participation, and quality of life: A systematic review.

Schöfer, F., & Seibel, A. (2025). Augmented design automation: Leveraging parametric designs using large language models. *Proceedings of the Design Society*.

Segura, D., Romero, E., Abarca, V. E., & Elías, D. A. (2024). Upper limb prostheses by the level of amputation: A systematic review. *Prosthesis*, 6(2), 22. <https://www.mdpi.com/2673-1592/6/2/22/pdf?version=1710818539>

Seregni, F., Arlati, S., Colombo, V., Spoladore, D., Greci, L., Pedroli, E., Serino, S., Cipresso, P., Goulene, K., Stroulia, E., Rizzo, A., & Sacco, M. (2021). Virtual coaching for rehabilitation: The participatory design experience of the vCare Project.

Shah, S., & Robinson, I. (2006). User involvement in healthcare technology development and assessment: Structured literature review.

<https://www.semanticscholar.org/paper/299d5b2c1d65791cc4c9f2db76edf20f479adcbe>

Silva, L. A. da, Medola, F. O., Rodrigues, O. V., Rodrigues, A. C. T., & Sandnes, F. E. (2018). Interdisciplinary-based development of user-friendly customized 3D printed upper limb prosthesis. *Comunicação em conferência*.

Silva, R., Silva, B., Fernandes, C., Morouco, P., Alves, N., & Veloso, A. (2024). A review on 3D scanners studies for producing customized orthoses. *Sensors*, 24(5), 1373.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10935386/pdf/sensors-24-01373.pdf>

Sims, T., Cranny, A., Metcalf, C., Chappell, P., & Donovan-Hall, M. (2017). Participatory design of pediatric upper limb prostheses: Qualitative methods and prototyping.

Smail, L. C., Neal, C., Wilkins, C., & Packham, T. (2020). Comfort and function remain key factors in upper limb prosthetic abandonment: Findings of a scoping review.

<https://www.semanticscholar.org/paper/b5eb3fd2414ebadaa5d2283451268fafa2db0a81>

Soyer, K., Unver, B., Tamer, S., & Ulger, O. (2016). The importance of rehabilitation concerning upper extremity amputees: A systematic review. <https://pjms.com.pk/index.php/pjms/article/view/9922/4660>

- Squibb, C., Madigan, M. L., & Philen, M. K. (2024). A high precision laser scanning system for measuring shape and volume of transtibial amputee residual limbs: Design and validation. *PLOS ONE*, 19(5). <https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0301619&type=printable>
- Steenbekkers, L. P. A., & van Beijsterveldt, C. E. M. (Eds.). (1998). *Design-relevant characteristics of ageing users*. Delft University Press.
- Story, M. (2006). *Applying the principles of universal design to medical devices*. <https://www.semanticscholar.org/paper/d0d84425d517331607c9120290ed26d1bf2e1862>
- Stralen, M. V. (2018). *Mass customization: A critical perspective on parametric design, digital fabrication and design democratization*. <https://www.semanticscholar.org/paper/a18f2c4d248e791d2a9b84f3cab268d5a377cc10>
- Sunderland, F., Willerth, S., Silver-Thorn, B., & Dickinson, A. (2024). OpenLimbTT, a transtibial residual limb shape model for prosthetics simulation and design: Creating a statistical anatomic model using sparse data. *medRxiv*. <https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2024/11/30/2024.11.27.24317622.full.pdf>
- ten Kate, J., Smit, G., & Breedveld, P. (2017). 3D-printed upper limb prostheses: A review. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 12(3), 300-314. <https://doi.org/10.1080/17483107.2016.1253117>
- Thorsen, R., Hansen, A. H., & Nilsen, E. R. (2023). From patient to maker: A workflow including people with cerebral palsy in co-creating assistive devices using 3D printing technologies.
- Trautmann, L. (2021). *Product customization and generative design*. *Multidiszciplináris Tudományok*.
- Verganti, R., Vendraminelli, L., & Iansiti, M. (2020). *Innovation and design in the age of artificial intelligence*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/jpim.12523>
- Virós-i-Martin, A., & Selva, D. (2021). A framework to study human-AI collaborative design space exploration. <https://www.semanticscholar.org/paper/716be148371af443169531b0856ae07dfe400869>
- Walker, M., Paras, A., Boonstra, N., & Murrup-Stewart, C. (2019). Towards including end-users in the design of prosthetic hands: Ethical analysis of a survey of Australians with upper-limb difference.
- Walters, S., Seminati, E., Metcalfe, B., Bailey, N. Y., & Pegg, E. C. (2025). Demystifying upper limb hybrid prostheses: A scoping review. <https://www.semanticscholar.org/paper/d659aff9bb182a3c92377571973e6e077a3b1838>
- Wang, X., & Hu, B. (2024). Machine learning algorithms for improved product design user experience. <https://www.semanticscholar.org/paper/717e7ad25dcfec12f01b6732773bdf9c5a49661>
- Wendo, K., Barbier, O., Bollen, X., Schubert, T., Lejeune, T., Raucent, B., & Olszewski, R. (2022). Open-source 3D printing in the prosthetic field: The case of upper limb prostheses: A review. *Machines*, 10(6), 413. <https://doi.org/10.3390/machines10060413>
- White, J., & Mosca, E. I. (2022). Developing innovative solutions for universal design in healthcare and other sectors. <https://www.semanticscholar.org/paper/df2bb0d53af547bd89b2c716933c2a544bf422b1>

Wiberg, A., Persson, J., & Ölvander, J. (2019). Design for additive manufacturing: A review of available design methods and software.

<https://www.semanticscholar.org/paper/e03bf769f344512519f1005baa1d6b83fe4fc8ed>

Wilke, H., Badke-Schaub, P., & Thoring, K. (2020). The healthcare design dilemma: Perils of a technology-driven design process for medical products.

<https://www.semanticscholar.org/paper/078781d9389d4618fc1b5db9347ab68ca7ef46d9>

Windrich, M., Grimmer, M., Christ, O., Rinderknecht, S., & Beckerle, P. (2016). Active lower limb prosthetics: A systematic review of design issues and solutions.

Yao, X., Moon, S. K., & Bi, G. (2016). A cost-driven design methodology for additive manufactured variable platforms in product families.

<https://www.semanticscholar.org/paper/f7bc9dc2a80714c18ac068f45b99408b0f4fe65e>

Young, P. R., Hebert, J. S., Marasco, P., Carey, J., & Schofield, J. S. (2023). Advances in the measurement of prosthetic socket interface mechanics: A review of technology, techniques, and a 20-year update. [https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17434440.2023.2244418?](https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17434440.2023.2244418?needAccess=true&role=button)
[needAccess=true&role=button](https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17434440.2023.2244418?needAccess=true&role=button)

Yu, A., Yick, K. L., Ng, S. P., & Yip, J. (2013). 2D and 3D anatomical analyses of hand dimensions for custom-made gloves. *Applied Ergonomics*, 44, 381-392.

Yüksel, N., Börklü, H. R., Sezer, H. K., & Canyurt, O. (2023). Review of artificial intelligence applications in engineering design perspective.

<https://www.semanticscholar.org/paper/cd38b58edf6690459767097aca745a3806824236>

Zhu, Z., & Zhong, R. Y. (2022). A digital twin enabled wearable device for customized healthcare.

Zimmerman, J., Forlizzi, J., & Evenson, S. (2007). Research through design as a method for interaction design research in HCI. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 493-502). ACM. <https://doi.org/10.1145/1240624.1240704>

Zuniga, J., Katsavelis, D., Peck, J., Stollberg, J., Petrykowski, M., Carson, A., & Fernandez, C. (2015). Cyborg beast: A low-cost 3D-printed prosthetic hand for children with upper-limb differences. *BMC Research Notes*, 8, 10. <https://doi.org/10.1186/s13104-015-0971-9>

ANEXO A — METODOLOGIA DE EXTRACÇÃO E CODIFICAÇÃO DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS DA MÃO

A.1 CONTEXTO E OBJECTIVO

O desenvolvimento de um gerador paramétrico de próteses de mão requer dados antropométricos da mão humana que sejam suficientemente variados para cobrir diferentes populações, sexos e grupos etários. O objectivo deste processo foi construir uma base de dados estruturada em formato CSV que servisse de entrada directa ao modelo paramétrico, contendo medições reais retiradas de literatura científica publicada e de relatórios militares de referência.

Foram produzidos três ficheiros CSV complementares:

- data/ansur_1988_complete.csv — 2.726 linhas de dados, 47 dimensões corporais do estudo ANSUR 1988 (Gordon et al., 1989), população militar norte-americana
- data/ansur_1988_hand_arm.csv — 696 linhas de dados, subconjunto do ANSUR restrito às medições da mão, antebraço e braço
- data/multi_population_hand.csv — 1.790 linhas de dados, provenientes de fontes e subconjuntos populacionais de nove países

A.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

A.2.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA ORIENTADA

A pesquisa de literatura foi conduzida através de pesquisas bibliográficas orientadas por questões, complementadas por ferramentas de apoio à revisão e triagem, com o objectivo de identificar estudos de antropometria da mão com dados primários tabelados. As questões-chave incluíam variações de:

"hand anthropometry normative data population study percentiles" "hand dimensions measurement ergonomics working population" "anthropometric survey finger length breadth caliper"

As listas de referências resultantes foram guardadas localmente em pastas organizadas por capítulo da tese. Os ficheiros de trabalho, citações e listas bibliográficas foram cruzados com a coleção local de PDFs para identificar lacunas.

A.2.2 BASE ANSUR 1988

O relatório ANSUR 1988 (Gordon et al., 1989) apresenta 9.068 participantes no levantamento geral. Os ficheiros gerados neste projecto codificam as tabelas estatísticas detalhadas do anexo para os grupos nelas identificados: 2.208 mulheres e 1.774 homens, num total analítico de 3.982 participantes. O total geral do levantamento e os grupos das tabelas codificadas têm âmbitos distintos e não devem ser somados nem usados como se descrevessem a mesma amostra. As tabelas fornecem, para cada dimensão e por sexo, média, desvio-padrão, percentis do P1 ao P99, mínimo e máximo.

A.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE ESTUDOS

Para cada estudo identificado, a decisão de incluir ou excluir os seus dados na base CSV seguiu critérios explícitos.

A.3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Um estudo foi incluído se satisfazia simultaneamente as seguintes condições:

1. Dados primários — o estudo apresenta medições recolhidas pelos seus próprios autores sobre participantes reais, não reutilizando tabelas de terceiros sem transformação.
2. Dimensões da mão ou do membro superior — pelo menos uma medição refere-se à mão, dedos, palma, antebraço ou punho.
3. Estatística descritiva legível — a tabela do artigo fornece, no mínimo, a média. A presença de desvio-padrão e/ou percentis constituía um critério de preferência.
4. Identificação clara da população — o artigo especifica país, sexo, dimensão amostral e método de medição.

A.3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Um estudo foi excluído nas seguintes situações:

- Dados secundários sem valor acrescentado — por exemplo, o trabalho de Moreo (2016) apresenta valores percentílicos de comprimento de dedo extraídos da base de dados DINED (TU Delft, n=965 crianças neerlandesas), sem recolha própria. A Tabela 6.1 desse trabalho serve apenas para validar as escolhas de design do protótipo, não constituindo uma fonte primária codificável de forma independente.
- Artigos de engenharia sem tabelas antropométricas — estudos centrados em materiais, análise de elementos finitos ou fabrico aditivo que referenciam dimensões da mão apenas de forma incidental e sem estatística descritiva.
- Dimensões não da mão em estudos mistos — medições de outras regiões corporais presentes no mesmo artigo foram excluídas se não existia uma razão directa para a prótese de mão (exceção: comprimento cotovelo-ponta dos dedos, incluído por ser relevante para o encaixe do socket).

A.4 PROCESSO DE EXTRACÇÃO DE DADOS

A.4.1 LEITURA DOS PDFS E LOCALIZAÇÃO DAS TABELAS

Cada artigo foi lido integralmente, com foco nas secções de Methods (para identificar o instrumento de medição, a mão medida, e a posição do participante) e Results (para localizar as tabelas com estatística descritiva). A página exata de cada tabela foi registada no campo sourcepage do CSV.

Quando um artigo reportava medições em mais do que uma tabela (por exemplo, comprimentos numa tabela e larguras noutra), cada tabela foi processada separadamente.

A.4.2 IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES E CONVERSÃO

Os artigos consultados reportam medições em milímetros (mm), centímetros (cm) ou, no caso do ANSUR, em polegadas (in). O CSV armazena sempre os três sistemas em simultâneo (valuemm, valuecm, valuein), calculados a partir de uma única unidade-fonte:

- Se o artigo reporta em mm: $\text{valuecm} = \text{valuemm} / 10$; $\text{valuein} = \text{valuecm} / 2.54$
- Se o artigo reporta em cm: $\text{valuemm} = \text{valuecm} \times 10$; $\text{valuein} = \text{valuecm} / 2.54$
- Se o artigo reporta em in: $\text{valuecm} = \text{valuein} \times 2,54$; $\text{valuemm} = \text{valuein} \times 25,4$

Esta redundância elimina conversões em tempo de execução por parte do modelo paramétrico.

A.4.3 DECOMPOSIÇÃO EM LINHAS ATÔMICAS

Cada célula de uma tabela estatística origina uma linha independente no CSV. Assim, para uma dada dimensão, população e sexo, existem tantas linhas quantos os indicadores estatísticos disponíveis: por exemplo, se um artigo reporta média, desvio-padrão, P5, P50 e P95, são criadas cinco linhas — cada uma com o campo `stattype` definido como `mean`, `stddev` ou `percentile`, e o campo `percentile` preenchido apenas nas linhas de tipo `percentile`.

Esta estrutura longa (`long format`) permite filtrar e agregar por qualquer combinação de variáveis sem necessidade de transformação prévia.

A.4.4 REGISTO FIEL DO CONTEXTO DA MEDIÇÃO

O campo `measurementmethodnote` registra, para cada estudo, informações sobre:

- O instrumento utilizado (e.g., "paquímetro digital Vernier 200 mm, resolução 0,01 mm")
- A mão medida (direita/esquerda/dominante)
- A posição da mão durante a medição (estendida e plana, em posição de repouso, sentado)
- O ponto de referência do comprimento (e.g., "da prega palmar proximal à ponta do dedo")

Esta informação é crítica porque estudos diferentes definem as mesmas dimensões com protocolos diferentes: por exemplo, "comprimento da mão" pode ser medido desde a prega do pulso até à ponta do dedo médio (Rodríguez-Vega et al., 2024) ou desde o processo estilóide até à mesma ponta (Anacleto Filho et al., 2023), produzindo valores não diretamente comparáveis.

A.5 DECISÕES POR ESTUDO

A.5.1 ANSUR 1988 — EUA, MILITARES (GORDON ET AL., 1989)

Fonte: tabelas detalhadas do relatório técnico do U.S. Army Natick Research Center (março de 1989), com 47 dimensões corporais codificadas e grupos separados por sexo ($n=2.208$ mulheres; $n=1.774$ homens). O relatório apresenta 9.068 participantes no levantamento geral, enquanto os grupos usados nas tabelas codificadas totalizam 3.982. As dimensões da mão e do membro superior incluem comprimento e largura da mão, comprimentos dos dedos, circunferência do pulso e comprimento do antebraço.

Decisão: inclusão das 47 tabelas legíveis codificadas no script. A dimensão amostral, a amplitude dos indicadores estatísticos e a descrição do levantamento tornam esta fonte uma referência central da base de dados, sem a converter em norma universal para outras populações.

Notas: o código registra oito anomalias do documento de origem. Cinco valores em centímetros foram corrigidos com apoio na coluna em polegadas ou na sequência estatística: página 8, percentil 40 feminino, 74,93 para 71,93 cm; página 37, percentil 1 feminino, 35,55 para 53,55 cm; página 42, percentil 65 masculino, 507,19 para 207,19 cm; página 44, percentil 95 feminino, 1143,33 para 114,33 cm; e página 45, percentil 2 masculino, 35,31 para 25,31 cm. Na página 25, a impressão «59397» na coluna em polegadas foi registada como 59,97 in apenas para apresentação, porque o valor de 152,32 cm já estava correcto. Na página 40, o mínimo feminino de 11,70 cm foi mantido e assinalado como provável erro; na página 46, o desvio-padrão masculino de 0,52 cm foi igualmente mantido e marcado como incerto, pois a coluna em polegadas indica cerca de 3,53 cm. Cada caso fica descrito no campo `dataqualitynote`.

A.5.2 TURQUIA — JOVENS ADULTOS (CHATZIOGLOU ET AL., 2024)

Fonte: *Anatomy & Cell Biology*, 57:172–182. n=51 (32F, 19M), idade 18–30, Izmir e Istanbul. Método foto-antropométrico com ImageJ (pixel → mm via factor de calibração 0,08618 ×). Comprimentos dos cinco dedos da mão direita, por sexo e amostra total, Tabela 1.

Decisão: inclusão. Primeiro estudo de foto-antropometria da mão na base de dados; o método é documentado de forma rigorosa e o artigo foi publicado em revista indexada com revisão por pares. Os valores mínimo e máximo, sem percentis, foram codificados como stattype = min e max.

A.5.3 MÉXICO — POPULAÇÃO GERAL (RODRÍGUEZ-VEGA & RODRÍGUEZ-VEGA, 2024)

Fonte: *European Public & Social Innovation Review*, 9:1–15. n=2.837 (2.275M, 562F), Noroeste do México, idade 15–59. Quatro dimensões: comprimento da mão (HL), comprimento da palma (PL), largura da mão (HB) e diâmetro de preensão (HGD). Tabela 3 (amostra geral) e Tabela 4 (oito grupos etários: 15–19, 20–24, ..., 50–54).

Decisão: inclusão, com marcação de qualidade nos subgrupos de pequena dimensão. A desagregação por grupo etário é única na base de dados e relevante para modelação por faixa etária. Foram detectados dois casos problemáticos na Tabela 4: o subgrupo feminino 50-54 tem n=3 (SD = 0,00 reportado para HB, provavelmente por arredondamento); o subgrupo feminino 45-49 tem n=10. Ambos foram incluídos e marcados no campo dataqualitynote.

A.5.4 ÍNDIA — MULHERES TRABALHADORAS (NAG ET AL., 2003)

Fonte: *Indian Journal of Medical Research*, 117:260–269. n=95 mulheres, trabalhadores informais (indústria de bidis, agarbattis e vestuário), Ahmedabad. 51 dimensões da mão direita em cinco tabelas (comprimentos, larguras, circunferências, profundidades, extensões e folgas), com P5, P50 e P95 reportados.

Decisão: inclusão total. É o estudo com maior detalhe de dimensões da mão na base de dados e o único com dados de profundidade e circunferência por articulação. A restrição a mulheres e a uma população laboral informal específica é documentada na coluna population.

A.5.5 PORTUGAL — TRABALHADORES INDUSTRIAIS (ANACLETO FILHO ET AL., 2023)

Fonte: *International Journal of Industrial Ergonomics*, 97:103473. n=343 (169M, 174F), trabalhadores industriais do Norte de Portugal, 2021. De um conjunto de 27 dimensões corporais, apenas duas são da mão: comprimento da mão e largura da mão (metacarpal II–V). Tabela 3, P5, P50, P95 por sexo.

Decisão: inclusão. Embora sejam disponibilizadas duas dimensões da mão, trata-se da única fonte de dados antropométricos da mão para população portuguesa adulta identificada na literatura, o que justifica a sua inclusão na contextualização nacional da dissertação.

Nota metodológica: O estudo mediu o lado esquerdo por limitação de instalações; este facto é registado em measurementmethodnote.

A.5.6 NIGÉRIA — ATLETAS UNIVERSITÁRIOS (IBIWARI ET AL., 2025)

Fonte: *International Journal of Science Academic Research*, 6(8):10513–10517. n=80: basquetebol (n=41: 21M, 20F) e voleibol (n=39: 20M, 19F), Universidade de Port Harcourt, idade 19–30. Quatro

dimensões da mão direita por desporto e sexo: comprimento da mão, largura da mão, comprimento palmar e comprimento do 3.º dígito. Tabelas 3 e 4.

Decisão: inclusão com marcação de subgrupo desportivo. Dois subgrupos apresentam desvio-padrão atipicamente elevado, como o comprimento da mão no voleibol masculino ($SD = 37,49$ mm), sugerindo a presença de valores atípicos na amostra original. Estes casos foram marcados com nota de qualidade; os valores foram preservados por provirem de tabelas publicadas.

Nota: A população de atletas não é representativa da população geral; os valores refletem uma selecção fisicamente ativa e potencialmente com mãos de dimensões superiores à média.

A.5.7 JORDÂNIA — TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA (MISTARIHI, 2020)

Fonte: Data in Brief, 30:105420. $n=40$ trabalhadores com deficiência física, governorate de Irbid, Jordânia, idade 20–40. Sexos combinados (sem desagregação por sexo em Tabela 4). Comprimento da mão (mm) e comprimento cotovelo-ponta dos dedos (cm) com P5 e P95 na Tabela 4; largura da mão (cm, média apenas) a partir da Figura 2.

Decisão: Inclusão parcial. A dimensão amostral reduzida ($n=40$) e a ausência de desagregação por sexo limitam a utilidade directa dos dados. No entanto, é o único estudo com dados de uma população do Médio Oriente e com uma população com deficiência, o que justifica a inclusão para representatividade demográfica. A largura da mão (apenas média, sem SD, retirada de um diagrama de figura e não de uma tabela) foi incluída com marcação explícita de qualidade.

A.5.8 EUA — DEDO INDICADOR (LIM ET AL., 2018)

Fonte: Trabalho académico UC Berkeley. $n=50$ adultos, idade 18–30. Apenas duas dimensões do dedo indicador (D2): comprimento MCP-ponta (média= $90,9$ mm) e largura na articulação PIP (média= $16,9$ mm). Apenas médias reportadas, sem SD ou percentis.

Decisão: inclusão limitada. A ausência de desvio-padrão e percentis reduz significativamente a utilidade estatística. O estudo foi incluído por se orientar especificamente para a personalização de próteses de dedo e fornecer valores de referência para o design de um dedo indicador protésico, directamente relevantes para o objectivo desta dissertação. O coeficiente de determinação $R^2 = 0,18$ entre comprimento e largura do dedo é registado como indicador de correlação fraca.

A.5.9 ESTUDO EXCLUÍDO: MOREO (2016)

O trabalho de Moreo (2016), dissertação de mestrado sobre design paramétrico de prótese de mão para crianças, foi lido na íntegra (55 páginas). A Tabela 6.1 apresenta valores percentílicos de comprimento de dedo por grupo etário, mas estes valores são extraídos da base de dados DINED (TU Delft, $n=965$ crianças neerlandesas), sem recolha primária por parte da autora. A inclusão duplicaria uma fonte secundária sem ligação directa ao estudo DINED original. Decisão: excluído.

A.5.10 EUA — MILITARES ANSUR II (GORDON ET AL., 2015)

Fonte: Relatório técnico NATICK/TR-15/007, U.S. Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center. $n=6.068$ militares activos (4.082M, 1.986F), idade 17–58, grande diversidade étnica. Os dados brutos individuais foram disponibilizados em acesso público em 2017 (licença CC BY 4.0). As

estatísticas foram calculadas a partir dos CSV individuais, usando Python sem dependências externas, para permitir a regeneração exacta pelo mesmo procedimento.

Decisão: Inclusão total. É o maior conjunto de dados individuais de antropometria da mão disponível publicamente. A disponibilidade de dados brutos individuais (em vez de apenas tabelas sumárias) permitiu calcular o conjunto completo de 11 indicadores por dimensão (média, SD, mínimo, máximo, P5, P10, P25, P50, P75, P90, P95). Sete medições codificadas: comprimento da mão, largura da mão (metacarpal), circunferência da mão, comprimento da palma, circunferência do pulso, comprimento antebraço-ponta do dedo médio e comprimento antebraço-centro de preensão.

Nota: A medição wristheight foi excluída — corresponde à distância do chão ao pulso em posição de pé, uma dimensão postural e não uma medição da mão.

A.5.11 PAÍSES BAIXOS — DINED (TU DELFT, 1993–2004)

Fonte: Base de dados antropométrica do Delft Institute for Ergonomics and Design, acessível via conta institucional em dined.io.tudelft.nl. Três sub-datasets distintos, com dados de mão disponíveis:

- kima1993: crianças neerlandesas, idades 2–12 (grupos por ano), por sexo e combinado; 8 medições da mão por grupo etário.

- geron1998: idosos neerlandeses, idades 50–80+ (bandas de 5 anos), por sexo e combinado; 5 medições da mão.

- dined2004: adultos neerlandeses, grupos etários 20–30, 31–60, 60+, por sexo e combinado; 6–7 medições da mão.

Os dados foram extraídos a partir do HTML da interface web (padrões `id="mean{col}{row}" / id="sd{col}{row}"`), mapeando índices de coluna para combinações (sub-dataset, sexo, grupo etário) e índices de linha para nomes de medição.

Decisão: Inclusão total (três sub-datasets). Apenas média e desvio-padrão estão disponíveis; percentis não são fornecidos pela interface DINED. O grupo combinado 20–60 do dined2004 foi excluído por ser redundante relativamente aos grupos 20–30 e 31–60. Primeiro dataset pediátrico e o dataset de idosos mais granular da base de dados.

A.5.12 CHINA — IDOSOS DE PEQUIM (HU ET AL., 2007)

Fonte: International Journal of Industrial Ergonomics, 37(4):303–311. DOI: 10.1016/j.ergon.2006.11.006. n=108 (58F, 50M), idade 65–85, residentes na área de Pequim, recrutados por conveniência entre reformados. Medições com paquímetro deslizante e paquímetro de pontas, segundo a norma chinesa GB/T 5703-1999 (equivalente à ISO 7250:1996). Tabela 1 (média e desvio-padrão) e Tabela 2 (P1, P5, P50, P95, P99).

Decisão: Inclusão parcial (cinco medições de mão/antebraço: largura da mão no metacarpal, largura máxima da mão, comprimento da mão, comprimento do dedo, comprimento antebraço-ponta dos dedos). P5, P50 e P95 codificados a partir da Tabela 2. A medição "Finger length" usa a designação do padrão GB/T 5703 sem especificar o dígito; assume-se o dedo médio, documentado em dataqualitynote.

Nota de cobertura: Primeira fonte de dados de idosos chineses e, simultaneamente, a única fonte da Ásia Oriental na base de dados (após a verificação de que uma referência alternativa inicialmente identificada não era verificável).

A.5.13 ESTUDO EXCLUÍDO: RECONSTRUÇÃO CORPORAL 3D A PARTIR DE FOTOGRAFIAS ORTOGONAIS

Fonte: artigo metodológico sobre reconstrução de modelos corporais 3D a partir de fotografias ortogonais, publicado no International Journal of Industrial Ergonomics, usando deformação de forma livre (FFD).

Decisão: excluído. O artigo não é um estudo de antropometria populacional: apresenta um método de modelação e valida-o sobre um único sujeito. A figura de validação do artigo compara valores do modelo com valores do participante real para 22 dimensões — não constituindo estatística descritiva de uma amostra. Não há média, desvio-padrão nem percentis de uma população. Incluir o valor de comprimento de mão do sujeito de validação (17 cm, lido do gráfico) seria metodologicamente incorreto.

A.6 ESTRUTURA DO CSV E ESQUEMA DE DADOS

A.6.1 CAMPOS

Campo	Tipo	Descrição
sourcedocument	string	Título abreviado do artigo ou relatório fonte
sourcepage	int	Página da tabela de origem no documento
sourcecitation	string	Citação completa em estilo APA
measurementname	string	Nome da dimensão, incluindo especificações de método quando relevante
bodyregion	string	Região corporal (hand, forearm, upperarm, lowerlimb, torso, head)
measurementmethodnote	string	Instrumento, mão medida, posição e protocolo de medição
population	string	Descrição da população (e.g., "Young adults (age 18-30)")
country	string	País de recolha dos dados
sex	string	male, female ou combined
agegroup	string	Intervalo etário da (sub)amostra
samplesize	int	Número de participantes na

Campo	Tipo	Descrição
		(sub)amostra
statttype	string	Tipo de estatística: mean, stddev, percentile, min, max
percentile	string	Valor do percentil (5, 10, 25, 50, 75, 90, 95) — vazio se não aplicável
valuecm	float	Valor em centímetros
valuemm	float	Valor em milímetros
valuein	float	Valor em polegadas (calculado automaticamente)
dataqualitynote	string	Notas sobre limitações, artefactos ou incertezas do valor

A.6.2 FORMATO LONGO (LONG FORMAT)

A opção pelo formato longo — uma linha por estatística, e não uma linha por dimensão com colunas mean, sd, p5, etc. — permite:

- Filtrar facilmente por tipo de estatística sem tratamento especial de colunas opcionais
- Incluir estudos que reportam apenas subconjuntos de estatísticas (e.g., apenas média, sem percentis) sem introduzir células vazias em colunas estruturais
- Acrescentar novos tipos de estatística, por exemplo intervalos de confiança, sem alterar o esquema de dados

O custo é a repetição dos campos de identificação (país, sexo, dimensão) em cada linha — aceitável dado o volume total de dados (< 5 MB).

A.7 CONTROLO DE QUALIDADE DOS DADOS

A.7.1 MARCAÇÃO INLINE DE LIMITAÇÕES

O campo dataqualitynote é preenchido sempre que existe uma das seguintes situações:

- Valor extraído de uma figura (diagrama ou gráfico) em vez de uma tabela
- Subgrupo com $n \leq 10$
- Desvio-padrão ausente ou atipicamente elevado
- Valor estimado a partir de estatísticas adjacentes por ilegibilidade da tabela
- Correlação fraca entre variáveis reportada pelo próprio estudo
- Inconsistência tipográfica no documento original, corrigida com nota

A.7.2 VERIFICAÇÃO DE UNIDADES

Todos os valores foram verificados pela coerência de ordem de grandeza. Por exemplo, um comprimento de mão adulta reportado em cm deve situar-se entre 15 e 22 cm; qualquer valor fora deste intervalo foi relido no artigo original antes de ser codificado.

A.7.3 LIGAÇÃO À FONTE

Cada linha do CSV contém a citação completa (sourcecitation) e o número de página exato (sourcepage), permitindo que qualquer valor seja verificado diretamente na fonte primária sem necessidade de metadados externos.

A.8 ESCRITA DO CÓDIGO DE GERAÇÃO

Os dados foram codificados em dois scripts Python independentes:

- data/generate_ansur_csv.py — gera data/ansur_1988_complete.csv e data/ansur_1988_hand_arm.csv a partir de dicionários Python incorporados no script, um por tabela do relatório ANSUR

- data/generate_multi_population_hand_csv.py — gera data/multi_population_hand.csv a partir de secções correspondentes às fontes e aos subconjuntos incluídos

A incorporação dos dados no código serve três propósitos: manter cada valor junto da citação e da nota de método; permitir que a execução do script regenere o CSV pelo mesmo procedimento; e tornar as alterações visíveis no histórico de versões com o contexto da fonte modificada.

O script aplica automaticamente as conversões de unidade, calcula valuein a partir de valuecm, e valida que nenhuma linha é emitida sem pelo menos uma das colunas valuemm ou valuecm preenchida.

A.9 RESULTADO FINAL

Ficheiro	Linhas (dados)	Países	Estudos	Dimensões distintas
data/ ansur_1988_compl ete.csv	2.726	1 (EUA)	1	47
data/ ansur_1988_hand_ arm.csv	696	1 (EUA)	1	17
data/ multi_population_ hand.csv	1.790	9	11	cerca de 85

O ficheiro data/multi_population_hand.csv cobre nove países (EUA, Países Baixos, Turquia, México, Índia, Portugal, Nigéria, Jordânia e China), ambos os sexos e grupos combinados, grupos etários desde os 2 até aos 80 ou mais anos, e populações como crianças em idade escolar, idosos, atletas universitários, trabalhadores industriais, trabalhadoras informais e militares.

Na inspecção final da base local app.db, a tabela antropométrica continha 100 perfis agregados: 97 com origem csv_bulk, dois com origem csv e um criado manualmente. Este total representa perfis processados pela aplicação e não linhas dos três CSV; cada perfil pode reunir várias estatísticas e medidas da mesma população.

A.10 COBERTURA GLOBAL DA BASE DE DADOS E LACUNAS

A.10.1 O QUE ESTÁ COBERTO

A base de dados data/multi_population_hand.csv foi construída para reunir diferenças antropométricas da mão em várias dimensões geográficas, demográficas, etárias e estatísticas. A tabela seguinte sintetiza a cobertura actual.

A.10.1.1 Cobertura geográfica

Região	Países representados	Fonte(s)
Europa Ocidental	Portugal, Países Baixos	Anacleto Filho et al. (2023); DINED kima1993, geron1998, dined2004
América do Norte	EUA	ANSUR 1988, ANSUR II 2012, Lim et al. (2018)
América Latina	México	Rodríguez-Vega et al. (2024)
Médio Oriente	Jordânia	Mistarihi (2020)
África	Nigéria	Ibiwari et al. (2025)
Sul da Ásia	Índia	Nag et al. (2003)
Ásia Oriental	China (Pequim)	Hu et al. (2007)
Europa do Sul / Ásia Menor	Turquia	Chatzioglou et al. (2024)

Nove países estão representados, distribuídos por sete regiões do mundo. A cobertura é particularmente densa nos EUA (três fontes independentes) e nos Países Baixos (três sub-datasets DINED).

A.10.1.2 Cobertura etária

Faixa etária	Cobertura	Fonte(s)
2–12 anos	Países Baixos	DINED kima1993 (por ano de idade)
15–19 anos	México	Rodríguez-Vega et al. (2024), subgrupo
18–30 anos	EUA, Turquia	Lim et al. (2018); Chatzioglou et al. (2024)
17–58 anos	EUA	ANSUR II 2012
15–59 anos	México	Rodríguez-Vega et al. (2024), 8 grupos etários
19–30 anos	Nigéria	Ibiwari et al. (2025)
20–40 anos	Jordânia	Mistarihi (2020)
20–60+ anos	Países Baixos	DINED dinet2004 (3 grupos)
50–80+ anos	Países Baixos	DINED geron1998 (7 grupos de 5 anos)

Faixa etária	Cobertura	Fonte(s)
65–85 anos	China	Hu et al. (2007)

A cobertura pediátrica (2–12 anos) existe apenas para os Países Baixos. A adolescência (13–17 anos) está ausente como grupo dedicado — o subgrupo mexicano 15–19 é o mais próximo, mas cobre uma faixa mais alargada. A idade adulta ativa (20–60) está bem coberta em múltiplos países. Os idosos estão representados nos Países Baixos (50–80+) e na China (65–85), mas não noutras geografias.

A.10.1.3 Cobertura estatística

A profundidade estatística varia consideravelmente entre fontes:

Nível de detalhe	Estudos
Média, SD, min, max, P5–P95 (11 indicadores)	ANSUR 1988, ANSUR II 2012
Média e SD (2 indicadores)	DINED (3 subconjuntos)
Média, SD, P5, P50, P95 (5 indicadores)	Hu et al. (2007)
P5, P50, P95 (3 indicadores)	Nag et al. (2003), Anacleto Filho et al. (2023), Rodríguez-Vega et al. (2024)
Média, SD, min, max (4 indicadores)	Chatzioglou et al. (2024), Ibiwari et al. (2025)
Média apenas	Mistarihi (2020) — largura da mão; Lim et al. (2018)

A maioria das fontes não-americanas fornece apenas subconjuntos de estatísticas. Percentis intermédios (P10, P25, P75, P90) estão disponíveis exclusivamente nos datasets ANSUR. Esta assimetria é uma limitação real: para populações não-americanas, o modelo paramétrico pode interpolar entre P5 e P95, mas não dispõe de percentis de granularidade fina.

A.10.2 ONDE A COBERTURA FALHA

A.10.2.1 Lacunas geográficas

As regiões mais populosas do mundo estão sub-representadas ou ausentes:

- Ásia Oriental — China tem uma única fonte (n=108, apenas idosos de Pequim). Japão e Coreia do Sul estão completamente ausentes, apesar de serem países com literatura ergonómica ativa. O conjunto ANSUR é amplamente usado como proxy para populações ocidentais, mas os valores diferem sistematicamente das populações do leste asiático (mãos tendencialmente mais pequenas nos estudos disponíveis).

- Ásia do Sudeste — Nenhum país representado (Indonésia, Filipinas, Vietname, Tailândia, etc.), apesar de concentrarem uma fração significativa da população mundial e de apresentarem diferenças antropométricas documentadas relativamente às populações sul-asiáticas.

- África Subsaariana — Apenas a Nigéria, com uma amostra de atletas universitários (n=80) que não é representativa da população geral. Angola, Moçambique, e outros países de língua portuguesa estão ausentes, o que é particularmente relevante numa tese desenvolvida em Portugal.

- América do Sul — Completamente ausente. Brasil, Colômbia e Argentina têm literatura ergonómica publicada mas não foram identificadas fontes acessíveis com dados de mão codificáveis.

- Europa Central e de Leste — Ausente. Os Países Baixos e Portugal representam a Europa, mas existem diferenças antropométricas documentadas entre populações do norte, sul e leste do continente.

A.10.2.2 Lacunas demográficas

- Adolescentes (13–17 anos) — a transição da mão infantil para a adulta não está coberta por nenhum estudo dedicado. O kima1993 chega aos 12 anos e o ANSUR começa aos 17.

- Amputados — a mão de referência para uma prótese unilateral é a mão contralateral intacta do próprio utilizador. Não foi identificado nenhum estudo com estatística descritiva da mão intacta de utilizadores de próteses. Esta é a lacuna de maior impacto directo para o objectivo desta tese: sem estes dados, a personalização paramétrica baseia-se em populações saudáveis como aproximação.

- Pessoas com deficiência física — apenas o estudo de Mistarihi (2020) cobre esta população (n=40, sexos combinados, Jordânia). A dimensão amostral é insuficiente para ser estatisticamente representativa.

- Idosos fora da Europa e China — a prevalência de amputação de membro superior é mais elevada em contextos de baixo rendimento (causas traumáticas, diabetes, doença vascular), mas os dados de idosos disponíveis limitam-se a populações europeias e chinesas.

A.10.2.3 Limitações qualitativas dos dados existentes

Para além das lacunas por ausência, existem limitações nos dados já presentes:

- Heterogeneidade de protocolos — "comprimento da mão" é medido desde pontos de referência distintos consoante o estudo (prega distal do pulso, processo estilóide do rádio, articulação metacarpo-falângica). Os valores não são diretamente comparáveis entre fontes sem ajuste, o que limita a integração directa para inferência de valores fora da base de dados.

- Amostras de conveniência — a maioria dos estudos não é probabilística: Chatzioglou et al. (2024) recrutou estudantes universitários de Izmir e Istanbul; Ibiwari et al. (2025) recrutou atletas universitários; Hu et al. (2007) recrutou reformados da área de Pequim. A representatividade nacional é, em todos estes casos, questionável.

- Desequilíbrio de dimensões — o comprimento da mão e a largura da mão (metacarpal) estão presentes em quase todas as fontes; comprimentos por falange individual, profundidade da palma, e ângulos de abdução dos dedos estão ausentes exceto no ANSUR.

- Mão medida — a maioria dos estudos mede a mão dominante ou a mão direita; o estudo português mede a mão esquerda por limitação de instalações. Esta inconsistência é registada nos metadados mas não pode ser corrigida post-hoc.

A.10.3 FRENTES IDENTIFICADAS PARA EXPANSÃO FUTURA

A expansão futura da base de dados deverá priorizar três frentes: dados pediátricos e adolescentes fora do contexto europeu, fontes nacionais de antropometria da mão em regiões ainda ausentes, e conjuntos de dados com maior granularidade anatómica dos dedos, falanges, punho e antebraço distal.

A.10.3.1 Prioridade alta

- Dados pediátricos e adolescentes da Ásia Oriental, capazes de preencher a lacuna entre os 13 e os 17 anos e de reduzir a dependência de fontes neerlandesas para perfis infantis.

- Dados industriais ou ergonómicos do Médio Oriente com maior dimensão amostral e separação por sexo, de modo a complementar a fonte jordana já incluída.

- Bases públicas nacionais com dados de mão para populações asiáticas, quando disponibilizarem metadados claros e condições de reutilização compatíveis com investigação académica.

A.10.3.2 Prioridade média

- Relatórios técnicos com medições granulares da mão, incluindo comprimentos por falange, profundidades articulares e ângulos de preensão.

- Estudos baseados em digitalização 3D com amostras adultas amplas, desde que disponibilizem estatísticas por dimensão para além de exemplos individuais.

A.10.3.3 Pertinência directa para o tema da tese

A lacuna de maior impacto continua a ser a ausência de dados de pessoas amputadas, sobretudo medições da mão contralateral intacta. Para o design de próteses de mão personalizadas, a referência mais adequada é a mão intacta do próprio utilizador, e não a média de uma população saudável. Uma recolha primária de dados, mesmo com dimensão reduzida, poderia ser metodologicamente mais valiosa do que acrescentar novas populações saudáveis sem relação clínica directa com o problema da personalização protésica.